PROJETO GABARITANDO

VEM GABARITAR COM A GENTE

APOSTILA

TÉCNICO EM ENFERMAGEM

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Secretaria de Estado da Saúde do Tocantins

Cargo: Técnico em Enfermagem · Apostila completa · 2026

"O crescimento mora no desconforto."

@projeto.gabaritando

SUMÁRIO

Assunto 1 – Fundamentos de Enfermagem: anatomia, fisiologia, semiologia, procedimentos e técnicas

Assunto 2 – Assistência de Enfermagem em Centro Cirúrgico e Central de Material e Esterilização

Assunto 3 – Assistência de Enfermagem em Clínica Médico-Cirúrgica e Unidade de Terapia Intensiva

Assunto 4 – Assistência de Enfermagem em Urgência e Emergência, Suporte Básico de Vida e Atendimento Pré-Hospitalar

Assunto 5 – Assistência de Enfermagem em Saúde Mental

Assunto 6 – Enfermagem Materno-Infantil: pré-natal, parto, puerpério, aleitamento materno e Programa Nacional de Imunizações

Assunto 7 – Programas de Atenção à Saúde da Criança, do Adolescente, da Mulher, do Adulto e da Pessoa Idosa

Assunto 8 – Processo de Enfermagem e atuação do Técnico em Enfermagem na coleta de dados, planejamento, implementação e registros

Assunto 9 – Enfermagem em Saúde Pública: hipertensão, diabetes, doenças cardiovasculares, obesidade, doença renal crônica, hanseníase, tuberculose, dengue e IST

Assunto 10 – Epidemiologia, vigilância, prevenção e controle das IRAS e na comunidade, doenças transmissíveis, de notificação compulsória e imunopreveníveis

Assunto 11 – Política Nacional de Humanização (PNH – HumanizaSUS)

Assunto 12 – Rede de Frio: conservação, armazenamento e manipulação de vacinas

Assunto 13 – Biossegurança: precauções padrão, limpeza e desinfecção, higienização das mãos, EPI e gerenciamento de resíduos

Assunto 14 – Farmacologia aplicada à Enfermagem: princípios básicos, cálculos, diluições e interações medicamentosas

Assunto 15 – Enfermagem aplicada à realização de exames e coleta de materiais biológicos

Assunto 16 – Noções de nutrição e dietética

Assunto 17 – Política Nacional de Segurança do Paciente

Assunto 18 – Comissão de Controle de Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde (CCIRAS)

Assunto 19 – Sistemas de Informação em Saúde

Assunto 20 – Ética no serviço público, sigilo profissional, relações interpessoais e atendimento ao usuário

ASSUNTO 1 – FUNDAMENTOS DE ENFERMAGEM: ANATOMIA, FISIOLOGIA, SEMIOLOGIA, PROCEDIMENTOS E TÉCNICAS

1. RESUMO TEÓRICO

1.1 Anatomia e fisiologia essenciais

O corpo humano é organizado em níveis: células → tecidos → órgãos → sistemas. Para a prova de Técnico em Enfermagem, interessam sobretudo os sistemas ligados aos procedimentos do dia a dia: cardiovascular, respiratório, urinário, digestório, tegumentar e nervoso.

Sistema cardiovascular. O coração tem quatro câmaras: dois átrios e dois ventrículos. O lado direito recebe sangue venoso (pobre em O2) pelas veias cavas e o envia aos pulmões pela artéria pulmonar (pequena circulação). O lado esquerdo recebe sangue arterial pelas veias pulmonares e o distribui ao corpo pela aorta (grande circulação). Atenção: a artéria pulmonar é a única artéria que transporta sangue venoso, e as veias pulmonares são as únicas veias que transportam sangue arterial. Valvas: tricúspide (entre AD e VD), pulmonar, mitral ou bicúspide (entre AE e VE) e aórtica.

Sistema respiratório. Vias aéreas superiores (nariz, faringe, laringe) e inferiores (traqueia, brônquios, bronquíolos, alvéolos). A troca gasosa (hematose) ocorre nos alvéolos. O principal músculo da respiração é o diafragma. O brônquio principal direito é mais curto, mais largo e mais verticalizado, por isso corpos estranhos e a sonda/tubo introduzidos demais tendem a ir para o pulmão direito (intubação seletiva).

Sistema urinário. Rins (formam a urina no néfron), ureteres, bexiga e uretra. A uretra feminina mede cerca de 4 cm e a masculina cerca de 18 a 20 cm, o que explica a maior incidência de infecção urinária em mulheres. Débito urinário normal do adulto: cerca de 0,5 a 1 mL/kg/h; **oligúria** é menos de 400 mL/24h e **anúria** é menos de 100 mL/24h.

Sistema tegumentar. Pele (epiderme, derme) e tela subcutânea (hipoderme). É a referência para as vias de injeção: intradérmica (derme), subcutânea (hipoderme) e intramuscular (músculo).

1.2 Sinais vitais (SSVV)

Sinal vital	Valor de referência no adulto	Alterações
Temperatura axilar	35,8 °C a 37,0 °C	Febrícula 37,1–37,7 °C; febre ≥ 37,8 °C; hipotermia < 35,5 °C
Pulso / frequência cardíaca	60 a 100 bpm	Bradicardia < 60; taquicardia > 100
Frequência respiratória	12 a 20 irpm	Bradipneia < 12; taquipneia > 20; apneia = ausência
Pressão arterial	< 120/80 mmHg (ótima)	Hipertensão ≥ 140/90 mmHg; hipotensão < 90/60 mmHg
Saturação de O2 (SpO2)	95% a 100%	Hipoxemia < 90% (DPOC tolera 88–92%)
Dor	Escala de 0 a 10	Considerada o 5º sinal vital

Valores na criança: o recém-nascido tem FC de 120 a 160 bpm e FR de 30 a 60 irpm. Quanto menor a criança, maiores a FC e a FR e menor a PA.

Terminologia que mais cai: dispneia (dificuldade para respirar), ortopneia (dispneia que melhora sentado), eupneia (respiração normal), Cheyne-Stokes (alternância de apneia e respirações profundas

crescentes e decrescentes), Kussmaul (respiração profunda e rápida, típica da cetoacidose diabética), pulso filiforme (fraco e rápido, típico de choque), afebril, pirexia/hipertermia.

Técnica de verificação da PA. Paciente sentado e em repouso de 3 a 5 minutos, bexiga vazia, braço na altura do coração, manguito 2 a 3 cm acima da fossa cubital, palpar a artéria radial e inflar até 20 a 30 mmHg acima do desaparecimento do pulso, desinsuflar lentamente (2 a 4 mmHg por segundo). O 1º som de Korotkoff corresponde à PA sistólica e o desaparecimento do som (fase V) à diastólica. Manguito pequeno superestima a PA; manguito grande a subestima.

1.3 Semiologia e semiotécnica

Semiologia é o estudo dos sinais e sintomas; **semiotécnica** é a técnica de obtê-los. **Sinal** é objetivo (pode ser observado/medido: febre, edema, cianose). **Sintoma** é subjetivo (relatado pelo paciente: dor, náusea, tontura).

Métodos propedêuticos do exame físico: **inspeção, palpação, percussão e ausculta**. No exame do **abdome** a ordem muda para **inspeção, ausculta, percussão e palpação**, porque palpar antes alteraria os ruídos hidroaéreos.

Termos clássicos: cianose (coloração azulada por hipóxia), icterícia (amarelada, por bilirrubina), palidez, edema (cacifo/Godet positivo quando a pressão deixa depressão), anasarca (edema generalizado), hematoma, equimose, petéquias, diaforese (sudorese intensa), prurido, disfagia (dificuldade para deglutir), disúria (dor ao urinar), poliúria, nictúria, hematúria, melena (fezes escuras com sangue digerido), hematêmese (vômito com sangue), hemoptise (tosse com sangue).

Escala de Coma de Glasgow: avalia abertura ocular (1–4), resposta verbal (1–5) e resposta motora (1–6), com pontuação de 3 a 15; desde 2018 inclui a reatividade pupilar (Glasgow-P, que subtrai 0 a 2 pontos). Glasgow ≤ 8 indica necessidade de via aérea definitiva.

1.4 Posições do paciente

Posição	Descrição	Indicação principal
Decúbito dorsal (supina)	Deitado de costas	Exame físico, repouso
Decúbito ventral (prona)	Deitado de bruços	Exame da coluna, SDRA (prona)
Decúbito lateral / Sims	De lado; Sims com perna de cima flexionada	Lavagem intestinal, exame retal
Fowler	Cabeceira elevada 45° a 60°	Dispneia, alimentação, pós-operatório
Semi-Fowler	Cabeceira 30° a 45°	Prevenção de broncoaspiração, dieta por sonda
Trendelenburg	Cabeça mais baixa que os pés	Cirurgias pélvicas; choque (uso controverso)
Litotômica (ginecológica)	Dorsal com pernas flexionadas e afastadas	Parto, exame ginecológico, sondagem feminina
Genupeitoral	Joelhos e peito apoiados no leito	Exame retal, versão de útero

1.5 Procedimentos e técnicas

Vias de administração parenteral (injetáveis):

Via	Ângulo	Volume máximo usual	Local
Intradérmica (ID)	10° a 15°	0,5 mL (em geral 0,1 mL)	Face anterior do antebraço; BCG na inserção do deltoide direito
Subcutânea (SC)	90° (agulha curta) ou 45°	1,5 mL	Abdome, face posterior do braço, coxa
Intramuscular (IM)	90°	Deltoide 2–3 mL; ventroglútea e dorsoglútea até 4–5 mL; vasto lateral até 4 mL	Ventroglútea (Hochstetter), deltoide, vasto lateral da coxa

		(adulto)	
Endovenosa (EV)	15° a 30°	Sem limite (bolus/infusão)	Veias periféricas do antebraço e dorso da mão

A região **ventroglútea** é considerada a mais segura para IM porque é livre de grandes vasos e nervos. No **vasto lateral** da coxa é a via preferencial em lactentes. A região **dorsoglútea** deve ser aplicada no quadrante superior externo para evitar o nervo ciático, e não é indicada para menores de 2 anos.

Técnica em Z (Z-track): desloca-se a pele lateralmente antes de introduzir a agulha; é usada para medicações irritantes (ex.: ferro), pois impede o refluxo para o tecido subcutâneo.

Os "certos" da administração de medicamentos. Classicamente são 5 (paciente, medicamento, dose, via e hora certos), ampliados para 9 (registro, ação/orientação, forma farmacêutica e monitoramento/resposta certos) e, em alguns protocolos, para 13. O Protocolo de Segurança na Prescrição, Uso e Administração de Medicamentos do Ministério da Saúde trabalha com os **9 certos**.

Sondagens:

- **Sondagem nasogástrica (SNG):** medida da ponta do nariz ao lóbulo da orelha e daí ao apêndice xifoide (NEX). Posição: Fowler. Confirmação: aspiração de conteúdo gástrico, teste do pH e, de forma definitiva, radiografia. A ausculta de ar injetado não é mais considerada método seguro isolado.
- **Sondagem nasoenteral (SNE):** sonda mais fina, com fio-guia; mede-se NEX + 20 a 25 cm. A posição deve ser confirmada por radiografia antes de iniciar a dieta.
- **Sondagem vesical:** de **alívio** (intermitente, retirada logo após o esvaziamento) ou de **demora** (Foley, balonete insuflado com água destilada). Técnica **estéril**. Na mulher, posição ginecológica; no homem, o pênis é posicionado a 90° em relação ao corpo para retificar a uretra. A bolsa coletora fica sempre abaixo do nível da bexiga e nunca no chão.

Curativos. O curativo deve ser realizado do **menos contaminado para o mais contaminado**: na ferida limpa (operatória), de dentro para fora; na ferida infectada, de fora para dentro. Soro fisiológico 0,9% morno é a solução padrão de limpeza. Ferida por **primeira intenção** tem bordas aproximadas (sutura); por **segunda intenção** fica aberta e cicatriza por granulação; por **terceira intenção** é fechada tardiamente.

Lesão por pressão (LPP) – classificação NPIAP: estágio 1 (pele íntegra com eritema que não embranquece), estágio 2 (perda parcial da pele com exposição da derme), estágio 3 (perda total da pele, gordura visível), estágio 4 (exposição de músculo, tendão ou osso), além de **não classificável** (coberta por esfacelo/escara) e **lesão tissular profunda** (área vermelho-escura/púrpura persistente). Prevenção: mudança de decúbito a cada **2 horas**, avaliação de risco pela **escala de Braden** (quanto menor a pontuação, maior o risco; ≤ 18 já indica risco), hidratação da pele e colchão de redistribuição de pressão.

Oxigenoterapia. Cateter nasal tipo óculos: 1 a 6 L/min, com FiO2 de 24% a 44% (cada litro aumenta cerca de 4%). Máscara de Venturi: oferta FiO2 precisa, útil no DPOC. Máscara com reservatório (não reinalante): 10 a 15 L/min, FiO2 de até 90% a 100%. Umidificador com água destilada estéril, trocado conforme protocolo da instituição.

2. PONTOS QUE MAIS CAEM EM PROVA

- Valores dos sinais vitais e a terminologia (bradicardia, taquipneia, febrícula, hipertensão).
- Ordem do exame físico e a exceção do abdome (inspeção, ausculta, percussão, palpação).
- Diferença entre sinal (objetivo) e sintoma (subjetivo).

- Posições: Fowler, semi-Fowler, Sims, Trendelenburg, litotômica.
- Ângulos e volumes das injeções; ventroglútea como região mais segura; vasto lateral em lactentes.
- Medida da SNG (nariz–lóbulo da orelha–apêndice xifoide) e confirmação da posição.
- Sondagem vesical é técnica estéril; bolsa abaixo da bexiga.
- Curativo do menos para o mais contaminado.
- Estágios da lesão por pressão e escala de Braden.
- Os 9 certos da administração de medicamentos.

3. MACETES E DICAS DE MEMORIZAÇÃO

- **"IPPA, mas na barriga é IAPP"**: inspeção, palpação, percussão, ausculta; no abdome a ausculta vem logo após a inspeção.
- **"NEX"**: Nariz, Earlobe (lóbulo da orelha), Xifoide = medida da sonda gástrica.
- **"Sinal se vê, sintoma se diz"**: sinal é objetivo; sintoma é relato.
- **Ângulos "10–45–90"**: ID 10–15°, SC 45° (ou 90° com agulha curta), IM 90°.
- **"Ventroglútea = VIP"**: a área mais segura para IM em adultos e crianças acima de 1 ano.
- **Braden: "nota baixa, risco alto"**.
- **"Do limpo para o sujo"**: regra universal do curativo e da higiene.

4. QUESTÕES

QUESTÃO 01

Durante a admissão de um paciente adulto, o técnico em enfermagem verificou: temperatura axilar de 37,5 °C, frequência cardíaca de 110 bpm e frequência respiratória de 24 irpm. Esses achados são descritos, respectivamente, como:

(A) febre, bradicardia e bradipneia.
(B) febrícula, taquicardia e taquipneia.
(C) hipertermia, taquicardia e eupneia.
(D) afebril, normocardia e taquipneia.
(E) febrícula, taquisfigmia e apneia.

✔️ **GABARITO: B**

Comentário:

A) Incorreta – 37,5 °C é febrícula (37,1 a 37,7 °C); FC de 110 bpm é taquicardia, e não bradicardia; FR de 24 irpm é taquipneia.

B) Correta – febrícula, FC acima de 100 bpm (taquicardia) e FR acima de 20 irpm (taquipneia).

C) Incorreta – hipertermia/febre começa em 37,8 °C, e FR de 24 irpm não é eupneia.

D) Incorreta – 37,5 °C não é afebril e 110 bpm não está na faixa normal (60 a 100 bpm).

E) Incorreta – apneia é a ausência de respiração, o que não ocorre com FR de 24 irpm.

QUESTÃO 02

No exame físico do abdome, a sequência correta dos métodos propedêuticos é:

(A) inspeção, palpação, percussão e ausculta.
(B) palpação, inspeção, ausculta e percussão.
(C) inspeção, ausculta, percussão e palpação.
(D) ausculta, inspeção, palpação e percussão.
(E) percussão, palpação, inspeção e ausculta.

✔️ **GABARITO: C**

Comentário:

A) Incorreta – essa é a ordem geral do exame físico, que não se aplica ao abdome.

B) Incorreta – a inspeção é sempre o primeiro método.

C) Correta – no abdome, ausculta-se antes de percutir e palpar, porque a manipulação altera os ruídos hidroaéreos.

D) Incorreta – a inspeção precede a ausculta.

E) Incorreta – sequência sem fundamento técnico.

QUESTÃO 03

Para a administração de medicamento por via intramuscular em adulto, a região considerada mais segura, por ser livre de grandes vasos e nervos, é a:

(A) dorsoglútea, no quadrante inferior interno.
(B) deltoidiana, para volumes de até 5 mL.
(C) ventroglútea (de Hochstetter).
(D) face anterior do antebraço.
(E) região abdominal periumbilical.

✔️ **GABARITO: C**

Comentário:

A) Incorreta – na dorsoglútea usa-se o quadrante superior externo; o inferior interno coloca em risco o nervo ciático.

B) Incorreta – o deltoide suporta volumes pequenos (até 2 a 3 mL).

C) Correta – a ventroglútea é a região mais segura, com espessa camada muscular e sem grandes vasos e nervos.

D) Incorreta – o antebraço é local da via intradérmica.

E) Incorreta – o abdome é local da via subcutânea (ex.: insulina, heparina).

QUESTÃO 04

Sobre a sondagem vesical de demora, assinale a alternativa correta.

(A) É procedimento limpo, dispensando luvas estéreis.
(B) A bolsa coletora deve ser mantida acima do nível da bexiga para facilitar a drenagem.
(C) O balonete da sonda Foley deve ser insuflado com água destilada, conforme o volume indicado pelo fabricante.
(D) No paciente do sexo masculino, o pênis deve ser mantido paralelo às pernas durante a introdução.
(E) A bolsa coletora pode ser apoiada no chão desde que fechada.

✔️ **GABARITO: C**

Comentário:

A) Incorreta – a sondagem vesical é procedimento estéril (luvas, campo e material estéreis).

B) Incorreta – a bolsa deve ficar abaixo do nível da bexiga para evitar refluxo e infecção.

C) Correta – o balonete é insuflado com água destilada no volume indicado (geralmente 10 mL); soro fisiológico pode cristalizar.

D) Incorreta – o pênis é posicionado a cerca de 90° em relação ao corpo para retificar a uretra.

E) Incorreta – a bolsa nunca deve tocar o chão.

QUESTÃO 05

Paciente acamado apresenta, na região sacral, perda total da espessura da pele, com tecido adiposo visível, sem exposição de músculo, tendão ou osso. Segundo a classificação do NPIAP, trata-se de lesão por pressão:

(A) estágio 1.
(B) estágio 2.
(C) estágio 3.
(D) estágio 4.
(E) tissular profunda.

✔️ **GABARITO: C**

Comentário:

A) Incorreta – o estágio 1 tem pele íntegra com eritema que não embranquece.

B) Incorreta – o estágio 2 é perda parcial da pele, com exposição da derme.

C) Correta – perda total da pele com gordura visível, sem estruturas profundas expostas, caracteriza o estágio 3.

D) Incorreta – o estágio 4 expõe músculo, tendão, cartilagem ou osso.

E) Incorreta – a lesão tissular profunda é área persistente vermelho-escura, marrom ou púrpura, com pele íntegra ou não.

5. REVISÃO DO CAPÍTULO

Resumo em tópicos: sinais vitais e terminologia; sinal × sintoma; IPPA e a exceção do abdome; posições; vias parenterais (ângulos, volumes, locais); SNG, SNE e sondagem vesical; curativos; LPP e Braden; oxigenoterapia.

Quadro-resumo: FC 60–100 bpm; FR 12–20 irpm; T axilar até 37,0 °C, febre a partir de 37,8 °C; PA alterada ≥ 140/90 mmHg; SpO2 ≥ 95%; mudança de decúbito a cada 2 h.

Pegadinhas: aplicar IPPA ao abdome; dizer que sondagem vesical é técnica limpa; achar que a dorsoglútea é a região mais segura; confundir estágio 2 com estágio 3 de LPP.

Erros comuns: classificar 37,5 °C como febre; achar que Braden alto significa risco alto; confirmar SNG apenas por ausculta.

ASSUNTO 2 – ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM EM CENTRO CIRÚRGICO E CENTRAL DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO

1. RESUMO TEÓRICO

2.1 Centro Cirúrgico (CC): estrutura e áreas

O Centro Cirúrgico é unidade de acesso restrito, dividida em três áreas conforme a circulação de pessoas e o risco de contaminação:

Área	Exemplos	Vestimenta
Não restrita	Vestiários (entrada), secretaria, sala de espera	Roupa comum
Semirrestrita	Corredores internos, sala de recuperação pós-anestésica (SRPA), expurgo, conforto	Uniforme privativo, gorro
Restrita	Salas de operação, lavabos, área de guarda de material estéril	Uniforme privativo, gorro e máscara

A RDC ANVISA nº 50/2002 rege a estrutura física dos estabelecimentos de saúde. As salas de operação devem ter temperatura entre **19 °C e 24 °C** e umidade relativa do ar entre **45% e 60%**, com pressão positiva em relação às áreas adjacentes.

2.2 Equipe cirúrgica e funções

- **Cirurgião:** responsável pelo ato cirúrgico.
- **Auxiliar (assistente):** auxilia o cirurgião.
- **Anestesiologista:** avalia, induz e monitora a anestesia.
- **Instrumentador cirúrgico:** prepara a mesa e entrega os instrumentais (paramentado, campo estéril).
- **Circulante de sala (técnico em enfermagem): não se paramenta**; atua fora do campo estéril, abre pacotes estéreis, fornece materiais, auxilia no posicionamento, controla compressas e gazes, faz anotações e mantém a sala organizada.

2.3 Montagem e preparo da sala cirúrgica

Sequência clássica de funções do circulante:

- Verificar o mapa cirúrgico (paciente, procedimento, lado, equipe, materiais especiais).
- Realizar limpeza concorrente (entre cirurgias) com álcool 70% ou desinfetante padronizado nas superfícies; a limpeza terminal é feita ao fim do dia/programação.
- Testar equipamentos: foco, bisturi elétrico (com placa dispersiva), aspirador, carro de anestesia, monitor.
- Dispor os pacotes estéreis conferindo integridade, data de validade e o indicador químico externo.
- Receber o paciente, conferir identificação (pulseira), prontuário, jejum, retirada de próteses e adornos, termo de consentimento e local demarcado.
- Participar da **Lista de Verificação de Cirurgia Segura** (OMS), que tem três momentos:

Momento	Nome	Quando	Principais verificações
1	Entrada (Sign in)	Antes da indução	Identidade, sítio

		anestésica	demarcado, consentimento, alergias, via aérea, risco de sangramento
2	Pausa cirúrgica (Time out)	Antes da incisão da pele	Apresentação da equipe, confirmação de paciente/sítio/procedimento, antibiótico profilático nos últimos 60 min
3	Saída (Sign out)	Antes de o paciente sair da sala	Nome do procedimento, contagem de instrumentais, compressas e agulhas, identificação de peças, problemas com equipamentos

2.4 Posições cirúrgicas

Dorsal (supina) – cirurgias abdominais; ventral (prona) – coluna; lateral – rim, tórax; litotômica (ginecológica) – períneo e parto; Trendelenburg – pelve e abdome inferior; Trendelenburg reverso (proclive) – abdome superior, tireoide; Fowler/sentada – neurocirurgia e ombro. O posicionamento deve proteger proeminências ósseas e evitar lesões de plexo braquial (braço nunca abduzido acima de 90°).

2.5 Paramentação e técnica asséptica

Antissepsia cirúrgica das mãos (escovação): remove a microbiota transitória e reduz a residente. Com antisséptico degermante (clorexidina 2% a 4% ou PVPI 10%), a primeira escovação do dia dura de **3 a 5 minutos** (ou conforme o fabricante). Sentido: das **mãos para os cotovelos** (das unhas e dedos em direção ao cotovelo), mantendo as mãos **acima do nível dos cotovelos**. Unhas curtas, sem adornos. Produtos à base de álcool para fricção cirúrgica também são aceitos.

Sequência de paramentação: uniforme privativo, gorro, máscara, propé (quando indicado) e óculos → escovação → secagem com compressa estéril → avental estéril → luvas estéreis (técnica fechada ou aberta).

Princípios da técnica asséptica: só estéril toca estéril; a parte da frente do avental é estéril da cintura até o tórax e as mangas até 5 cm acima do cotovelo; as costas não são consideradas estéreis; a borda dos campos (2,5 cm) é considerada contaminada; na dúvida, o material é considerado contaminado; não se dá as costas ao campo estéril.

2.6 Sala de Recuperação Pós-Anestésica (SRPA)

Monitoramento contínuo até estabilização. A alta da SRPA usa o **Índice de Aldrete e Kroulik**, que avalia atividade motora, respiração, circulação, consciência e saturação de O2 (cada item vale 0 a 2; total de 0 a 10). Pontuação **≥ 8 a 10** (conforme o serviço) indica condição de alta. Complicações frequentes: hipotermia, náuseas e vômitos, dor, hipoxemia, depressão respiratória e obstrução de vias aéreas por queda da língua.

2.7 Central de Material e Esterilização (CME)

Regulamentada pela **RDC ANVISA nº 15/2012**. É unidade funcional destinada ao processamento de produtos para saúde. Classifica-se em **CME Classe I** (processa produtos de conformação não complexa) e **CME Classe II** (processa também produtos de conformação complexa, como os de lúmen). O fluxo deve ser **unidirecional**, do sujo para o limpo, sem cruzamento:

Área	O que acontece
Recepção e limpeza (expurgo) – área suja	Recebimento, conferência, pré-limpeza, limpeza

	manual/ultrassônica, enxágue
Preparo e acondicionamento – área limpa	Inspeção (lupa), secagem, montagem de caixas, embalagem, identificação
Esterilização	Autoclaves, óxido de etileno, peróxido de hidrogênio
Guarda e distribuição	Armazenamento em local limpo, seco, com controle de temperatura e umidade

O trabalhador do expurgo usa EPI completo: avental impermeável de manga longa, luvas de borracha de cano longo, máscara, óculos/protetor facial, gorro e calçado fechado impermeável.

2.8 Classificação de Spaulding

Classifica os artigos de acordo com o risco de infecção e define o processamento:

Classe	Contato	Exemplos	Processamento mínimo
Críticos	Penetram tecidos estéreis ou sistema vascular	Instrumental cirúrgico, agulhas, cateteres, implantes	Esterilização
Semicríticos	Mucosa íntegra ou pele não íntegra	Equipamentos de terapia respiratória, endoscópios digestivos, lâminas de laringoscópio	Desinfecção de alto nível (ou esterilização)
Não críticos	Pele íntegra	Comadre, estetoscópio, termômetro, esfigmomanômetro	Limpeza e/ou desinfecção de baixo/nível intermediário

2.9 Limpeza, desinfecção e esterilização

Limpeza é a remoção de sujidade (matéria orgânica e inorgânica) e **é a etapa mais importante do processamento**: sem limpeza adequada não há desinfecção nem esterilização eficazes. Usam-se detergente enzimático, escovas e lavadora ultrassônica.

Desinfecção elimina microrganismos na forma vegetativa, **exceto esporos** (a de alto nível pode eliminar alguns esporos). Níveis e exemplos de agentes:

- **Alto nível:** glutaraldeído 2%, ácido peracético, ortoftalaldeído; termodesinfecção.
- **Nível intermediário:** álcool 70%, hipoclorito de sódio, fenólicos (destroem micobactérias como o bacilo da tuberculose).
- **Baixo nível:** quaternário de amônio.

Esterilização destrói **todas** as formas de vida microbiana, **inclusive esporos**.

Método	Agente/condições	Observações
Vapor saturado sob pressão (autoclave)	121 °C por 15–30 min ou 134 °C por 3–10 min	Método de 1ª escolha para termorresistentes; mais seguro, rápido e barato
Calor seco (estufa)	160–170 °C por 1–2 h	**Proibido** pela RDC 15/2012 para produtos de saúde
Óxido de etileno (ETO)	Gás, baixa temperatura	Termossensíveis; exige aeração (tóxico)
Plasma de peróxido de hidrogênio	Baixa temperatura	Termossensíveis; não deixa resíduos tóxicos
Vapor a baixa temperatura e formaldeído (VBTF)	50–78 °C	Termossensíveis
Radiação ionizante (raios gama)	Industrial	Materiais descartáveis

2.10 Monitoramento da esterilização

- **Indicadores físicos:** registros de tempo, temperatura e pressão de cada ciclo.

- **Indicadores químicos:** classes 1 a 6. Classe 1 = fita indicadora externa (apenas indica que o pacote passou pelo processo, não garante esterilidade); classe 2 = **teste Bowie-Dick** (remoção de ar em autoclaves pré-vácuo, feito diariamente, no 1º ciclo, com câmara vazia); classes 4, 5 (integradores) e 6 (emuladores) são internos.
- **Indicadores biológicos:** contêm esporos (*Geobacillus stearothermophilus* para vapor e peróxido de hidrogênio; *Bacillus atrophaeus* para óxido de etileno e calor seco). São os únicos que comprovam a esterilização. Para vapor, uso no mínimo **semanal**, sendo obrigatório em todas as cargas com implantes.

Validade e armazenamento: a validade do material estéril é **relacionada a eventos** (integridade da embalagem, condições de guarda), e não apenas ao tempo. Pacote úmido, rasgado, caído no chão ou com selagem violada deve ser considerado contaminado e reprocessado.

Embalagens: papel grau cirúrgico, tecido de algodão (limite de reutilizações e obrigação de registro), SMS (não tecido), contêineres rígidos. Tyvek é usado para plasma de peróxido de hidrogênio (não usar papel/celulose nesse método).

2. PONTOS QUE MAIS CAEM EM PROVA

- Funções do circulante de sala (não se paramenta).
- Três momentos do checklist de Cirurgia Segura e o que se verifica em cada um.
- Sentido e tempo da escovação; mãos acima dos cotovelos.
- Classificação de Spaulding (crítico, semicrítico, não crítico).
- Diferença entre limpeza, desinfecção e esterilização; limpeza como etapa mais importante.
- Autoclave como método de escolha; estufa proibida pela RDC 15/2012.
- Indicadores físicos, químicos (Bowie-Dick) e biológicos.
- Fluxo unidirecional da CME e EPI do expurgo.
- Índice de Aldrete e Kroulik na SRPA.

3. MACETES E DICAS DE MEMORIZAÇÃO

- **"Crítico corta, semicrítico encosta na mucosa, não crítico só na pele"**.
- **"Espora só morre com esterilização"**: desinfecção não garante destruição de esporos.
- **"ESP": Entrada (antes da anestesia), Saída (antes de sair da sala), Pausa (antes da incisão)** — na ordem: Entrada → Pausa → Saída.
- **"Bowie-Dick bate o ponto todo dia de manhã"**: primeiro ciclo do dia, câmara vazia.
- **"Biológico é a prova dos nove"**: só ele comprova esterilização.
- **"Do sujo para o limpo, nunca volta"**: fluxo da CME.
- **Aldrete: "nota 8 vai para casa (para a enfermaria)"**.

4. QUESTÕES

QUESTÃO 01

Segundo a classificação de Spaulding, os artigos que entram em contato com mucosas íntegras, como os acessórios de terapia respiratória, são classificados como:

(A) críticos, exigindo esterilização obrigatória.
(B) semicríticos, exigindo no mínimo desinfecção de alto nível.
(C) não críticos, exigindo apenas limpeza.
(D) semicríticos, bastando desinfecção de baixo nível.
(E) críticos, bastando desinfecção de nível intermediário.

✔️ **GABARITO: B**

Comentário:

A) Incorreta – críticos são os que penetram tecidos estéreis ou o sistema vascular.

B) Correta – artigos em contato com mucosa íntegra ou pele não íntegra são semicríticos e exigem, no mínimo, desinfecção de alto nível.

C) Incorreta – não críticos entram em contato apenas com pele íntegra.

D) Incorreta – baixo nível é insuficiente para artigos semicríticos.

E) Incorreta – a classificação e o processamento estão errados.

QUESTÃO 02

Na Lista de Verificação de Cirurgia Segura da OMS, a confirmação da identidade do paciente, do sítio cirúrgico e do procedimento por toda a equipe, imediatamente antes da incisão da pele, ocorre na etapa denominada:

(A) Entrada (Sign in).
(B) Pausa cirúrgica (Time out).
(C) Saída (Sign out).
(D) Admissão no centro cirúrgico.
(E) Recuperação pós-anestésica.

✔️ **GABARITO: B**

Comentário:

A) Incorreta – a Entrada ocorre antes da indução anestésica.

B) Correta – a Pausa cirúrgica (Time out) é feita antes da incisão, com toda a equipe.

C) Incorreta – a Saída ocorre antes de o paciente deixar a sala, com contagem de materiais.

D) Incorreta – a admissão não é uma das três etapas do checklist.

E) Incorreta – a SRPA ocorre após a cirurgia.

QUESTÃO 03

Sobre o monitoramento do processo de esterilização a vapor, assinale a alternativa correta.

(A) A fita zebrada externa garante que o conteúdo do pacote está estéril.
(B) O teste Bowie-Dick deve ser feito no primeiro ciclo do dia, com a câmara vazia, em autoclaves com pré-vácuo.
(C) O indicador biológico utiliza esporos de *Bacillus atrophaeus* para monitorar autoclaves a vapor.
(D) Os indicadores físicos substituem os indicadores biológicos.
(E) O indicador biológico deve ser usado apenas uma vez por ano.

✔️ **GABARITO: B**

Comentário:

A) Incorreta – o indicador químico classe 1 apenas diferencia pacotes processados dos não processados.

B) Correta – o Bowie-Dick avalia a remoção do ar e a penetração do vapor, diariamente, no 1º ciclo e com câmara vazia.

C) Incorreta – para vapor usa-se *Geobacillus stearothermophilus*; o *B. atrophaeus* é para óxido de etileno e calor seco.

D) Incorreta – os indicadores se complementam; o biológico é o único que comprova a esterilização.

E) Incorreta – o monitoramento biológico da autoclave é, no mínimo, semanal.

QUESTÃO 04

Durante uma cirurgia, compete ao técnico em enfermagem que atua como circulante de sala:

(A) paramentar-se com avental e luvas estéreis para manusear o instrumental na mesa.
(B) abrir os pacotes estéreis, fornecer materiais à equipe e controlar compressas e gazes utilizadas.
(C) realizar a indução anestésica em situações de urgência.
(D) instrumentar o cirurgião durante o ato operatório.
(E) liberar o paciente da SRPA sem avaliação de escala.

✔️ **GABARITO: B**

Comentário:

A) Incorreta – o circulante não se paramenta; quem manuseia a mesa é o instrumentador.

B) Correta – essas são atribuições típicas do circulante, que atua fora do campo estéril.

C) Incorreta – a indução anestésica é ato do anestesiologista.

D) Incorreta – a instrumentação é feita pelo instrumentador cirúrgico.

E) Incorreta – a alta da SRPA depende de avaliação (Índice de Aldrete e Kroulik) e decisão médica/de enfermagem conforme protocolo.

QUESTÃO 05

De acordo com a RDC ANVISA nº 15/2012 e os princípios de processamento de produtos para saúde, é correto afirmar que:

(A) a estufa (calor seco) é o método de primeira escolha para instrumentais metálicos.
(B) a limpeza pode ser dispensada quando o artigo será esterilizado em autoclave.
(C) o fluxo de materiais na CME deve ser unidirecional, da área suja para a área limpa.
(D) a desinfecção de alto nível equivale à esterilização para artigos críticos.
(E) pacotes que caírem no chão podem ser usados se a embalagem parecer íntegra.

✔️ **GABARITO: C**

Comentário:

A) Incorreta – a RDC 15/2012 proíbe a estufa para esterilização de produtos para saúde; a autoclave é o método de escolha.

B) Incorreta – a limpeza é a etapa mais importante e nunca pode ser dispensada.

C) Correta – o fluxo é unidirecional, evitando o cruzamento entre material sujo e limpo/estéril.

D) Incorreta – artigos críticos exigem esterilização.

E) Incorreta – a validade é relacionada a eventos; queda no chão obriga o reprocessamento.

5. REVISÃO DO CAPÍTULO

Resumo em tópicos: áreas do CC; funções da equipe; montagem da sala; checklist de Cirurgia Segura; posições cirúrgicas; escovação e paramentação; SRPA e Aldrete; CME (RDC 15/2012); Spaulding; limpeza, desinfecção e esterilização; indicadores.

Quadro-resumo: sala de operação 19–24 °C, umidade 45–60%; autoclave 121 °C (15–30 min) ou 134 °C (3–10 min); Bowie-Dick diário; biológico semanal e em toda carga com implante; Aldrete ≥ 8.

Pegadinhas: achar que fita zebrada garante esterilidade; dizer que desinfecção elimina esporos; confundir as etapas do checklist; achar que o circulante se paramenta.

Erros comuns: escovar do cotovelo para as mãos; considerar a estufa permitida; trocar *Geobacillus* (vapor) por *Bacillus atrophaeus* (ETO).

ASSUNTO 3 – ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM EM CLÍNICA MÉDICO-CIRÚRGICA E UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA

1. RESUMO TEÓRICO

3.1 Cuidados perioperatórios na clínica cirúrgica

Pré-operatório imediato (24 h antes): jejum (em geral 8 h para sólidos e 2 h para líquidos claros, conforme protocolo de abreviação do jejum), higiene corporal, tricotomia apenas quando necessária e **o mais próximo possível da cirurgia, com tricotomizador elétrico** (lâmina aumenta o risco de infecção de sítio cirúrgico), retirada de próteses, adornos e esmalte, esvaziamento vesical, sinais vitais, conferência do termo de consentimento, pulseira de identificação e demarcação de lateralidade.

Pós-operatório imediato (primeiras 24 h): controle de sinais vitais, nível de consciência, dor, curativo (sangramento), drenos, diurese, náuseas e vômitos. Estimular **deambulação precoce** e exercícios respiratórios para prevenir trombose venosa profunda (TVP), atelectasia e pneumonia.

Complicações pós-operatórias clássicas: hemorragia e choque (taquicardia, hipotensão, palidez, sudorese fria), **atelectasia** (mais comum nas primeiras 48 h), TVP/embolia pulmonar, retenção urinária, íleo paralítico, infecção de sítio cirúrgico (em geral entre o 3º e o 7º dia) e **deiscência** (abertura da ferida) ou **evisceração** (saída de vísceras – cobrir com compressa estéril úmida em SF 0,9% e comunicar imediatamente).

Drenos: Penrose (laminar, drenagem por capilaridade), tubular, de sucção (Portovac, Hemovac – pressão negativa) e **dreno de tórax em selo d'água**: o frasco fica sempre abaixo do nível do tórax; a extremidade do tubo fica submersa cerca de 2 cm na água; observar **oscilação** da coluna líquida com a respiração (indica sistema pérvio); pinçar o dreno apenas em situações específicas (troca do frasco), nunca durante o transporte de rotina.

3.2 Afecções clínicas mais cobradas

Doença	Fisiopatologia	Sinais e sintomas	Cuidados de enfermagem
Insuficiência cardíaca congestiva	Coração não bombeia o suficiente; congestão pulmonar (IC esquerda) ou sistêmica (IC direita)	Dispneia, ortopneia, dispneia paroxística noturna, edema de membros inferiores, turgência jugular, ganho de peso	Posição Fowler, restrição hídrica e de sódio, **peso diário**, balanço hídrico, controle de diuréticos e digitálicos (verificar pulso apical antes do digitálico)
Infarto agudo do miocárdio	Oclusão coronariana e necrose do músculo cardíaco	Dor torácica em aperto, irradiada para braço esquerdo, mandíbula ou dorso, > 20 min, sudorese, náuseas	Repouso, O2 se SpO2 < 90%, ECG em até 10 min, acesso venoso, monitorização, administração do protocolo (AAS, nitrato etc.)
AVC isquêmico/hemorrágico	Obstrução ou rompimento de vaso cerebral	Desvio de rima, fraqueza em um lado, alteração da fala (SAMU)	Cabeceira 0–30° conforme protocolo, avaliação neurológica, prevenção de broncoaspiração, glicemia, mudança de decúbito

DPOC	Bronquite crônica + enfisema, limitação ao fluxo aéreo	Tosse produtiva, dispneia progressiva, tórax em tonel	O2 em baixo fluxo (1–2 L/min ou Venturi), alvo SpO2 88–92%, respiração com lábios semicerrados
Pneumonia	Infecção do parênquima pulmonar	Febre, tosse produtiva, dor torácica, taquipneia	Hidratação, fisioterapia respiratória, antibiótico no horário, cabeceira elevada
Cirrose hepática	Fibrose do fígado; hipertensão portal	Ascite, icterícia, varizes esofágicas, encefalopatia	Medir circunferência abdominal, peso diário, dieta conforme prescrição, observar sangramentos e confusão mental
Insuficiência renal aguda	Queda súbita da filtração glomerular	Oligúria, edema, hiperpotassemia, ureia elevada	Balanço hídrico rigoroso, peso diário, controle de potássio, cuidados com fístula/cateter de diálise

3.3 Unidade de Terapia Intensiva (UTI)

A UTI atende pacientes graves ou potencialmente graves, com monitorização contínua. Regulamentada pela **RDC ANVISA nº 7/2010**, que exige no mínimo **1 técnico de enfermagem para cada 2 leitos** em cada turno, além de 1 enfermeiro assistencial para cada 8 leitos.

Monitorização: cardioscópio (ECG contínuo), oximetria de pulso, pressão arterial não invasiva (PANI) e invasiva (PAI – via cateter arterial, geralmente radial), pressão venosa central (PVC, valor de referência aproximado de 3 a 8 cmH2O ou 2 a 6 mmHg), capnografia, débito urinário horário.

Ventilação mecânica e cuidados ao paciente intubado (bundle de prevenção da PAV):

- Cabeceira elevada entre **30° e 45°**.
- Higiene oral com clorexidina 0,12% (ou conforme protocolo).
- Manter a pressão do **cuff entre 20 e 30 cmH2O** (ou 18 a 22 mmHg).
- Interrupção diária da sedação e avaliação do desmame (ação médica/multiprofissional).
- Aspiração traqueal com **técnica estéril** em sistema aberto, por no máximo **10 a 15 segundos**, com pré-oxigenação; sistema fechado (trach care) reduz contaminação e perda de PEEP.
- Ordem da aspiração no sistema aberto: **tubo/traqueostomia → nariz → boca** (do mais limpo para o mais contaminado).

Sedação e dor: escala de **RASS** (Richmond, de +4 combativo a –5 não despertável; 0 = alerta e calmo) e escala de Ramsay (1 a 6). Avaliação de dor em paciente não comunicativo: escala BPS (Behavioral Pain Scale).

Cateter venoso central (CVC): curativo com gaze (troca a cada 48 h) ou filme transparente (troca a cada 7 dias), ou antes se úmido, solto ou sujo; desinfecção dos conectores com álcool 70% por 5 a 15 segundos antes de cada acesso (*scrub the hub*).

Choque (hipoperfusão tecidual): hipovolêmico (perda de volume), cardiogênico (falha da bomba), distributivo (séptico, anafilático, neurogênico) e obstrutivo (tamponamento, pneumotórax hipertensivo, TEP). Sinais: hipotensão, taquicardia, pele fria e pegajosa, enchimento capilar > 2 s, oligúria, alteração do nível de consciência.

Sepse: disfunção orgânica ameaçadora à vida causada por resposta desregulada à infecção. Pacote da 1ª hora: coleta de lactato, **hemoculturas antes do antibiótico**, antibiótico de amplo espectro, reposição volêmica (30 mL/kg de cristaloide se hipotensão ou lactato ≥ 4 mmol/L) e vasopressor se hipotensão persistente.

2. PONTOS QUE MAIS CAEM EM PROVA

- Tricotomia: só se necessária, próxima à cirurgia, com tricotomizador elétrico.
- Deambulação precoce para prevenir TVP e complicações respiratórias.
- Evisceração: compressa estéril úmida com SF 0,9% e comunicar.
- Dreno de tórax: frasco abaixo do tórax, oscilação, selo d'água.
- ICC: peso diário, Fowler, restrição hídrica e de sódio; pulso apical antes do digitálico.
- DPOC: O2 em baixo fluxo.
- Bundle de PAV: cabeceira 30–45°, cuff 20–30 cmH2O, higiene oral.
- Aspiração: estéril, máximo 15 s, tubo → nariz → boca.
- RDC 7/2010: 1 técnico para 2 leitos.
- Hemocultura antes do antibiótico na sepse.

3. MACETES E DICAS DE MEMORIZAÇÃO

- **"30-30-15"**: cabeceira a 30° (ou mais), cuff entre 20 e 30, aspiração por até 15 s.
- **"ICC pesa todo dia"**: peso diário é o melhor indicador de retenção hídrica.
- **"DPOC gosta de pouco oxigênio"**: alto fluxo pode deprimir o estímulo respiratório.
- **"Tubo, nariz, boca"**: do mais limpo para o mais sujo na aspiração.
- **"Cultura antes, antibiótico depois"**.
- **"Dreno que oscila está vivo"**: oscilação indica sistema pérvio.

4. QUESTÕES

QUESTÃO 01

Paciente no 5º dia de pós-operatório de laparotomia apresenta, após esforço de tosse, saída de alças intestinais pela incisão. A conduta imediata do técnico em enfermagem é:

(A) recolocar as alças na cavidade abdominal com luvas estéreis.
(B) cobrir as vísceras com compressa estéril umedecida em soro fisiológico 0,9% e comunicar imediatamente a equipe.
(C) aplicar curativo compressivo seco com esparadrapo.
(D) colocar o paciente sentado e estimular a deambulação.
(E) aguardar a visita médica para decidir a conduta.

✔️ **GABARITO: B**

Comentário:

A) Incorreta – a reintrodução das vísceras é ato cirúrgico, nunca realizada pela enfermagem no leito.

B) Correta – a evisceração exige proteção das alças com compressa estéril úmida para evitar ressecamento e contaminação, além de comunicação imediata.

C) Incorreta – curativo seco e compressivo pode lesar as alças.

D) Incorreta – a posição indicada é dorsal com joelhos levemente fletidos, para reduzir a tensão abdominal.

E) Incorreta – é uma emergência cirúrgica; não se aguarda a visita.

QUESTÃO 02

Entre as medidas do pacote (bundle) de prevenção de pneumonia associada à ventilação mecânica, inclui-se:

(A) manter a cabeceira em decúbito zero.
(B) manter a pressão do cuff entre 20 e 30 cmH2O.
(C) trocar o circuito do ventilador diariamente.
(D) realizar aspiração traqueal com técnica limpa.
(E) manter a sedação contínua sem interrupção.

✔️ **GABARITO: B**

Comentário:

A) Incorreta – a cabeceira deve ficar entre 30° e 45°.

B) Correta – a pressão adequada do cuff evita microaspiração de secreções (pressão baixa) e lesão traqueal (pressão alta).

C) Incorreta – o circuito só é trocado se houver sujidade ou mau funcionamento; trocas rotineiras não reduzem PAV.

D) Incorreta – a aspiração em sistema aberto exige técnica estéril.

E) Incorreta – recomenda-se a interrupção diária da sedação.

QUESTÃO 03

Paciente com insuficiência cardíaca congestiva está internado em uso de furosemida e digoxina. Constitui cuidado de enfermagem adequado:

(A) estimular a ingestão hídrica livre.
(B) manter o paciente em decúbito dorsal horizontal.
(C) verificar o peso diariamente, em jejum, na mesma balança.
(D) oferecer dieta rica em sódio para compensar o diurético.
(E) administrar a digoxina mesmo com pulso apical abaixo de 60 bpm.

✔️ **GABARITO: C**

Comentário:

A) Incorreta – na ICC geralmente há restrição hídrica.

B) Incorreta – a posição de Fowler alivia a dispneia.

C) Correta – o peso diário, sempre nas mesmas condições, é o melhor indicador de retenção de líquidos.

D) Incorreta – a dieta é hipossódica.

E) Incorreta – pulso apical abaixo de 60 bpm é sinal de alerta para intoxicação digitálica; a dose deve ser suspensa e o enfermeiro/médico comunicado.

QUESTÃO 04

Sobre a aspiração de secreções em paciente com tubo orotraqueal em sistema aberto, é correto afirmar:

(A) a sonda deve permanecer aspirando por até 1 minuto contínuo.
(B) a sequência correta é boca, nariz e tubo orotraqueal.
(C) a técnica é estéril, com duração máxima de 10 a 15 segundos por aspiração.
(D) a pré-oxigenação é contraindicada.
(E) a mesma sonda pode ser reutilizada em vários horários se guardada em SF.

✔️ **GABARITO: C**

Comentário:

A) Incorreta – a aspiração prolongada causa hipoxemia, bradicardia e lesão da mucosa.

B) Incorreta – a ordem é tubo → nariz → boca.

C) Correta – técnica estéril, aspirando apenas na retirada da sonda, por no máximo 10 a 15 s.

D) Incorreta – a pré-oxigenação é recomendada para evitar hipoxemia.

E) Incorreta – no sistema aberto a sonda é descartável e de uso único.

QUESTÃO 05

Em relação ao paciente com dreno de tórax em selo d'água, assinale a alternativa correta.

(A) O frasco coletor deve ser mantido acima do nível do tórax.

(B) A ausência de oscilação da coluna líquida sempre indica cura.

(C) O dreno deve ser pinçado rotineiramente durante todos os transportes.

(D) A extremidade do tubo deve permanecer submersa na água do frasco, e a oscilação acompanha os movimentos respiratórios.

(E) O frasco pode ser esvaziado sem pinçamento enquanto o paciente tosse.

✔️ **GABARITO: D**

Comentário:

A) Incorreta – o frasco acima do tórax faz o líquido refluir para a cavidade pleural.

B) Incorreta – a falta de oscilação pode indicar obstrução, dobra do tubo ou reexpansão pulmonar; precisa ser avaliada.

C) Incorreta – o pinçamento rotineiro pode causar pneumotórax hipertensivo; mantém-se o frasco abaixo do tórax.

D) Correta – o selo d'água impede a entrada de ar e a oscilação mostra que o sistema está pérvio.

E) Incorreta – a troca do frasco requer pinçamento breve e técnica adequada.

5. REVISÃO DO CAPÍTULO

Resumo em tópicos: pré e pós-operatório; complicações (atelectasia, TVP, deiscência, evisceração); drenos; ICC, IAM, AVC, DPOC, pneumonia, cirrose, IRA; UTI (RDC 7/2010); monitorização; ventilação mecânica e PAV; aspiração; RASS; CVC; choque e sepse.

Quadro-resumo: cabeceira 30–45°; cuff 20–30 cmH2O; aspiração ≤ 15 s; 1 técnico/2 leitos; curativo de CVC: gaze 48 h, filme 7 dias; DPOC: SpO2 88–92%.

Pegadinhas: tricotomia com lâmina na véspera; frasco de dreno acima do tórax; aspiração boca → tubo; alto fluxo de O2 no DPOC.

Erros comuns: achar que evisceração se resolve com curativo seco; esquecer o pulso apical antes do digitálico; iniciar antibiótico antes da hemocultura na sepse.

ASSUNTO 4 – ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, SUPORTE BÁSICO DE VIDA E ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR

1. RESUMO TEÓRICO

4.1 Conceitos e rede de atenção

Urgência é a ocorrência imprevista de agravo à saúde, com ou sem risco potencial de vida, que precisa de assistência rápida. **Emergência** é a condição que implica **risco iminente de vida** ou sofrimento intenso, exigindo tratamento imediato (Resolução CFM nº 1.451/1995).

A Rede de Atenção às Urgências (Portaria GM/MS nº 1.600/2011, consolidada na Portaria de Consolidação nº 3/2017) é composta por: promoção e prevenção, atenção básica, **SAMU 192** e centrais de regulação, sala de estabilização, Força Nacional do SUS, **UPA 24h**, portas hospitalares de urgência, leitos de retaguarda, atenção domiciliar e hospitalar.

Classificação de risco – Protocolo de Manchester:

Cor	Prioridade	Tempo-alvo de atendimento
Vermelho	Emergência	Imediato (0 min)
Laranja	Muito urgente	10 minutos
Amarelo	Urgente	60 minutos
Verde	Pouco urgente	120 minutos
Azul	Não urgente	240 minutos

Atenção: a classificação de risco é atribuição do **enfermeiro** (Resolução COFEN nº 661/2021); o técnico em enfermagem não classifica, mas atua no acolhimento e na verificação de sinais vitais.

4.2 Suporte Básico de Vida (SBV) – Diretrizes AHA

Cadeia de sobrevivência no adulto fora do hospital: reconhecimento e acionamento do serviço de emergência → RCP de alta qualidade imediata → desfibrilação rápida (DEA) → suporte avançado → cuidados pós-PCR → recuperação.

Sequência C-A-B (compressões, via aérea, respiração). Diante de vítima que não responde:

- Verificar a segurança da cena.
- Checar responsividade (tocar os ombros e chamar em voz alta).
- Pedir ajuda, acionar o 192 e solicitar o DEA.
- Checar respiração e pulso carotídeo simultaneamente, em **no máximo 10 segundos**.
- Sem pulso e sem respiração normal (ou só gasping): iniciar RCP.

RCP de alta qualidade no adulto:

- Frequência de **100 a 120 compressões por minuto**.
- Profundidade de **5 a 6 cm**.
- Permitir o **retorno completo do tórax** após cada compressão.
- Minimizar interrupções (fração de compressões > 80%; pausas < 10 s).
- Relação **30 compressões : 2 ventilações** (1 ou 2 socorristas) sem via aérea avançada.

- Com via aérea avançada: compressões contínuas e **1 ventilação a cada 6 segundos** (10 por minuto).
- Revezar o compressor a cada **2 minutos** (ou 5 ciclos).
- Mãos no centro do tórax, na metade inferior do esterno.

Criança e lactente: relação 30:2 com 1 socorrista e **15:2 com 2 socorristas**; profundidade de cerca de 5 cm na criança e 4 cm no lactente (1/3 do diâmetro anteroposterior do tórax); no lactente com 2 socorristas usa-se a técnica dos dois polegares com mãos envolvendo o tórax.

DEA (desfibrilador externo automático): ligar o aparelho → colar as pás (infraclavicular direita e lateral esquerda abaixo da axila) → afastar-se para análise → choque se indicado → retomar RCP imediatamente por 2 minutos. Ritmos chocáveis: **fibrilação ventricular (FV)** e **taquicardia ventricular sem pulso (TVSP)**. Ritmos não chocáveis: **assistolia** e **atividade elétrica sem pulso (AESP)**.

Obstrução de vias aéreas por corpo estranho (OVACE): obstrução leve (tosse eficaz) – estimular a tosse; obstrução grave em adulto e criança consciente – **manobra de Heimlich** (compressões abdominais); em lactente – **5 golpes nas costas + 5 compressões torácicas**; em gestantes e obesos – compressões torácicas. Se a vítima ficar inconsciente, iniciar RCP.

4.3 Atendimento pré-hospitalar (APH) ao trauma

Avaliação primária segundo o **XABCDE** (PHTLS):

Letra	Significado	Ação
X	Hemorragia exsanguinante	Compressão direta, torniquete
A	Vias aéreas + controle da coluna cervical	Elevação do mento/tração da mandíbula, colar cervical
B	Respiração e ventilação	Avaliar FR, expansão torácica, SpO2, oferta de O2
C	Circulação e controle de outras hemorragias	Pulso, perfusão, pele, acesso venoso
D	Disfunção neurológica	Glasgow, pupilas
E	Exposição e controle da hipotermia	Despir para avaliar e aquecer

No trauma, a abertura de via aérea é feita por **tração da mandíbula (jaw thrust)**, sem hiperextensão do pescoço. A manobra de inclinação da cabeça e elevação do queixo é usada quando não há suspeita de trauma cervical.

Queimaduras: 1º grau (epiderme – eritema e dor), 2º grau (epiderme e parte da derme – **flictenas/bolhas**, dor intensa), 3º grau (todas as camadas – pele esbranquiçada ou carbonizada, **indolor** no centro). Extensão pela **regra dos nove** no adulto: cabeça e pescoço 9%, cada membro superior 9%, tronco anterior 18%, tronco posterior 18%, cada membro inferior 18% e períneo 1%. Conduta inicial: interromper o processo, resfriar com **água corrente em temperatura ambiente** (nunca gelo), retirar adornos, não romper bolhas, cobrir com compressa limpa/estéril.

Hemorragias e fraturas: compressão direta é a primeira medida; o torniquete é indicado em hemorragia de membro com risco de vida. Fraturas: imobilizar a articulação acima e abaixo; não tentar realinhar fratura exposta – cobrir com curativo estéril.

4.4 Outras emergências clínicas

- **Hipoglicemia** (glicemia < 70 mg/dL): sudorese fria, tremores, confusão, convulsão. Consciente – oferecer 15 g de carboidrato de absorção rápida; inconsciente – glicose 50% EV conforme prescrição. Nunca dar líquidos pela boca a vítima inconsciente.
- **Crise convulsiva:** proteger a cabeça, afastar objetos, lateralizar após a crise, não introduzir nada na boca, não conter os movimentos, observar duração.
- **Anafilaxia:** adrenalina IM (vasto lateral da coxa) é o tratamento de primeira escolha.

- **AVC:** escala pré-hospitalar de Cincinnati (face, braço, fala) e registro do horário de início dos sintomas (janela de trombólise de até 4,5 h).

2. PONTOS QUE MAIS CAEM EM PROVA

- Diferença entre urgência e emergência.
- Cores e tempos do Protocolo de Manchester; classificação de risco é privativa do enfermeiro.
- Sequência C-A-B; checar pulso por até 10 s.
- RCP: 100–120/min, 5–6 cm, 30:2, retorno do tórax, troca a cada 2 min.
- 15:2 em criança/lactente com 2 socorristas.
- Ritmos chocáveis (FV e TVSP) × não chocáveis (assistolia e AESP).
- OVACE: Heimlich; lactente – 5 golpes nas costas e 5 compressões torácicas.
- XABCDE; tração da mandíbula no trauma.
- Classificação das queimaduras e regra dos nove; resfriar com água corrente.

3. MACETES E DICAS DE MEMORIZAÇÃO

- **"Cem a cento e vinte, cinco a seis"**: frequência e profundidade das compressões.
- **"Chocável é o que treme"**: FV e TV sem pulso; "linha reta não choca" (assistolia).
- **"15 é para os pequenos com dupla"**: 15:2 em criança e lactente com 2 socorristas.
- **"X antes do A"**: hemorragia grave é contida antes da via aérea no trauma.
- **"Regra dos 9"**: cabeça 9, braço 9, frente 18, costas 18, perna 18, períneo 1.
- **"Vermelho já, laranja 10, amarelo 60, verde 120, azul 240"**.

4. QUESTÕES

QUESTÃO 01

Durante a reanimação cardiopulmonar de um adulto, sem via aérea avançada, realizada por dois socorristas, recomenda-se:

(A) 15 compressões para 2 ventilações, com frequência de 80 por minuto.
(B) 30 compressões para 2 ventilações, com frequência de 100 a 120 compressões por minuto e profundidade de 5 a 6 cm.
(C) 30 compressões para 1 ventilação, com profundidade de 3 cm.
(D) compressões contínuas com 1 ventilação a cada 2 segundos.
(E) 5 compressões para 1 ventilação, com frequência de 60 por minuto.

✔️ **GABARITO: B**

Comentário:

A) Incorreta – a relação 15:2 é usada em criança e lactente com 2 socorristas, e a frequência mínima é 100/min.

B) Correta – no adulto a relação é 30:2 com 1 ou 2 socorristas, frequência de 100 a 120/min e profundidade de 5 a 6 cm.

C) Incorreta – a relação e a profundidade estão erradas.

D) Incorreta – compressões contínuas com ventilação a cada 6 segundos ocorrem apenas com via aérea avançada.

E) Incorreta – relação obsoleta e frequência insuficiente.

QUESTÃO 02

São ritmos de parada cardiorrespiratória em que está indicada a desfibrilação:

(A) assistolia e atividade elétrica sem pulso.
(B) fibrilação ventricular e taquicardia ventricular sem pulso.
(C) bradicardia sinusal e assistolia.
(D) fibrilação atrial e flutter atrial.
(E) atividade elétrica sem pulso e fibrilação ventricular.

✔️ **GABARITO: B**

Comentário:

A) Incorreta – assistolia e AESP são ritmos não chocáveis.

B) Correta – FV e TV sem pulso são os ritmos chocáveis.

C) Incorreta – bradicardia sinusal não é ritmo de PCR, e assistolia não é chocável.

D) Incorreta – são arritmias com pulso, tratadas de outra forma (cardioversão eletiva, quando indicada).

E) Incorreta – a AESP não é chocável.

QUESTÃO 03

Lactente de 6 meses, consciente, engasgou-se com um pedaço de alimento e não consegue chorar nem tossir. A conduta indicada é:

(A) realizar a manobra de Heimlich com compressões abdominais.
(B) fazer a varredura digital às cegas da cavidade oral.
(C) aplicar 5 golpes nas costas seguidos de 5 compressões torácicas, repetindo até a desobstrução ou a perda da consciência.
(D) oferecer água para ajudar a deglutir o alimento.
(E) aguardar a tosse espontânea.

✔️ **GABARITO: C**

Comentário:

A) Incorreta – compressões abdominais não são indicadas em lactentes, pelo risco de lesão de órgãos.

B) Incorreta – a varredura às cegas pode empurrar o corpo estranho; só se retira o objeto se estiver visível.

C) Correta – em lactente com obstrução grave alternam-se 5 golpes nas costas e 5 compressões torácicas.

D) Incorreta – oferecer líquidos agrava o risco de aspiração.

E) Incorreta – a ausência de choro e tosse indica obstrução grave, que exige intervenção imediata.

QUESTÃO 04

Na avaliação primária da vítima de trauma pelo método XABCDE, a letra "X" refere-se a:

(A) exame neurológico com escala de Glasgow.
(B) exposição da vítima e prevenção da hipotermia.
(C) controle de hemorragia externa exsanguinante.
(D) avaliação da via aérea com proteção da coluna cervical.
(E) radiografia da coluna cervical.

✔️ **GABARITO: C**

Comentário:

A) Incorreta – a avaliação neurológica corresponde à letra D.

B) Incorreta – exposição e controle da hipotermia correspondem à letra E.

C) Correta – o "X" prioriza o controle da hemorragia exsanguinante, que mata em poucos minutos.

D) Incorreta – via aérea com proteção cervical é a letra A.

E) Incorreta – exames de imagem não fazem parte da avaliação primária no APH.

QUESTÃO 05

Um adulto sofreu queimadura de segundo grau em todo o membro superior direito e em toda a face anterior do tronco. Pela regra dos nove, a superfície corporal queimada é de aproximadamente:

(A) 9%.
(B) 18%.
(C) 27%.
(D) 36%.
(E) 45%.

✔️ **GABARITO: C**

Comentário:

A) Incorreta – 9% corresponde apenas ao membro superior.

B) Incorreta – 18% corresponde apenas ao tronco anterior.

C) Correta – membro superior direito (9%) + tronco anterior (18%) = 27%.

D) Incorreta – 36% seria o tronco inteiro (anterior e posterior).

E) Incorreta – valor superestimado.

5. REVISÃO DO CAPÍTULO

Resumo em tópicos: urgência × emergência; RAU (SAMU, UPA); Manchester; cadeia de sobrevivência; RCP de alta qualidade; DEA e ritmos; OVACE; XABCDE; queimaduras; hemorragias e fraturas; hipoglicemia, convulsão, anafilaxia, AVC.

Quadro-resumo: RCP 100–120/min, 5–6 cm, 30:2 (15:2 em criança com 2 socorristas); pulso em até 10 s; troca do compressor a cada 2 min; ventilação a cada 6 s com via aérea avançada; regra dos nove.

Pegadinhas: chocar assistolia; Heimlich em lactente; hiperextensão do pescoço no trauma; gelo na queimadura; técnico classificando risco.

Erros comuns: profundidade de 3 cm; esquecer o retorno completo do tórax; colocar objeto na boca durante a convulsão.

ASSUNTO 5 – ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM EM SAÚDE MENTAL

1. RESUMO TEÓRICO

5.1 Reforma Psiquiátrica e legislação

A **Lei nº 10.216/2001** (Lei Paulo Delgado) dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas com transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental, substituindo o modelo hospitalocêntrico (manicômios) por uma rede de serviços comunitários. A internação, em qualquer modalidade, **só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes**.

Tipos de internação psiquiátrica (art. 6º):

Tipo	Característica
Voluntária	Com o consentimento do usuário (que assina declaração)
Involuntária	Sem o consentimento do usuário, a pedido de terceiro; deve ser **comunicada ao Ministério Público Estadual em até 72 horas** pelo responsável técnico do estabelecimento
Compulsória	Determinada pela **Justiça**

A internação psiquiátrica somente será realizada mediante **laudo médico circunstanciado** que caracterize seus motivos.

5.2 Rede de Atenção Psicossocial (RAPS)

Instituída pela **Portaria GM/MS nº 3.088/2011**. Componentes: atenção básica (UBS, equipes de Consultório na Rua, centros de convivência), **atenção psicossocial especializada (CAPS)**, atenção de urgência e emergência (SAMU, UPA), atenção residencial de caráter transitório (unidades de acolhimento, comunidades terapêuticas), atenção hospitalar (leitos de saúde mental em hospital geral), estratégias de desinstitucionalização (**Serviços Residenciais Terapêuticos** e **Programa de Volta para Casa**) e reabilitação psicossocial.

Tipo de CAPS	Público / população
CAPS I	Todas as faixas etárias; municípios com mais de 15 mil habitantes
CAPS II	Transtornos mentais graves e persistentes; mais de 70 mil habitantes
CAPS III	Funcionamento **24 horas**, inclusive fins de semana, com acolhimento noturno; mais de 150 mil habitantes
CAPS AD	Álcool e outras drogas; mais de 70 mil habitantes
CAPS AD III	Álcool e drogas, 24 horas; mais de 150 mil habitantes
CAPS i	Crianças e adolescentes; mais de 70 mil habitantes

5.3 Principais transtornos mentais

- **Esquizofrenia:** sintomas positivos (delírios, alucinações – a mais comum é a auditiva –, discurso desorganizado) e negativos (embotamento afetivo, apatia, isolamento social, alogia).

- **Transtorno afetivo bipolar:** alternância entre episódios de mania (euforia, agitação, redução da necessidade de sono, fuga de ideias, grandiosidade) e de depressão.
- **Depressão:** humor deprimido, anedonia (perda de prazer), alterações de sono e apetite, fadiga, sentimento de culpa, ideação suicida.
- **Transtornos de ansiedade:** ansiedade generalizada, pânico (crises súbitas com palpitação, sudorese, sensação de morte iminente), fobias, transtorno obsessivo-compulsivo.
- **Dependência química:** síndrome de abstinência alcoólica – tremores, sudorese, ansiedade; a forma grave é o **delirium tremens** (confusão, alucinações visuais, agitação, febre), em geral 48 a 72 h após a última dose.

Glossário de psicopatologia: **alucinação** (percepção sem objeto real), **ilusão** (percepção deformada de um objeto real), **delírio** (crença falsa inabalável), **despersonalização**, **logorreia** (fala excessiva), **mutismo**, **ecolalia** (repetição da fala do outro), **catatonia**.

5.4 Psicofármacos e cuidados de enfermagem

Classe	Exemplos	Efeitos adversos a observar
Antipsicóticos típicos	Haloperidol, clorpromazina	Sintomas extrapiramidais (tremor, rigidez, acatisia, distonia), síndrome neuroléptica maligna (febre alta, rigidez, instabilidade autonômica)
Antipsicóticos atípicos	Risperidona, olanzapina, quetiapina, clozapina	Ganho de peso, alterações metabólicas; clozapina – **agranulocitose** (hemograma periódico)
Estabilizador do humor	Carbonato de lítio	**Janela terapêutica estreita** (litemia); intoxicação: tremores grosseiros, vômitos, diarreia, confusão; cuidado com desidratação e dieta pobre em sódio
Antidepressivos	Fluoxetina, sertralina (ISRS); amitriptilina (tricíclico)	Efeito terapêutico demora **2 a 4 semanas**; risco de suicídio no início do tratamento; tricíclicos – boca seca, hipotensão postural, retenção urinária
Ansiolíticos (benzodiazepínicos)	Diazepam, clonazepam	Sonolência, dependência, risco de quedas; antídoto: **flumazenil**

5.5 Assistência de enfermagem

- **Comunicação terapêutica:** escuta ativa, aceitação, linguagem clara, perguntas abertas, não reforçar nem confrontar delírios e alucinações (orientar para a realidade sem discutir).
- **Paciente agitado/agressivo:** ambiente calmo, abordagem verbal (desescalada) como primeira medida, manter distância segura e rota de fuga; a **contenção mecânica** é medida de exceção, por prescrição, por tempo limitado, com monitorização frequente (circulação, sinais vitais, hidratação, eliminações) e registro em prontuário (Resolução COFEN nº 427/2012).
- **Risco de suicídio:** levar a sério qualquer manifestação; perguntar diretamente sobre ideação **não aumenta** o risco; retirar objetos perigosos; supervisão constante; notificação compulsória de tentativa (lesão autoprovocada é de notificação imediata – em até 24 h – no município).
- **Projeto Terapêutico Singular (PTS):** plano construído pela equipe com o usuário e a família.

2. PONTOS QUE MAIS CAEM EM PROVA

- Lei 10.216/2001 e os três tipos de internação; comunicação ao MP em 72 h na involuntária.
- RAPS (Portaria 3.088/2011) e tipos de CAPS; CAPS III e AD III funcionam 24 h.
- Diferença entre alucinação, ilusão e delírio.
- Efeitos dos antipsicóticos (extrapiramidais) e do lítio (litemia).
- Antidepressivo leva semanas para agir; vigilância do risco de suicídio.
- Contenção mecânica como último recurso, com monitorização e registro.
- Perguntar sobre suicídio não induz o ato.

3. MACETES E DICAS DE MEMORIZAÇÃO

- **"VIC"**: Voluntária (eu quero), Involuntária (outro pede – MP em 72 h), Compulsória (juiz manda).
- **"CAPS III é o único que não dorme"** (junto com o AD III).
- **"Alucinação não tem objeto; ilusão deforma o objeto; delírio é ideia"**.
- **"Lítio pede sangue"**: controle de litemia.
- **"Clozapina conta leucócitos"**: risco de agranulocitose.
- **"Primeiro conversa, depois contém"**.

4. QUESTÕES

QUESTÃO 01

De acordo com a Lei nº 10.216/2001, a internação psiquiátrica que ocorre sem o consentimento do usuário e a pedido de terceiro denomina-se:

(A) voluntária, devendo ser comunicada ao Conselho Tutelar.
(B) compulsória, determinada pelo médico assistente.
(C) involuntária, devendo ser comunicada ao Ministério Público Estadual no prazo de 72 horas.
(D) involuntária, dispensando qualquer comunicação.
(E) compulsória, comunicada ao COFEN em 24 horas.

✔️ **GABARITO: C**

Comentário:

A) Incorreta – a voluntária ocorre com o consentimento do usuário.

B) Incorreta – a compulsória é determinada pela Justiça.

C) Correta – a internação involuntária deve ser comunicada ao MP Estadual em até 72 horas pelo responsável técnico do estabelecimento.

D) Incorreta – a comunicação ao MP é obrigatória.

E) Incorreta – o órgão e a modalidade estão errados.

QUESTÃO 02

Na Rede de Atenção Psicossocial, o serviço que funciona 24 horas, inclusive nos feriados e fins de semana, com acolhimento noturno, destinado a pessoas com transtornos mentais graves, é o:

(A) CAPS I.
(B) CAPS II.
(C) CAPS III.
(D) CAPS i.
(E) Centro de Convivência.

✔️ **GABARITO: C**

Comentário:

A) Incorreta – o CAPS I funciona em horário comercial.

B) Incorreta – o CAPS II funciona em dois turnos, de segunda a sexta (podendo ter terceiro turno até 21 h).

C) Correta – o CAPS III é o serviço 24 horas para transtornos mentais (o AD III é o correspondente para álcool e drogas).

D) Incorreta – o CAPS i atende crianças e adolescentes, sem funcionamento 24 h obrigatório.

E) Incorreta – o centro de convivência é espaço de sociabilidade da atenção básica, não serviço 24 h.

QUESTÃO 03

Paciente em uso de carbonato de lítio apresenta vômitos, diarreia, tremores grosseiros e confusão mental. O técnico em enfermagem deve suspeitar de:

(A) síndrome de abstinência alcoólica.
(B) intoxicação por lítio, comunicando a equipe para avaliação da litemia.
(C) efeito terapêutico esperado do medicamento.
(D) agranulocitose.
(E) hipoglicemia.

✔️ **GABARITO: B**

Comentário:

A) Incorreta – o quadro é compatível com o uso do lítio, não com abstinência.

B) Correta – o lítio tem janela terapêutica estreita; sintomas gastrintestinais, tremores grosseiros e confusão indicam intoxicação.

C) Incorreta – esses sinais não são efeito esperado.

D) Incorreta – a agranulocitose é associada principalmente à clozapina.

E) Incorreta – não há relação com o quadro descrito.

QUESTÃO 04

Um paciente relata ouvir vozes que o mandam sair do quarto, sem que ninguém esteja falando. Esse fenômeno é chamado de:

(A) ilusão.
(B) delírio.
(C) alucinação auditiva.
(D) ecolalia.
(E) logorreia.

✔️ **GABARITO: C**

Comentário:

A) Incorreta – ilusão é a percepção deformada de um estímulo real.

B) Incorreta – delírio é alteração do pensamento (crença falsa), não da percepção.

C) Correta – perceber vozes sem estímulo real é alucinação auditiva, comum na esquizofrenia.

D) Incorreta – ecolalia é a repetição da fala de outra pessoa.

E) Incorreta – logorreia é a fala excessiva.

QUESTÃO 05

Sobre a assistência ao paciente com risco de suicídio, é correto afirmar:

(A) perguntar diretamente sobre ideação suicida aumenta o risco e deve ser evitado.
(B) quem fala que vai se matar não o faz, apenas quer chamar atenção.
(C) a melhora súbita do humor no início do tratamento antidepressivo elimina o risco.
(D) a supervisão, a retirada de objetos perigosos e a escuta acolhedora fazem parte dos cuidados.
(E) a tentativa de suicídio não é de notificação compulsória.

✔️ **GABARITO: D**

Comentário:

A) Incorreta – perguntar abertamente não induz o ato e ajuda a avaliar o risco.

B) Incorreta – é um mito; toda manifestação deve ser levada a sério.

C) Incorreta – o início do tratamento é período de risco elevado, pois a energia volta antes do humor.

D) Correta – supervisão, ambiente seguro e escuta são cuidados essenciais.

E) Incorreta – a violência autoprovocada, incluindo tentativa de suicídio, é de notificação compulsória imediata.

5. REVISÃO DO CAPÍTULO

Resumo em tópicos: Reforma Psiquiátrica e Lei 10.216/2001; tipos de internação; RAPS e CAPS; transtornos (esquizofrenia, bipolar, depressão, ansiedade, dependência química); psicopatologia; psicofármacos; comunicação terapêutica; contenção; risco de suicídio; PTS.

Quadro-resumo: internação involuntária – MP em 72 h; CAPS III e AD III – 24 h; antidepressivo – efeito em 2 a 4 semanas; lítio – litemia; clozapina – hemograma; flumazenil – antídoto dos benzodiazepínicos.

Pegadinhas: confundir compulsória com involuntária; achar que perguntar sobre suicídio é perigoso; trocar alucinação por ilusão.

Erros comuns: tratar contenção como primeira escolha; discutir com o paciente sobre o conteúdo do delírio.

ASSUNTO 6 – ENFERMAGEM MATERNO-INFANTIL: PRÉ-NATAL, PARTO, PUERPÉRIO, ALEITAMENTO MATERNO E PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÕES

1. RESUMO TEÓRICO

6.1 Assistência pré-natal

O pré-natal deve ser iniciado **até a 12ª semana** de gestação (captação precoce). O Ministério da Saúde preconiza **no mínimo 6 consultas** (a Rede Alyne, que sucedeu a Rede Cegonha em 2024, recomenda 7 ou mais), com calendário: mensais até a 28ª semana, quinzenais da 28ª à 36ª e semanais a partir da 36ª semana até o parto. Não existe "alta do pré-natal".

Cálculos obstétricos:

- **Regra de Naegele (DPP):** data da última menstruação (DUM) + 7 dias e – 3 meses (ou + 9 meses). Ex.: DUM 10/05 → DPP 17/02.
- **Idade gestacional (IG):** soma dos dias desde a DUM dividida por 7.
- **Altura uterina:** útero palpável na sínfise púbica por volta da 12ª semana, na cicatriz umbilical por volta da 20ª semana; entre 18 e 30 semanas, a altura uterina em cm aproxima-se da IG.

Exames do 1º trimestre: tipagem sanguínea e fator Rh, Coombs indireto (se Rh negativo), hemograma, glicemia de jejum, testes rápidos (HIV, sífilis, hepatites B e C), urina tipo I e urocultura, toxoplasmose, ultrassonografia. Testes rápidos de HIV e sífilis repetidos no 3º trimestre e no parto.

Vacinas na gestação: dTpa a partir da **20ª semana** em cada gestação (protege o RN contra coqueluche), **hepatite B** (conforme situação vacinal), **influenza** (em qualquer idade gestacional) e **covid-19**. Vacinas de vírus vivos atenuados (tríplice viral, febre amarela, varicela) são **contraindicadas** na gestação, salvo situações específicas avaliadas (febre amarela em surto).

Suplementação: ácido fólico (idealmente 30 dias antes da concepção até a 12ª semana – previne defeitos do tubo neural) e sulfato ferroso (a partir da 20ª semana até 3 meses pós-parto).

Sinais de alerta: sangramento vaginal, perda de líquido, cefaleia intensa, escotomas visuais, edema súbito de face e mãos, ausência de movimentos fetais, febre, contrações regulares antes de 37 semanas. **Pré-eclâmpsia**: PA ≥ 140/90 mmHg após a 20ª semana com proteinúria ou lesão de órgão-alvo; **eclâmpsia** é a ocorrência de convulsão; o sulfato de magnésio é a droga de escolha (antídoto: **gluconato de cálcio**; observar reflexo patelar, FR e diurese).

6.2 Parto

Períodos clínicos do parto:

Período	Início e fim	Características
1º – Dilatação	Início das contrações regulares até a dilatação total (10 cm)	Fase mais longa; fase ativa a partir de 5 a 6 cm (diretriz MS 2017)
2º – Expulsivo	Dilatação total até a saída do feto	Puxos; ausculta frequente do BCF
3º – Dequitação (secundamento)	Saída do feto até a saída da placenta	Até 30 minutos; ocitocina 10 UI IM logo após o nascimento (manejo ativo)
4º – Greenberg	1ª hora após a saída da placenta	Maior risco de **hemorragia pós-parto**; observar globo de segurança de Pinard (útero

		contraído)

Boas práticas (Diretriz Nacional de Assistência ao Parto Normal): acompanhante de livre escolha durante todo o trabalho de parto, parto e pós-parto (**Lei nº 11.108/2005**), liberdade de posição e movimentação, oferta de líquidos, métodos não farmacológicos de alívio da dor (banho morno, massagem, bola), contato pele a pele imediato, clampeamento oportuno do cordão (1 a 3 minutos no RN vigoroso). Não recomendados como rotina: tricotomia, enema, episiotomia, manobra de Kristeller (proibida), amniotomia de rotina.

Frequência cardíaca fetal (BCF) normal: **110 a 160 bpm**.

6.3 Cuidados imediatos ao recém-nascido

- Contato pele a pele e amamentação **na primeira hora de vida**.
- **Índice de Apgar** no 1º e no 5º minuto: frequência cardíaca, esforço respiratório, tônus muscular, irritabilidade reflexa e cor (0 a 2 cada; 7 a 10 = boa vitalidade).
- **Vitamina K** 1 mg IM (prevenção da doença hemorrágica do RN).
- **Credé/profilaxia ocular** (atualmente com eritromicina, tetraciclina ou iodopovidona) na 1ª hora.
- Vacina de **hepatite B nas primeiras 12 a 24 horas** (preferencialmente nas primeiras 12 h) e **BCG** o mais precoce possível.
- Testes de triagem neonatal: teste do pezinho (entre o **3º e o 5º dia** de vida), do olhinho, da orelhinha, do coraçãozinho (oximetria entre 24 e 48 h) e da linguinha.

6.4 Puerpério

Divide-se em **imediato** (1º ao 10º dia), **tardio** (11º ao 42º dia) e **remoto** (após o 42º dia). Os **lóquios** evoluem de **rubros** (vermelhos, primeiros 3 a 4 dias) para **serosos** (rosados/acastanhados) e **alvos** (esbranquiçados, a partir do 10º dia). A involução uterina é de cerca de 1 cm por dia. Primeira consulta puerperal: **até o 7º–10º dia** (Primeira Semana de Saúde Integral). Sinais de alerta: febre, lóquios fétidos, sangramento aumentado (hemorragia pós-parto – perda ≥ 500 mL no parto vaginal ou ≥ 1.000 mL na cesárea), dor e calor nas mamas, tristeza intensa (depressão pós-parto).

6.5 Aleitamento materno

Recomendação: **aleitamento materno exclusivo até os 6 meses** e complementado até **2 anos ou mais**. Livre demanda, sem horários rígidos. Não oferecer chupetas, mamadeiras nem chás.

Sinais de **pega correta**: boca bem aberta, lábio inferior virado para fora, queixo tocando a mama, mais aréola visível acima da boca do que abaixo, bochechas arredondadas (não encovadas). Sinais de boa posição: corpo do bebê voltado para a mãe, barriga com barriga, cabeça e corpo alinhados, bebê bem apoiado.

O **colostro** (primeiros dias) é rico em proteínas e anticorpos (IgA). O leite do início da mamada é rico em água; o do final, rico em **gordura** (saciedade e ganho de peso) – por isso a criança deve esvaziar uma mama antes de passar à outra.

Contraindicações ao aleitamento: mãe com **HIV** (no Brasil), HTLV 1 e 2, uso de algumas drogas e medicamentos (antineoplásicos), criança com galactosemia. Hepatite B **não** contraindica (RN recebe vacina e imunoglobulina).

6.6 Programa Nacional de Imunizações (PNI)

Criado em **1973**. Calendário básico da criança (Calendário Nacional de Vacinação – principais vacinas):

Idade	Vacinas
Ao nascer	BCG (dose única) e hepatite B

2 meses	Pentavalente (DTP + Hib + hepatite B), VIP (poliomielite inativada), pneumocócica 10-valente, rotavírus
3 meses	Meningocócica C
4 meses	Pentavalente, VIP, pneumocócica 10, rotavírus
5 meses	Meningocócica C
6 meses	Pentavalente, VIP; covid-19 (esquema conforme vigência)
9 meses	Febre amarela
12 meses	Tríplice viral, pneumocócica 10 (reforço), meningocócica C (reforço)
15 meses	DTP (1º reforço), VIP (reforço, substituindo a VOP desde 2024), hepatite A, tetraviral (ou tríplice viral + varicela)
4 anos	DTP (2º reforço), febre amarela (reforço), varicela
9 a 14 anos	HPV (dose única desde 2024), meningocócica ACWY (11 a 14 anos)

Vias de administração: BCG – intradérmica (0,1 mL, inserção inferior do deltoide direito); rotavírus – oral (não repetir se a criança regurgitar); tríplice viral, febre amarela e varicela – subcutânea; pentavalente, VIP, pneumocócica e meningocócica – intramuscular (vasto lateral da coxa em menores de 2 anos).

A **evolução da BCG** é normal: mácula → pápula → pústula → úlcera → crosta → cicatriz, em cerca de 6 a 12 semanas (até 3 meses); não se faz curativo nem se espreme a lesão. Desde 2019, a ausência de cicatriz **não** indica revacinação.

Rotavírus: 1ª dose até 3 meses e 15 dias; 2ª dose até 7 meses e 29 dias.

2. PONTOS QUE MAIS CAEM EM PROVA

- Regra de Naegele e cálculo da IG.
- Calendário e número mínimo de consultas; início até a 12ª semana.
- dTpa a partir da 20ª semana; vacinas de vírus vivo contraindicadas na gestação.
- Períodos do parto e o 4º período (Greenberg) como de maior risco hemorrágico.
- Boas práticas: acompanhante (Lei 11.108/2005), Kristeller proibida, episiotomia não rotineira.
- Apgar, vitamina K, hepatite B nas primeiras 12–24 h, teste do pezinho do 3º ao 5º dia.
- Lóquios rubros → serosos → alvos.
- Aleitamento exclusivo até 6 meses; pega correta; HIV contraindica.
- Calendário vacinal, vias e idades; evolução da BCG; idades-limite do rotavírus.

3. MACETES E DICAS DE MEMORIZAÇÃO

- **Naegele: "mais 7, menos 3"**.
- **"Doze-vinte"**: útero na sínfise com 12 semanas, no umbigo com 20.
- **"Vinte é dTpa"**: a partir da 20ª semana em toda gestação.
- **"Vivo não entra na barriga"**: vacinas atenuadas contraindicadas na gestação.
- **"Dilata, expulsa, dequita, Greenberg"**: os 4 períodos.
- **Lóquios: "RSA – Rubro, Seroso, Alvo"** (vermelho, rosado, branco).
- **"Boca de peixinho"**: lábio inferior virado para fora na pega correta.

- **"BCG no braço direito, intradérmica"**.

4. QUESTÕES

QUESTÃO 01

Gestante informa que a data da sua última menstruação foi 20 de março. Pela regra de Naegele, a data provável do parto será:

(A) 13 de dezembro.
(B) 27 de dezembro.
(C) 20 de dezembro.
(D) 27 de novembro.
(E) 13 de janeiro.

✔️ **GABARITO: B**

Comentário:

A) Incorreta – foram subtraídos 7 dias em vez de somados.

B) Correta – 20 + 7 = 27; março (3) – 3 meses = dezembro (12). DPP: 27 de dezembro.

C) Incorreta – esqueceu-se de somar os 7 dias.

D) Incorreta – foram subtraídos 4 meses.

E) Incorreta – cálculo sem fundamento na regra.

QUESTÃO 02

O período do parto que compreende a primeira hora após a saída da placenta, caracterizado pelo maior risco de hemorragia, é chamado de:

(A) período de dilatação.
(B) período expulsivo.
(C) dequitação.
(D) quarto período ou período de Greenberg.
(E) puerpério remoto.

✔️ **GABARITO: D**

Comentário:

A) Incorreta – a dilatação é o 1º período, até 10 cm.

B) Incorreta – o expulsivo vai da dilatação total ao nascimento.

C) Incorreta – a dequitação é a saída da placenta.

D) Correta – o 4º período (Greenberg) é a 1ª hora pós-dequitação, quando se forma o globo de segurança de Pinard.

E) Incorreta – puerpério remoto começa após o 42º dia.

QUESTÃO 03

Durante a avaliação da mamada, constitui sinal de pega correta:

(A) bochechas encovadas durante a sucção.
(B) lábio inferior voltado para dentro.
(C) boca bem aberta, lábio inferior virado para fora e queixo tocando a mama.
(D) maior parte da aréola visível abaixo da boca do bebê.
(E) ruídos de estalo durante a sucção.

✔️ **GABARITO: C**

Comentário:

A) Incorreta – bochechas encovadas indicam pega inadequada.

B) Incorreta – o lábio inferior deve estar evertido ("boca de peixinho").

C) Correta – são sinais clássicos de pega adequada.

D) Incorreta – deve haver mais aréola visível acima da boca do que abaixo.

E) Incorreta – estalos sugerem que o bebê perde a pega.

QUESTÃO 04

Sobre a vacina BCG, é correto afirmar:

(A) é administrada por via subcutânea no braço esquerdo.
(B) a lesão vacinal deve ser coberta com curativo oclusivo até cicatrizar.
(C) é aplicada por via intradérmica, na inserção inferior do músculo deltoide direito, e a ausência de cicatriz não indica revacinação.
(D) deve ser adiada para os 2 meses de idade junto com a pentavalente.
(E) é contraindicada para todos os recém-nascidos com menos de 3 kg.

✔️ **GABARITO: C**

Comentário:

A) Incorreta – a via é intradérmica e o local é o braço direito.

B) Incorreta – a lesão não deve ser coberta nem manipulada.

C) Correta – via ID, deltoide direito; desde 2019 não se revacina pela ausência de cicatriz.

D) Incorreta – a BCG é dada ao nascer, o mais precocemente possível.

E) Incorreta – adia-se a BCG em RN com peso inferior a 2.000 g.

QUESTÃO 05

Em relação à vacinação da gestante, assinale a alternativa correta.

(A) A tríplice viral deve ser aplicada no 3º trimestre.
(B) A dTpa é indicada a partir da 20ª semana em cada gestação, para proteger o recém-nascido contra a coqueluche.

(C) A vacina influenza é contraindicada na gestação.
(D) A vacina contra hepatite B é proibida durante a gestação.
(E) A dTpa deve ser feita apenas na primeira gestação.

✔️ **GABARITO: B**

Comentário:

A) Incorreta – a tríplice viral é de vírus vivo atenuado, contraindicada na gestação.

B) Correta – a dTpa é feita a partir da 20ª semana em toda gestação, transferindo anticorpos ao feto.

C) Incorreta – a influenza é recomendada em qualquer idade gestacional.

D) Incorreta – a hepatite B é indicada conforme a situação vacinal.

E) Incorreta – deve ser repetida em cada gestação.

5. REVISÃO DO CAPÍTULO

Resumo em tópicos: pré-natal (início, consultas, exames, vacinas, suplementos, sinais de alerta, pré-eclâmpsia); parto (períodos, boas práticas); cuidados ao RN (Apgar, vitamina K, vacinas, triagens); puerpério (lóquios); aleitamento (pega, composição, contraindicações); PNI e calendário.

Quadro-resumo: DPP = DUM + 7 dias – 3 meses; BCF 110–160 bpm; mínimo de 6 consultas; teste do pezinho 3º–5º dia; AME até 6 meses; dTpa a partir de 20 semanas; BCG ID 0,1 mL.

Pegadinhas: aplicar tríplice viral na gestante; aceitar a manobra de Kristeller (proibida); revacinar BCG sem cicatriz; hepatite B contraindicando amamentação.

Erros comuns: confundir dequitação com período de Greenberg; esquecer o limite de idade do rotavírus; achar que o leite do início da mamada é o mais gorduroso.

ASSUNTO 7 – PROGRAMAS DE ATENÇÃO À SAÚDE DA CRIANÇA, DO ADOLESCENTE, DA MULHER, DO ADULTO E DA PESSOA IDOSA

1. RESUMO TEÓRICO

7.1 Saúde da criança

A **Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança (PNAISC)**, instituída pela **Portaria GM/MS nº 1.130/2015**, abrange crianças de 0 a 9 anos e é organizada em **7 eixos estratégicos**: atenção humanizada à gestação, parto, nascimento e RN; aleitamento materno e alimentação complementar saudável; promoção e acompanhamento do crescimento e do desenvolvimento integral; atenção a agravos prevalentes e doenças crônicas; atenção à criança em situação de violência e promoção da cultura de paz; atenção à criança com deficiência ou em situações específicas e de vulnerabilidade; vigilância e prevenção do óbito infantil, fetal e materno.

Caderneta da Criança: instrumento de acompanhamento com gráficos de crescimento (peso, estatura, IMC e perímetro cefálico por idade), marcos do desenvolvimento e registro vacinal.

Calendário mínimo de consultas de puericultura (MS): 1ª semana, 1º mês, 2º, 4º, 6º, 9º, 12º, 18º e 24º meses; depois, anualmente.

Crescimento: o RN pode perder até **10% do peso** nos primeiros dias, recuperando-o até o **10º a 15º dia**. A criança dobra o peso de nascimento por volta dos **4 a 5 meses** e o triplica com **1 ano**.

AIDPI (Atenção Integrada às Doenças Prevalentes na Infância): estratégia para avaliar sinais de perigo (não consegue beber ou mamar, vomita tudo, convulsões, letargia/inconsciência). A desidratação por diarreia é tratada com **Terapia de Reidratação Oral** – Plano A (sem desidratação, tratamento em casa), Plano B (com desidratação, SRO na unidade) e Plano C (desidratação grave, hidratação venosa).

7.2 Saúde do adolescente

Pelo **ECA (Lei nº 8.069/1990)**, adolescente é a pessoa entre **12 e 18 anos** incompletos; para a OMS e o Ministério da Saúde, a adolescência vai dos **10 aos 19 anos**. Temas prioritários: crescimento e desenvolvimento puberal, saúde sexual e reprodutiva, prevenção de gravidez e IST, uso de álcool e drogas, violência e saúde mental. **Caderneta de Saúde do Adolescente** (versões masculina e feminina). O adolescente tem direito a ser atendido **sem a presença dos pais**, com sigilo, salvo situações de risco à vida ou a terceiros. Programa **Saúde na Escola (PSE)** – Decreto nº 6.286/2007.

7.3 Saúde da mulher

Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher (PNAISM, 2004): ações em saúde sexual e reprodutiva, planejamento familiar (Lei nº 9.263/1996), atenção obstétrica, climatério, violência, câncer de colo do útero e de mama.

Rastreamento do câncer do colo do útero: exame citopatológico (Papanicolau) em mulheres de **25 a 64 anos** que já iniciaram atividade sexual; os dois primeiros exames com intervalo **anual** e, se ambos normais, a cada **3 anos**. Desde 2024 o MS incorporou o **teste de DNA-HPV** como método de rastreamento, com intervalo de **5 anos** se negativo, em implantação gradual. Orientações para coleta:

não ter relação sexual nem usar duchas ou cremes vaginais nas 48 h anteriores e não estar menstruada.

Rastreamento do câncer de mama: mamografia bienal para mulheres de **50 a 69 anos** (Diretriz do INCA; desde 2025 o MS ampliou o acesso à mamografia para mulheres de 40 a 49 anos mediante decisão compartilhada, e para 70 a 74 anos). O exame clínico das mamas faz parte da consulta; o autoexame é estimulado como parte do autoconhecimento, não como método de rastreamento.

Métodos contraceptivos: comportamentais (tabelinha, muco cervical), de barreira (preservativo masculino e feminino – únicos que protegem contra IST, diafragma), hormonais (pílula combinada, minipílula, injetável mensal e trimestral, implante), DIU (de cobre e hormonal) e definitivos (laqueadura e vasectomia – Lei 14.443/2022: idade mínima de **21 anos** ou ao menos 2 filhos vivos, **sem necessidade de consentimento do cônjuge**, prazo mínimo de 60 dias entre a manifestação da vontade e o procedimento).

Climatério: transição do período reprodutivo para o não reprodutivo (em geral 40 a 65 anos); **menopausa** é a última menstruação, reconhecida após 12 meses de amenorreia.

7.4 Saúde do adulto e do homem

Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem (PNAISH, Portaria nº 1.944/2009), voltada a homens de **20 a 59 anos**, com cinco eixos: acesso e acolhimento, saúde sexual e reprodutiva, paternidade e cuidado (pré-natal do parceiro), doenças prevalentes na população masculina, prevenção de violências e acidentes. Na saúde do adulto, destacam-se as **doenças crônicas não transmissíveis** (hipertensão, diabetes, câncer, doenças respiratórias crônicas), o tabagismo, o etilismo, a obesidade e o sedentarismo (ver Assunto 9).

7.5 Saúde da pessoa idosa

O **Estatuto da Pessoa Idosa (Lei nº 10.741/2003)** considera idosa a pessoa com **60 anos ou mais**. Garante prioridade no atendimento (prioridade especial aos maiores de **80 anos**), direito a **acompanhante** em internação ou observação, atendimento domiciliar e fornecimento gratuito de medicamentos de uso continuado. A **Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa (Portaria nº 2.528/2006)** tem como foco a manutenção da **capacidade funcional** e da autonomia.

Caderneta de Saúde da Pessoa Idosa e principais síndromes geriátricas ("gigantes da geriatria"): **instabilidade postural e quedas, incontinência urinária, imobilidade, insuficiência cognitiva (demências) e iatrogenia** (inclusive a polifarmácia). Avaliação funcional: atividades básicas de vida diária (escala de **Katz** – banho, vestir, higiene, transferência, continência, alimentação) e instrumentais (escala de **Lawton** – telefone, compras, finanças, medicação).

Prevenção de quedas: iluminação adequada, retirada de tapetes soltos, barras de apoio no banheiro, calçados fechados e antiderrapantes, revisão de medicamentos (sedativos, anti-hipertensivos), atividade física.

Violência contra a pessoa idosa é de notificação compulsória e deve ser comunicada também à autoridade policial, ao Ministério Público ou aos Conselhos da Pessoa Idosa.

2. PONTOS QUE MAIS CAEM EM PROVA

- PNAISC (0 a 9 anos, 7 eixos) e Caderneta da Criança.
- Perda fisiológica de peso do RN (até 10%) e recuperação até o 10º–15º dia.
- Planos A, B e C de reidratação.
- Faixas etárias: adolescente 12–18 (ECA) × 10–19 (OMS/MS); idoso ≥ 60 anos; homem 20–59 anos.

- Papanicolau 25–64 anos, dois anuais e depois trienal; DNA-HPV a cada 5 anos.
- Mamografia bienal de 50 a 69 anos.
- Laqueadura/vasectomia: 21 anos ou 2 filhos, sem consentimento do cônjuge.
- Estatuto da Pessoa Idosa: acompanhante, prioridade especial aos 80+.
- Gigantes da geriatria; escalas de Katz e Lawton.

3. MACETES E DICAS DE MEMORIZAÇÃO

- **"25–64, 1-1-3"**: Papanicolau dos 25 aos 64, dois exames anuais e depois a cada 3 anos.
- **"50–69 de 2 em 2"**: mamografia de rastreamento.
- **"ECA 12, OMS 10"**: início da adolescência.
- **"Os 5 Is da geriatria"**: Instabilidade, Incontinência, Imobilidade, Insuficiência cognitiva, Iatrogenia.
- **"Katz é básico, Lawton é instrumental"**.
- **"Dobra aos 5, triplica com 1 ano"**: peso da criança.

4. QUESTÕES

QUESTÃO 01

Segundo as diretrizes do Ministério da Saúde, o exame citopatológico do colo do útero deve ser oferecido a mulheres:

(A) de 18 a 50 anos, anualmente, independentemente dos resultados.
(B) de 25 a 64 anos que já iniciaram atividade sexual, com os dois primeiros exames anuais e, se normais, a cada três anos.
(C) a partir da menarca, a cada seis meses.
(D) somente após a menopausa.
(E) de 40 a 69 anos, a cada dois anos.

✔️ **GABARITO: B**

Comentário:

A) Incorreta – a faixa etária e a periodicidade estão erradas.

B) Correta – é a recomendação clássica do MS/INCA para o Papanicolau.

C) Incorreta – não se rastreia antes dos 25 anos, nem com intervalo semestral.

D) Incorreta – o rastreamento ocorre principalmente na idade reprodutiva.

E) Incorreta – essa faixa e periodicidade lembram a mamografia, não o citopatológico.

QUESTÃO 02

Para o Estatuto da Pessoa Idosa (Lei nº 10.741/2003), é considerada pessoa idosa aquela com idade igual ou superior a:

(A) 55 anos.
(B) 60 anos.
(C) 65 anos.
(D) 70 anos.
(E) 80 anos.

✔️ **GABARITO: B**

Comentário:

A) Incorreta – 55 anos não é marco legal.

B) Correta – o Estatuto considera idosa a pessoa com 60 anos ou mais.

C) Incorreta – 65 anos é referência usada em alguns benefícios e em países desenvolvidos.

D) Incorreta – não corresponde ao marco legal.

E) Incorreta – 80 anos é o marco para a prioridade especial.

QUESTÃO 03

Criança de 2 anos com diarreia apresenta-se irritada, com olhos fundos, sede intensa e sinal da prega desaparecendo lentamente, sem sinais de gravidade. Segundo o manejo da desidratação, deve-se aplicar o:

(A) Plano A, com tratamento exclusivamente domiciliar.
(B) Plano B, com terapia de reidratação oral na unidade de saúde.
(C) Plano C, com hidratação venosa imediata.
(D) jejum absoluto até cessar a diarreia.
(E) uso de antidiarreicos.

✔️ **GABARITO: B**

Comentário:

A) Incorreta – o Plano A é para crianças sem desidratação.

B) Correta – há sinais de desidratação (irritação, olhos fundos, sede, prega lenta), indicando Plano B na unidade.

C) Incorreta – o Plano C é para desidratação grave (letargia, incapacidade de beber, prega muito lenta).

D) Incorreta – a alimentação deve ser mantida.

E) Incorreta – antidiarreicos não são recomendados em crianças.

QUESTÃO 04

As grandes síndromes geriátricas ("gigantes da geriatria") incluem:

(A) hipertensão, diabetes e obesidade.
(B) instabilidade postural, incontinência, imobilidade, insuficiência cognitiva e iatrogenia.
(C) catarata, glaucoma e surdez.
(D) osteoporose, artrose e gota.
(E) pneumonia, tuberculose e gripe.

✔️ **GABARITO: B**

Comentário:

A) Incorreta – são doenças crônicas, não as síndromes geriátricas clássicas.

B) Correta – são os "5 Is" da geriatria.

C) Incorreta – são alterações sensoriais, sem constituir o grupo clássico.

D) Incorreta – são doenças osteoarticulares.

E) Incorreta – são doenças infecciosas.

QUESTÃO 05

Sobre a esterilização voluntária (laqueadura e vasectomia), conforme a Lei nº 9.263/1996, alterada pela Lei nº 14.443/2022, é correto afirmar:

(A) exige o consentimento expresso do cônjuge.
(B) é permitida a partir dos 25 anos, sem outra condição.
(C) é permitida a pessoas com capacidade civil plena maiores de 21 anos ou com pelo menos dois filhos vivos, sem necessidade de consentimento do cônjuge.
(D) é proibida durante o parto.
(E) pode ser feita no mesmo dia da manifestação da vontade.

✔️ **GABARITO: C**

Comentário:

A) Incorreta – a Lei 14.443/2022 retirou a exigência de consentimento do cônjuge.

B) Incorreta – a idade mínima passou a ser 21 anos (ou 2 filhos vivos).

C) Correta – são os requisitos atuais.

D) Incorreta – a lei passou a permitir a laqueadura durante o parto, observados o prazo e as condições médicas.

E) Incorreta – exige-se prazo mínimo de 60 dias entre a manifestação e o procedimento.

5. REVISÃO DO CAPÍTULO

Resumo em tópicos: PNAISC e puericultura; AIDPI e TRO; adolescente (ECA e MS, PSE); PNAISM, rastreamentos e contracepção; PNAISH; Estatuto e Política da Pessoa Idosa; síndromes geriátricas; prevenção de quedas.

Quadro-resumo: criança 0–9 anos (PNAISC); adolescente 10–19 (MS); homem 20–59; idoso ≥ 60; Papanicolau 25–64; mamografia 50–69 bienal; esterilização ≥ 21 anos ou 2 filhos.

Pegadinhas: exigir consentimento do cônjuge para laqueadura; confundir faixa do ECA com a do MS; usar autoexame como método de rastreamento.

Erros comuns: suspender a alimentação na diarreia; tratar a perda de 10% do peso do RN como doença.

ASSUNTO 8 – PROCESSO DE ENFERMAGEM E ATUAÇÃO DO TÉCNICO EM ENFERMAGEM NA COLETA DE DADOS, PLANEJAMENTO, IMPLEMENTAÇÃO E REGISTROS

1. RESUMO TEÓRICO

8.1 Base legal

A **Lei nº 7.498/1986** (Lei do Exercício Profissional) e o **Decreto nº 94.406/1987** definem as atribuições da equipe. O técnico em enfermagem exerce atividade de nível médio, envolvendo orientação e acompanhamento do trabalho de enfermagem em grau auxiliar e **participação no planejamento** da assistência, executando ações assistenciais, **exceto as privativas do enfermeiro**, sempre sob **supervisão** do enfermeiro.

São **privativos do enfermeiro**: direção e chefia do serviço de enfermagem; consulta de enfermagem; **prescrição da assistência de enfermagem**; cuidados diretos a pacientes graves com risco de vida; cuidados de maior complexidade técnica que exijam conhecimentos científicos e capacidade de tomar decisões imediatas; o **diagnóstico de enfermagem**.

8.2 Processo de Enfermagem (PE) – Resolução COFEN nº 736/2024

A Resolução COFEN nº 736/2024 (que revogou a 358/2009) dispõe sobre a implementação do Processo de Enfermagem em **todo contexto socioambiental** onde ocorre o cuidado de enfermagem. O PE é organizado em **cinco etapas** inter-relacionadas, interdependentes, recorrentes e cíclicas:

Etapa	Descrição	Participação do técnico
1. Avaliação de Enfermagem	Coleta de dados subjetivos e objetivos (anamnese e exame físico)	**Participa** (dados, sinais vitais, observações)
2. Diagnóstico de Enfermagem	Interpretação e julgamento clínico dos dados	**Privativo do enfermeiro**
3. Planejamento de Enfermagem	Priorização dos diagnósticos, resultados esperados e **prescrição** de enfermagem	Participa do planejamento; a prescrição é **privativa do enfermeiro**
4. Implementação de Enfermagem	Execução das intervenções prescritas	**Executa**, sob supervisão
5. Evolução de Enfermagem	Avaliação dos resultados alcançados e revisão do plano	A evolução é do enfermeiro; o técnico faz as **anotações**

Na Resolução 358/2009 (revogada) as etapas eram: coleta de dados (histórico), diagnóstico, planejamento, implementação e avaliação. A **Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE)** organiza o trabalho quanto a método, pessoal e instrumentos, tornando possível a operacionalização do PE.

Taxonomias mais usadas: **NANDA-I** (diagnósticos), **NIC** (intervenções), **NOC** (resultados) e **CIPE** (Classificação Internacional para a Prática de Enfermagem).

8.3 Registros e anotações de enfermagem

A **Resolução COFEN nº 545/2017** trata da **anotação** e do uso do número de inscrição: o profissional deve registrar, após a assinatura, a **categoria profissional abreviada** (Enf., TE ou AE) e o **número**

de inscrição no COREN, ou usar carimbo. A **Resolução COFEN nº 429/2012** dispõe sobre o registro das ações profissionais no prontuário, em meio **tradicional ou eletrônico**.

Anotação × Evolução:

Anotação de enfermagem	Evolução de enfermagem
Feita por toda a equipe (técnico, auxiliar e enfermeiro)	**Privativa do enfermeiro**
Registra dados pontuais e imediatos: o que foi observado e realizado	Análise reflexiva dos dados, com avaliação do estado do paciente nas últimas 24 h
Referente a um momento	Referente ao período, com comparação e planejamento

Características de uma boa anotação: legível, clara, objetiva, cronológica (com **data e hora**), completa, sem rasuras, **sem espaços em branco**, sem abreviaturas não padronizadas, com terminologia técnica, escrita a caneta (preferencialmente azul ou preta conforme a instituição), registrada **imediatamente após** o cuidado e nunca antes, assinada e carimbada. Em caso de erro, não usar corretivo: escrever "**digo**" ou "**em tempo**" e corrigir (ou riscar com um traço simples que mantenha legível o texto original).

Exemplo de anotação: "08h00 – Paciente em leito, consciente, orientado, deambulando sem auxílio. Aceitou dieta oral oferecida. Refere dor em região abdominal, intensidade 6/10. Comunicado enfermeiro. SSVV: PA 130 × 80 mmHg, FC 88 bpm, FR 18 irpm, T 36,5 °C. Diurese espontânea, coloração amarelo-clara. – Maria Silva, TE, COREN-TO 000000."

O prontuário é **documento legal** e de propriedade do paciente (sob guarda da instituição); deve ser mantido por **no mínimo 20 anos** a partir do último registro (Lei nº 13.787/2018 – prontuário digitalizado). O acesso de terceiros depende de autorização do paciente ou ordem judicial.

8.4 Admissão, transferência e alta

- **Admissão:** recepção, identificação (pulseira), orientação sobre a unidade e rotinas, verificação de SSVV, peso e altura, guarda de pertences com relação assinada e registro.
- **Transferência:** comunicação com a unidade de destino, preparo do prontuário, transporte seguro e registro do horário e das condições.
- **Alta:** orientações (medicamentos, retorno, sinais de alerta), devolução de pertences, retirada de dispositivos conforme prescrição e registro das condições de saída.
- **Óbito:** constatação e atestado são atos médicos; a enfermagem realiza o preparo do corpo, identificação, guarda de pertences e registro.

2. PONTOS QUE MAIS CAEM EM PROVA

- Etapas do PE segundo a Resolução COFEN 736/2024.
- Diagnóstico e prescrição de enfermagem são privativos do enfermeiro.
- O técnico participa da coleta de dados, do planejamento e executa a implementação.
- Anotação (toda a equipe) × evolução (enfermeiro).
- Resolução COFEN 545/2017: categoria abreviada + número do COREN.
- Características da anotação: data, hora, sem rasuras, "digo"/"em tempo".
- Prontuário guardado por 20 anos.

3. MACETES E DICAS DE MEMORIZAÇÃO

- **"ADPIE"**: Avaliação, Diagnóstico, Planejamento, Implementação, Evolução (736/2024).
- **"Diagnóstico e prescrição: só com o enfermeiro"**.
- **"Anota quem faz, evolui quem é enfermeiro"**.
- **"Errou? Digo!"**: nunca corretivo nem rasura.
- **"Não anote o que não fez; não faça sem anotar"**.

4. QUESTÕES

QUESTÃO 01

De acordo com a Lei nº 7.498/1986, é atividade privativa do enfermeiro:

(A) a verificação de sinais vitais.
(B) a administração de medicamentos por via oral.
(C) a prescrição da assistência de enfermagem.
(D) a realização de curativos simples.
(E) a anotação dos cuidados prestados no prontuário.

✔️ **GABARITO: C**

Comentário:

A) Incorreta – é ação executada por toda a equipe de enfermagem.

B) Incorreta – a administração de medicamentos prescritos é realizada pelo técnico e pelo auxiliar.

C) Correta – a prescrição da assistência de enfermagem é privativa do enfermeiro.

D) Incorreta – curativos simples são executados pelo técnico e pelo auxiliar.

E) Incorreta – a anotação é dever de todos os profissionais da equipe.

QUESTÃO 02

Segundo a Resolução COFEN nº 736/2024, as cinco etapas do Processo de Enfermagem são:

(A) histórico, diagnóstico médico, prescrição, cuidado e alta.
(B) avaliação de enfermagem, diagnóstico de enfermagem, planejamento de enfermagem, implementação de enfermagem e evolução de enfermagem.
(C) anamnese, exame físico, exames complementares, tratamento e prognóstico.
(D) admissão, transferência, alta, óbito e auditoria.
(E) coleta de dados, prescrição médica, execução, supervisão e anotação.

✔️ **GABARITO: B**

Comentário:

A) Incorreta – o diagnóstico médico não integra o PE.

B) Correta – são as etapas descritas pela Resolução 736/2024.

C) Incorreta – essa é a lógica do raciocínio clínico médico.

D) Incorreta – são momentos da internação, não etapas do PE.

E) Incorreta – a prescrição médica não é etapa do PE.

QUESTÃO 03

Ao perceber que registrou um dado errado na anotação de enfermagem, o técnico deve:

(A) usar corretivo líquido e reescrever.
(B) arrancar a folha e refazer a anotação.
(C) rasurar até tornar o texto ilegível.
(D) utilizar o termo "digo" ou "em tempo" e registrar a informação correta.
(E) deixar como está, pois não é possível corrigir.

✔️ **GABARITO: D**

Comentário:

A) Incorreta – o corretivo é proibido, pois o prontuário é documento legal.

B) Incorreta – retirar folhas do prontuário é infração grave.

C) Incorreta – rasuras comprometem a validade do registro.

D) Correta – "digo" (erro imediato) ou "em tempo" (correção posterior) preservam a legalidade.

E) Incorreta – a correção é possível e necessária.

QUESTÃO 04

Diferencia-se a anotação de enfermagem da evolução de enfermagem porque:

(A) a anotação é privativa do enfermeiro e a evolução é feita por toda a equipe.
(B) a anotação registra dados pontuais e pode ser feita por toda a equipe, enquanto a evolução é análise reflexiva privativa do enfermeiro.
(C) ambas são privativas do técnico em enfermagem.
(D) a evolução é feita somente na alta do paciente.
(E) a anotação dispensa data e horário.

✔️ **GABARITO: B**

Comentário:

A) Incorreta – a relação é inversa.

B) Correta – a anotação descreve o que foi observado/feito; a evolução analisa e é privativa do enfermeiro.

C) Incorreta – a evolução é do enfermeiro.

D) Incorreta – a evolução é diária (ou conforme o período definido), não só na alta.

E) Incorreta – data e horário são obrigatórios.

QUESTÃO 05

De acordo com a Resolução COFEN nº 545/2017, ao assinar uma anotação o profissional de enfermagem deve registrar:

(A) apenas o primeiro nome.

(B) o nome, a categoria profissional abreviada e o número de inscrição no COREN, podendo usar carimbo.
(C) somente o número do CPF.
(D) o nome do enfermeiro supervisor no lugar do próprio.
(E) a rubrica sem qualquer identificação.

✔️ **GABARITO: B**

Comentário:

A) Incorreta – a identificação deve ser completa.

B) Correta – nome, sigla da categoria (Enf., TE, AE) e número de inscrição no COREN.

C) Incorreta – o CPF não substitui a inscrição profissional.

D) Incorreta – cada profissional responde pelos próprios registros.

E) Incorreta – a rubrica isolada não identifica o profissional.

5. REVISÃO DO CAPÍTULO

Resumo em tópicos: Lei 7.498/1986 e Decreto 94.406/1987; atividades privativas do enfermeiro; PE em 5 etapas (Res. 736/2024); SAE e taxonomias; anotação × evolução; Res. 545/2017 e 429/2012; boas práticas de registro; admissão, transferência, alta e óbito.

Quadro-resumo: PE = avaliação → diagnóstico → planejamento → implementação → evolução; técnico participa da avaliação e do planejamento e executa a implementação; prontuário por 20 anos.

Pegadinhas: técnico fazendo diagnóstico ou prescrição de enfermagem; citar a 358/2009 como vigente; anotar antes de realizar o cuidado.

Erros comuns: confundir anotação com evolução; usar corretivo; deixar linhas em branco.

ASSUNTO 9 – ENFERMAGEM EM SAÚDE PÚBLICA: HIPERTENSÃO, DIABETES, DOENÇAS CARDIOVASCULARES, OBESIDADE, DOENÇA RENAL CRÔNICA, HANSENÍASE, TUBERCULOSE, DENGUE E IST

1. RESUMO TEÓRICO

9.1 Hipertensão arterial sistêmica (HAS)

Diagnóstico: PA **≥ 140/90 mmHg** em pelo menos duas ocasiões (Diretriz Brasileira de Hipertensão). É, em geral, **assintomática** ("assassina silenciosa"). Fatores de risco: idade, hereditariedade, excesso de sal, obesidade, sedentarismo, tabagismo, álcool, estresse. Complicações (lesão de órgão-alvo): AVC, infarto, insuficiência cardíaca, doença renal crônica, retinopatia.

Classificação (consultório)	PAS (mmHg)	PAD (mmHg)
PA ótima	< 120	< 80
PA normal	120–129	80–84
Pré-hipertensão	130–139	85–89
HAS estágio 1	140–159	90–99
HAS estágio 2	160–179	100–109
HAS estágio 3	≥ 180	≥ 110

Tratamento não medicamentoso: redução do sal (**< 5 g de sal/dia**, equivalente a 2 g de sódio), dieta DASH (rica em frutas, verduras, laticínios magros), atividade física (150 min/semana), perda de peso, cessação do tabagismo e moderação do álcool. Medicamentos comuns na atenção básica: hidroclorotiazida (diurético – pode causar hipopotassemia), captopril/enalapril (IECA – **tosse seca**), losartana (BRA), anlodipino (bloqueador de canal de cálcio – edema de tornozelos), propranolol/atenolol (betabloqueadores – bradicardia, contraindicados na asma).

9.2 Diabetes mellitus (DM)

Critério diagnóstico	Valor
Glicemia de jejum (8 h)	≥ 126 mg/dL
Glicemia 2 h após sobrecarga de 75 g de glicose (TOTG)	≥ 200 mg/dL
Hemoglobina glicada (HbA1c)	≥ 6,5%
Glicemia ao acaso com sintomas clássicos	≥ 200 mg/dL

Pré-diabetes: glicemia de jejum de 100 a 125 mg/dL ou HbA1c de 5,7% a 6,4%. **DM tipo 1**: destruição autoimune das células beta, início geralmente na infância/adolescência, dependente de insulina, risco de **cetoacidose**. **DM tipo 2**: resistência à insulina, associado a obesidade e idade, mais frequente (cerca de 90% dos casos). **Diabetes gestacional**: diagnosticado na gestação.

Sintomas clássicos: os **4 Ps** – poliúria, polidipsia, polifagia e perda de peso.

Insulinas: regular (ação rápida – aspecto **transparente**, pode ser EV) e NPH (ação intermediária – aspecto **leitoso/turvo**). Na mistura na mesma seringa, aspira-se **primeiro a regular (transparente) e depois a NPH (turva)**. A NPH deve ser homogeneizada rolando-se o frasco entre as mãos, sem agitar. Aplicação subcutânea com **rodízio** dos locais (abdome – absorção mais rápida –, braços,

coxas, nádegas) para prevenir lipodistrofia. Frasco em uso pode ficar em temperatura ambiente (até 30 °C) por cerca de 4 semanas; frascos lacrados são guardados na geladeira (2 °C a 8 °C), nunca no congelador nem na porta.

Pé diabético: examinar os pés diariamente, secar bem entre os dedos, hidratar (exceto entre os dedos), cortar as unhas retas, usar calçados fechados e confortáveis, nunca andar descalço, avaliar a sensibilidade com o **monofilamento de 10 g**.

Hipoglicemia (< 70 mg/dL): tremor, sudorese fria, palpitação, confusão – **regra dos 15**: 15 g de carboidrato de absorção rápida e nova glicemia em 15 minutos.

9.3 Doenças cardiovasculares, obesidade e doença renal crônica

Doenças cardiovasculares (infarto, AVC, insuficiência cardíaca) são a principal causa de morte no Brasil. A prevenção atua nos fatores de risco modificáveis: HAS, DM, dislipidemia, tabagismo, obesidade e sedentarismo.

Obesidade: IMC = peso (kg) ÷ altura² (m). Classificação do adulto: < 18,5 baixo peso; 18,5–24,9 eutrofia; 25–29,9 sobrepeso; 30–34,9 obesidade grau I; 35–39,9 grau II; ≥ 40 grau III. Circunferência abdominal aumentada (risco cardiovascular): > 94 cm em homens e > 80 cm em mulheres (risco muito elevado > 102 e > 88 cm).

Doença renal crônica (DRC): lesão renal ou taxa de filtração glomerular < 60 mL/min/1,73 m² por **mais de 3 meses**. Principais causas: **HAS e DM**. Tratamento substitutivo: hemodiálise, diálise peritoneal e transplante. Cuidados com a **fístula arteriovenosa**: não verificar PA, não puncionar, não coletar sangue nem apertar o braço da fístula; palpar o frêmito diariamente. Restrições: líquidos, sódio, potássio e fósforo, conforme orientação.

9.4 Hanseníase

Causada pelo *Mycobacterium leprae* (bacilo de Hansen), transmitida por **vias aéreas superiores** de pessoa com forma multibacilar não tratada, por contato próximo e prolongado. Período de incubação longo (2 a 7 anos). Caso de hanseníase: lesão de pele com **alteração de sensibilidade** (térmica, dolorosa ou tátil), espessamento de nervo periférico com alteração sensitiva/motora, ou baciloscopia positiva.

Classificação operacional	Critério	Tratamento (PQT-U)
Paucibacilar (PB)	Até 5 lesões de pele	Rifampicina + dapsona + clofazimina por **6 meses** (6 doses)
Multibacilar (MB)	Mais de 5 lesões ou baciloscopia positiva	Rifampicina + dapsona + clofazimina por **12 meses** (12 doses)

Dose mensal supervisionada na unidade. Orientar que a urina pode ficar avermelhada (rifampicina) e a pele escurecida (clofazimina). O paciente **deixa de transmitir logo após o início do tratamento** – não há necessidade de isolamento. Contatos: exame dermatoneurológico e BCG conforme a situação vacinal. Avaliação do **grau de incapacidade física** no diagnóstico e na alta.

9.5 Tuberculose (TB)

Causada pelo *Mycobacterium tuberculosis* (bacilo de Koch), transmitida por **aerossóis** (tosse, fala, espirro) de paciente com TB pulmonar bacilífera. **Sintomático respiratório:** tosse por **3 semanas ou mais** (na população geral) – deve ser investigado com baciloscopia (2 amostras de escarro, a 1ª no momento da consulta e a 2ª na manhã seguinte, ao despertar, em jejum) ou teste rápido molecular (TRM-TB). Em populações vulneráveis (pessoas privadas de liberdade, em situação de rua, com HIV, indígenas), investiga-se a tosse de qualquer duração.

Tratamento básico (adulto, 6 meses): fase intensiva de **2 meses com RHZE** (rifampicina, isoniazida, pirazinamida e etambutol) e fase de manutenção de **4 meses com RH**. Tomada diária, preferencialmente em jejum, com **Tratamento Diretamente Observado (TDO)**. Paciente bacilífero internado: **precaução por aerossóis**, quarto privativo com pressão negativa, uso de **máscara N95/PFF2** pelos profissionais e máscara cirúrgica pelo paciente durante o transporte. A transmissão reduz-se muito após cerca de 15 dias de tratamento eficaz.

9.6 Dengue

Arbovirose transmitida pela fêmea do mosquito *__Aedes aegypti__, *com 4 sorotipos (DENV-1 a 4). Fases: febril (febre alta de início súbito, cefaleia, dor retro-orbitária, mialgia, artralgia, exantema), crítica (entre o 3º e o 7º dia, com a queda da febre – período de maior risco de extravasamento plasmático e choque) e de recuperação*

Sinais de alarme: dor abdominal intensa e contínua, vômitos persistentes, acúmulo de líquidos (ascite, derrame), hipotensão postural/lipotimia, hepatomegalia > 2 cm, sangramento de mucosa, letargia ou irritabilidade, aumento progressivo do hematócrito.

Classificação e manejo: grupo A (sem sinais de alarme, sem comorbidades – hidratação oral em casa), B (sangramento de pele espontâneo ou prova do laço positiva, ou condição especial/comorbidade – exames e observação), C (sinais de alarme – hidratação venosa em leito de internação) e D (choque – reposição venosa rápida e UTI). Hidratação oral no adulto: **60 mL/kg/dia**, sendo 1/3 com soro de reidratação oral. **Não usar AAS nem anti-inflamatórios** (risco de sangramento); o antitérmico é dipirona ou paracetamol. A **prova do laço** é obrigatória na suspeita sem sangramento espontâneo: insuflar o manguito na PA média por **5 minutos** no adulto (3 min na criança) e considerar positiva com **20 ou mais petéquias** em quadrado de 2,5 cm de lado no adulto (10 ou mais na criança). Notificação compulsória; óbito por dengue é de notificação imediata. Vacina **Qdenga** no SUS para faixas etárias priorizadas (10 a 14 anos) e vacina do Butantan aprovada em 2025.

9.7 Infecções sexualmente transmissíveis (IST)

- **Sífilis** (*Treponema pallidum*): primária (cancro duro, indolor), secundária (lesões de pele, inclusive palmas e plantas), latente e terciária. Diagnóstico por teste treponêmico (teste rápido) e não treponêmico (VDRL). Tratamento: **penicilina G benzatina** IM (2,4 milhões UI dose única na primária, secundária e latente recente; 3 doses semanais na latente tardia/indeterminada). A penicilina é o único tratamento eficaz na gestante para prevenir a sífilis congênita; parcerias devem ser tratadas.
- **HIV:** diagnóstico por testes rápidos; tratamento antirretroviral para todos; **PEP** (profilaxia pós-exposição) iniciada idealmente em até 2 h e no máximo em **72 horas**, por 28 dias; **PrEP** (pré-exposição) para populações com maior risco.
- **Gonorreia e clamídia:** corrimento uretral/cervical; tratamento sindrômico (ceftriaxona + azitromicina).
- **HPV:** verrugas anogenitais (condiloma) e relação com câncer de colo de útero; prevenção pela vacina.
- **Herpes genital:** vesículas dolorosas e recorrentes; aciclovir.
- **Hepatites B e C:** transmissão sexual, sanguínea e vertical; vacina disponível para a hepatite B.

2. PONTOS QUE MAIS CAEM EM PROVA

- HAS ≥ 140/90 mmHg; sal < 5 g/dia; efeitos dos anti-hipertensivos (tosse do IECA).
- Critérios do DM (jejum ≥ 126; HbA1c ≥ 6,5%); 4 Ps; tipos de DM.

- Insulina: regular transparente aspirada antes da NPH; rodízio; conservação.
- Cuidados com o pé diabético e a fístula arteriovenosa.
- IMC e classificação.
- Hanseníase: PB até 5 lesões (6 doses) × MB mais de 5 lesões (12 doses).
- TB: tosse ≥ 3 semanas; RHZE 2 meses + RH 4 meses; N95.
- Dengue: fase crítica com a queda da febre; sinais de alarme; não usar AAS; prova do laço.
- Sífilis: penicilina benzatina; PEP em até 72 h.

3. MACETES E DICAS DE MEMORIZAÇÃO

- **"Do claro para o turvo"**: insulina regular antes da NPH na mesma seringa.
- **"4 Ps do diabetes"**: poliúria, polidipsia, polifagia, perda de peso.
- **"Regra dos 15"**: 15 g de açúcar e nova glicemia em 15 minutos.
- **"Hanseníase: até 5 é pouco (6 meses), mais de 5 é muito (12 meses)"**.
- **"2 RHZE + 4 RH"**: esquema básico da TB.
- **"Febre caiu, cuidado redobrou"**: fase crítica da dengue.
- **"Braço da fístula é sagrado"**: nada de PA, punção ou garrote.
- **"PEP: 72 h, 28 dias"**.

4. QUESTÕES

QUESTÃO 01

Ao preparar insulina regular e insulina NPH na mesma seringa, a técnica correta é:

(A) aspirar primeiro a NPH e depois a regular.
(B) agitar vigorosamente o frasco de NPH antes de aspirar.
(C) aspirar primeiro a insulina regular (transparente) e depois a NPH (turva), após homogeneizar a NPH rolando o frasco.
(D) misturar as duas em um frasco separado antes da aspiração.
(E) aplicar por via intramuscular para acelerar a absorção.

✔️ **GABARITO: C**

Comentário:

A) Incorreta – aspirar a NPH primeiro pode contaminar o frasco de regular com insulina de ação intermediária.

B) Incorreta – agitar forma bolhas e altera a dose; o correto é rolar o frasco entre as mãos.

C) Correta – aspira-se do claro para o turvo, protegendo o frasco de regular.

D) Incorreta – não se misturam insulinas em frascos.

E) Incorreta – a via de aplicação domiciliar é a subcutânea.

QUESTÃO 02

Paciente com hanseníase apresenta 8 lesões de pele com alteração de sensibilidade. Pela classificação operacional, trata-se de caso:

(A) paucibacilar, com tratamento de 6 doses.
(B) multibacilar, com tratamento de 12 doses mensais supervisionadas.
(C) paucibacilar, com tratamento de 12 doses.
(D) multibacilar, com tratamento de 6 doses.
(E) que exige isolamento do paciente durante todo o tratamento.

✔️ **GABARITO: B**

Comentário:

A) Incorreta – mais de 5 lesões caracteriza forma multibacilar.

B) Correta – multibacilar (mais de 5 lesões), tratado com PQT-U por 12 meses.

C) Incorreta – a classificação está errada.

D) Incorreta – o número de doses está errado.

E) Incorreta – o paciente deixa de transmitir logo após o início do tratamento; não há isolamento.

QUESTÃO 03

Sobre o tratamento da tuberculose pulmonar no adulto, é correto afirmar:

(A) dura 2 meses, com rifampicina isolada.
(B) consiste em 2 meses de RHZE seguidos de 4 meses de RH, preferencialmente com tratamento diretamente observado.
(C) é feito por 12 meses com estreptomicina injetável.
(D) pode ser interrompido quando a tosse desaparece.
(E) dispensa precauções respiratórias no início do tratamento.

✔️ **GABARITO: B**

Comentário:

A) Incorreta – a monoterapia induz resistência; o tratamento dura no mínimo 6 meses.

B) Correta – é o esquema básico (2RHZE/4RH), com TDO.

C) Incorreta – não é o esquema básico atual.

D) Incorreta – a interrupção precoce causa recidiva e resistência.

E) Incorreta – o paciente bacilífero exige precaução por aerossóis.

QUESTÃO 04

Paciente com dengue, no 4º dia de doença, refere que a febre cessou, mas apresenta dor abdominal intensa e contínua e vômitos persistentes. O técnico em enfermagem deve reconhecer que:

(A) a queda da febre indica cura e o paciente pode ter alta.
(B) trata-se de sinais de alarme, indicando classificação no grupo C e necessidade de hidratação venosa e comunicação imediata.
(C) deve ser administrado ácido acetilsalicílico para a dor.
(D) o paciente deve ser classificado no grupo A.
(E) os vômitos são esperados e não exigem conduta.

✔️ **GABARITO: B**

Comentário:

A) Incorreta – a defervescência marca o início da fase crítica.

B) Correta – dor abdominal intensa e vômitos persistentes são sinais de alarme (grupo C).

C) Incorreta – AAS é contraindicado na dengue pelo risco de sangramento.

D) Incorreta – o grupo A não tem sinais de alarme.

E) Incorreta – vômitos persistentes são sinal de alarme.

QUESTÃO 05

Paciente com doença renal crônica em hemodiálise possui fístula arteriovenosa no braço esquerdo. Constitui cuidado correto:

(A) verificar a pressão arterial preferencialmente no braço da fístula.
(B) coletar sangue para exames no braço da fístula para evitar novas punções.
(C) não aferir PA, não puncionar nem garrotear o braço da fístula, e verificar diariamente a presença de frêmito.
(D) manter o braço da fístula imobilizado e enfaixado.
(E) aplicar compressas frias diariamente sobre a fístula.

✔️ **GABARITO: C**

Comentário:

A) Incorreta – a compressão do manguito pode causar trombose da fístula.

B) Incorreta – punções fora da diálise aumentam o risco de infecção e trombose.

C) Correta – são os cuidados essenciais de preservação da fístula; o frêmito indica que está funcionando.

D) Incorreta – a fístula não deve ser enfaixada nem imobilizada; exercícios com bolinha favorecem sua maturação.

E) Incorreta – não há indicação de compressas frias.

5. REVISÃO DO CAPÍTULO

Resumo em tópicos: HAS (classificação, tratamento); DM (diagnóstico, tipos, insulina, pé diabético, hipoglicemia); doenças cardiovasculares; obesidade (IMC); DRC e fístula; hanseníase (PB × MB); TB (sintomático respiratório, RHZE, precauções); dengue (fases, sinais de alarme, grupos, prova do laço); IST (sífilis, HIV, PEP).

Quadro-resumo: HAS ≥ 140/90; DM jejum ≥ 126, HbA1c ≥ 6,5%; IMC ≥ 30 obesidade; hanseníase PB 6 doses e MB 12 doses; TB 2RHZE/4RH; dengue: hidratação oral 60 mL/kg/dia; prova do laço ≥ 20 petéquias (adulto).

Pegadinhas: aspirar NPH primeiro; isolar paciente com hanseníase; AAS na dengue; PA no braço da fístula.

Erros comuns: achar que a queda da febre na dengue significa melhora; confundir paucibacilar e multibacilar; interromper o tratamento da TB ao melhorar.

ASSUNTO 10 – EPIDEMIOLOGIA, VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS IRAS E NA COMUNIDADE, DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS, DE NOTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA E IMUNOPREVENÍVEIS

1. RESUMO TEÓRICO

10.1 Conceitos de epidemiologia

Epidemiologia estuda a distribuição e os determinantes dos estados de saúde e doença nas populações, aplicando esse conhecimento ao controle dos problemas de saúde.

Termo	Definição
Endemia	Ocorrência habitual de uma doença em determinada região, dentro do esperado
Epidemia	Aumento da ocorrência acima do esperado em determinada região e período
Surto	Epidemia localizada (mesmo local, como escola ou hospital), em geral com casos relacionados
Pandemia	Epidemia de grande extensão, atingindo vários países e continentes
Incidência	Número de **casos novos** em determinado período
Prevalência	Número **total de casos** (novos e antigos) existentes em determinado momento
Letalidade	Proporção de óbitos entre os **doentes** de determinada doença (gravidade)
Mortalidade	Proporção de óbitos em relação à **população total**

Cadeia de transmissão: agente etiológico → reservatório → porta de saída → modo de transmissão → porta de entrada → hospedeiro suscetível. Conceitos: **período de incubação** (da infecção até os primeiros sintomas), **período de transmissibilidade** (em que o agente pode ser transmitido), **portador** (abriga o agente sem manifestar a doença, mas pode transmiti-lo), **vetor** (ser vivo que transmite o agente, como o *Aedes aegypti*), **zoonose** (doença transmitida de animais ao homem, como raiva e leptospirose).

Níveis de prevenção (Leavell e Clark):

Nível	Objetivo	Exemplos
Prevenção primária	Promoção da saúde e proteção específica, **antes** da doença	Vacinação, saneamento, uso de preservativo, educação em saúde
Prevenção secundária	Diagnóstico precoce e tratamento imediato	Rastreamento (Papanicolau, mamografia), busca ativa de sintomáticos respiratórios
Prevenção terciária	Limitação de incapacidade e reabilitação	Fisioterapia pós-AVC, reabilitação de sequelas de hanseníase
Prevenção quaternária	Evitar intervenções desnecessárias (iatrogenia)	Evitar exames e medicações sem indicação

10.2 Vigilância em saúde

A Lei nº 8.080/1990 define **vigilância epidemiológica** como o conjunto de ações que proporciona o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes da saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle. A **vigilância sanitária** é o conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços. Integram ainda a vigilância em saúde a vigilância ambiental e a vigilância em saúde do trabalhador.

10.3 Notificação compulsória

Regida pela **Portaria de Consolidação GM/MS nº 4/2017** (Anexo 1 do Anexo V, com atualizações periódicas, como a Portaria GM/MS nº 5.201/2024). A notificação é **obrigatória para médicos, outros profissionais de saúde** (incluindo a enfermagem) e responsáveis por estabelecimentos de saúde, públicos ou privados. Também deve ser feita a **notificação de caso suspeito**, sem aguardar a confirmação. A comunicação pode ser feita por qualquer cidadão.

- **Notificação imediata:** em até **24 horas**, à Secretaria Municipal de Saúde (e, em alguns casos, à Estadual e ao MS). Exemplos: acidente de trabalho grave ou fatal e com crianças e adolescentes, **raiva humana**, **sarampo**, **rubéola**, **poliomielite/paralisia flácida aguda**, **cólera**, **febre amarela**, **febre do Chikungunya em áreas sem transmissão**, **óbito por dengue**, **doença de Chagas aguda**, **difteria**, **botulismo**, **tétano** (acidental e neonatal), **hantavirose**, **meningite**, **malária fora da região amazônica**, acidente por animal potencialmente transmissor da raiva, **violência sexual e tentativa de suicídio**, eventos de saúde pública, **evento adverso grave ou óbito pós-vacinação**, peste, varíola, influenza por novo subtipo.
- **Notificação semanal:** em até **7 dias**. Exemplos: **dengue** (casos), **hanseníase**, **tuberculose**, **HIV/aids**, **sífilis** (adquirida, em gestante e congênita), **hepatites virais**, leishmaniose, esquistossomose, **violência doméstica e outras violências**, acidente de trabalho com exposição a material biológico, leptospirose.

O **SINAN** (Sistema de Informação de Agravos de Notificação) recebe as notificações por meio da **Ficha de Notificação** e da **Ficha de Investigação**.

10.4 Doenças imunopreveníveis

Doenças evitáveis por vacinação: sarampo, rubéola, caxumba, varicela, poliomielite, difteria, tétano, coqueluche, hepatites A e B, febre amarela, meningites (meningococo, pneumococo, Hib), tuberculose (formas graves), influenza, rotavírus, HPV e covid-19.

- **Sarampo:** febre alta, exantema maculopapular (início no rosto, em direção craniocaudal), tosse, coriza, conjuntivite e **manchas de Koplik** (na mucosa oral). Transmissão por aerossóis – **precaução por aerossóis**. Notificação imediata.
- **Coqueluche:** tosse paroxística seguida de "guincho" inspiratório; prevenção com DTP/pentavalente e dTpa na gestante. Precaução por gotículas.
- **Tétano:** não é transmitido de pessoa a pessoa; *Clostridium tetani* penetra em ferimentos. **Tétano neonatal** previne-se com a vacinação da gestante e o cuidado com o coto umbilical (álcool 70%). Sinais: trismo, riso sardônico, opistótono.
- **Poliomielite:** paralisia flácida aguda; o Brasil é livre de circulação desde 1989; vacinação com VIP.
- **Difteria:** placas pseudomembranosas branco-acinzentadas na garganta.
- **Meningite:** febre, cefaleia, vômitos, **rigidez de nuca** (sinais de Kernig e Brudzinski); na meningocócica pode haver **petéquias/sufusões** (meningococcemia). Precaução por gotículas nas primeiras 24 h de antibiótico.

Vacinas e conceitos: imunidade **ativa** (o próprio organismo produz anticorpos – vacina ou doença) × **passiva** (recebe anticorpos prontos – soro, imunoglobulina, anticorpos maternos via placenta e leite).

Vacinas **vivas atenuadas**: BCG, tríplice viral, varicela, febre amarela, rotavírus, VOP. Vacinas inativadas/subunidades: VIP, hepatite B, pentavalente, influenza, pneumocócicas, meningocócicas, HPV. Intervalo entre duas vacinas vivas injetáveis não administradas no mesmo dia: **30 dias** (exceção: febre amarela e tríplice viral em menores de 2 anos não devem ser dadas no mesmo dia).

10.5 Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde (IRAS)

IRAS são infecções adquiridas após a admissão do paciente, manifestadas durante a internação ou após a alta, quando relacionadas à internação ou a procedimentos. Critério tradicional: infecção que se manifesta após **72 horas** da internação (ou antes, quando relacionada a procedimentos invasivos), excetuadas as em incubação na admissão. Infecção de sítio cirúrgico pode surgir até **30 dias** após a cirurgia (ou até **90 dias** se houver implante).

Principais IRAS e medidas de prevenção (bundles):

IRAS	Prevenção
Infecção primária de corrente sanguínea associada a cateter central (IPCS)	Higiene das mãos, barreira máxima na inserção, clorexidina alcoólica, desinfecção dos conectores, retirada precoce
Pneumonia associada à ventilação mecânica (PAV)	Cabeceira 30–45°, higiene oral, cuff 20–30 cmH2O, interrupção diária da sedação
Infecção do trato urinário associada a cateter vesical (ITU-AC)	Indicação precisa, técnica estéril na inserção, sistema fechado, bolsa abaixo da bexiga, retirada precoce
Infecção de sítio cirúrgico (ISC)	Banho pré-operatório, tricotomia com tricotomizador próxima à cirurgia, antibioticoprofilaxia em até 60 min antes da incisão, controle glicêmico e normotermia

A medida isolada **mais importante e simples** de prevenção das IRAS é a **higiene das mãos**. Microrganismos multirresistentes (MRSA, enterobactérias produtoras de carbapenemase – KPC, *Acinetobacter*) exigem **precaução de contato**.

10.6 Orientações aos pacientes e familiares

Orientar sobre higiene das mãos, etiqueta respiratória (cobrir a boca e o nariz com o antebraço ao tossir ou espirrar), uso de máscara por sintomáticos respiratórios, adesão ao tratamento, vacinação, eliminação de criadouros do *Aedes*, cuidados com água e alimentos e restrição de visitas quando indicada.

2. PONTOS QUE MAIS CAEM EM PROVA

- Endemia, epidemia, surto e pandemia; incidência × prevalência; letalidade × mortalidade.
- Cadeia de transmissão; portador; vetor; zoonose.
- Níveis de prevenção (primária a quaternária).
- Vigilância epidemiológica × sanitária (Lei 8.080/1990).
- Notificação imediata (24 h) × semanal (7 dias); notificar caso suspeito; SINAN.
- Sarampo: notificação imediata e precaução por aerossóis.
- Imunidade ativa × passiva; vacinas vivas atenuadas.
- IRAS: 72 h; ISC até 30/90 dias; bundles; higiene das mãos.

3. MACETES E DICAS DE MEMORIZAÇÃO

- **"Incidência é novidade, prevalência é estoque"**.
- **"Letalidade olha os doentes, mortalidade olha todo mundo"**.
- **"Surto é epidemia de endereço certo"**.
- **"Primária evita, secundária detecta, terciária reabilita, quaternária protege do excesso"**.
- **"Grave, raro ou explosivo = notifica em 24 h"** (sarampo, raiva, pólio, febre amarela, óbito por dengue).
- **"Vivas: BCG, febre amarela, tríplice viral, varicela, rotavírus"**.

4. QUESTÕES

QUESTÃO 01

Em determinado município, o número de casos de dengue em uma semana ultrapassou significativamente o esperado para o período. Essa situação caracteriza:

(A) endemia.
(B) epidemia.
(C) pandemia.
(D) prevalência.
(E) letalidade.

✔️ **GABARITO: B**

Comentário:

A) Incorreta – endemia é a ocorrência dentro do esperado.

B) Correta – aumento acima do esperado em determinado local e período é epidemia.

C) Incorreta – pandemia atinge vários países e continentes.

D) Incorreta – prevalência é medida de frequência, não situação epidemiológica.

E) Incorreta – letalidade mede a proporção de óbitos entre os doentes.

QUESTÃO 02

A realização do exame de Papanicolau para detecção precoce de lesões do colo do útero é exemplo de ação de:

(A) prevenção primária.
(B) prevenção secundária.
(C) prevenção terciária.
(D) prevenção quaternária.
(E) promoção da saúde.

✔️ **GABARITO: B**

Comentário:

A) Incorreta – a primária atua antes da doença (como a vacina contra HPV).

B) Correta – rastreamento e diagnóstico precoce são prevenção secundária.

C) Incorreta – a terciária visa reabilitação e limitação de sequelas.

D) Incorreta – a quaternária evita intervenções desnecessárias.

E) Incorreta – promoção da saúde integra o nível primário.

QUESTÃO 03

Entre as doenças e agravos abaixo, é de notificação compulsória imediata (em até 24 horas):

(A) caso de hanseníase.
(B) caso de tuberculose.
(C) caso suspeito de sarampo.
(D) caso de hepatite viral crônica.
(E) caso de sífilis adquirida.

✔️ **GABARITO: C**

Comentário:

A) Incorreta – a hanseníase é de notificação semanal.

B) Incorreta – a tuberculose é de notificação semanal.

C) Correta – o sarampo é de notificação imediata, inclusive na suspeita.

D) Incorreta – as hepatites virais são de notificação semanal.

E) Incorreta – a sífilis adquirida é de notificação semanal.

QUESTÃO 04

O recém-nascido que recebe anticorpos da mãe pela placenta e pelo leite materno apresenta imunidade:

(A) ativa natural.
(B) ativa artificial.
(C) passiva natural.
(D) passiva artificial.
(E) inata adquirida.

✔️ **GABARITO: C**

Comentário:

A) Incorreta – a ativa natural ocorre quando o próprio organismo produz anticorpos após a doença.

B) Incorreta – a ativa artificial decorre da vacinação.

C) Correta – anticorpos prontos transferidos naturalmente da mãe caracterizam imunidade passiva natural.

D) Incorreta – a passiva artificial ocorre com soros e imunoglobulinas.

E) Incorreta – termo sem correspondência na classificação.

QUESTÃO 05

Considera-se a medida isolada mais importante e eficaz para a prevenção das infecções relacionadas à assistência à saúde:

(A) o uso rotineiro de antibióticos profiláticos em todos os pacientes.

(B) a higiene das mãos.
(C) o uso de luvas em todos os procedimentos, dispensando a higiene das mãos.
(D) a troca diária de todos os cateteres.
(E) o isolamento de todos os pacientes internados.

✔️ **GABARITO: B**

Comentário:

A) Incorreta – o uso indiscriminado de antibióticos favorece a resistência microbiana.

B) Correta – a higiene das mãos é a medida mais simples e eficaz.

C) Incorreta – as luvas não substituem a higiene das mãos.

D) Incorreta – trocas rotineiras sem indicação aumentam a manipulação e o risco.

E) Incorreta – o isolamento é indicado conforme o agente e o modo de transmissão.

5. REVISÃO DO CAPÍTULO

Resumo em tópicos: conceitos epidemiológicos; cadeia de transmissão; níveis de prevenção; vigilância epidemiológica e sanitária; notificação compulsória (imediata × semanal; SINAN); doenças imunopreveníveis; tipos de imunidade; IRAS e bundles; orientações à comunidade.

Quadro-resumo: notificação imediata em 24 h; semanal em 7 dias; IRAS após 72 h; ISC até 30 dias (90 com implante); vacinas vivas com intervalo de 30 dias.

Pegadinhas: esperar confirmação para notificar; confundir incidência e prevalência; achar que só o médico notifica; luva substituir a higiene das mãos.

Erros comuns: classificar rastreamento como prevenção primária; achar que tétano é contagioso.

ASSUNTO 11 – POLÍTICA NACIONAL DE HUMANIZAÇÃO (PNH – HUMANIZASUS)

1. RESUMO TEÓRICO

11.1 Origem e conceito

A **Política Nacional de Humanização da Atenção e Gestão do SUS (PNH)**, também chamada **HumanizaSUS**, foi lançada em **2003** pelo Ministério da Saúde. Ela não é um programa, mas uma **política transversal**, que atravessa todas as ações e instâncias do SUS. Busca pôr em prática os princípios do SUS no cotidiano dos serviços, produzindo mudanças nos modos de **gerir e cuidar**.

Humanizar, para a PNH, é a valorização dos diferentes sujeitos implicados no processo de produção de saúde – **usuários, trabalhadores e gestores** –, com inclusão das diferenças nos processos de gestão e de cuidado. As mudanças são construídas de forma coletiva e compartilhada, e não de forma isolada.

11.2 Princípios

Princípio	Significado
Transversalidade	A PNH deve estar presente e inserida em todas as políticas e programas do SUS; amplia a comunicação entre grupos e saberes, rompendo isolamentos e hierarquias rígidas
Indissociabilidade entre atenção e gestão	As decisões da gestão interferem diretamente na atenção; trabalhadores e usuários devem conhecer e participar da gestão
Protagonismo, corresponsabilidade e autonomia dos sujeitos e coletivos	Usuários e trabalhadores são protagonistas e corresponsáveis pela produção de saúde; o usuário participa das decisões sobre seu cuidado

11.3 Método

O método da PNH é o da **tríplice inclusão**: inclusão dos diferentes sujeitos (usuários, trabalhadores e gestores) na produção da saúde; inclusão dos **analisadores sociais** (fenômenos que desestabilizam modelos tradicionais e revelam tensões, como conflitos) e inclusão do **coletivo** (movimentos sociais e redes). É o chamado método da **"inclusão"** ou **"roda"** (cogestão).

11.4 Diretrizes

- **Acolhimento:** reconhecer o que o outro traz como legítima e singular necessidade de saúde. É uma **postura ética**, não um local nem um horário, e deve ocorrer em todos os momentos do atendimento e por todos os profissionais. Pressupõe **escuta qualificada** e construção de vínculo. O **Acolhimento com Classificação de Risco (ACCR)** organiza a fila por gravidade, e não por ordem de chegada.
- **Gestão participativa e cogestão:** inclusão de novos sujeitos nos processos de análise e decisão (colegiados gestores, rodas, conselhos, mesas de negociação permanente).
- **Ambiência:** criar espaços físicos, sociais, profissionais e de relações interpessoais **saudáveis, acolhedores e confortáveis**, que respeitem a privacidade e propiciem mudanças no processo de trabalho (iluminação, cores, cheiros, sons, arte).

- **Clínica ampliada e compartilhada:** ferramenta teórica e prática que considera a singularidade do sujeito e a complexidade do processo saúde-doença, ampliando o objeto de trabalho para além da doença; utiliza o **Projeto Terapêutico Singular (PTS)** e o apoio matricial.
- **Valorização do trabalhador:** dar visibilidade à experiência dos trabalhadores e incluí-los na tomada de decisão; promover saúde do trabalhador e educação permanente.
- **Defesa dos direitos dos usuários:** conhecer e cumprir os direitos dos usuários, como a **Carta dos Direitos dos Usuários da Saúde** (Portaria GM/MS nº 1.820/2009), incluindo o direito a **acompanhante** e à **visita aberta**.

11.5 Dispositivos

Dispositivos são arranjos de processos de trabalho para pôr em prática as diretrizes:

- Acolhimento com classificação de risco.
- Colegiados de gestão e contratos de gestão.
- Sistemas de escuta qualificada para usuários e trabalhadores (**ouvidorias**, pesquisas de satisfação).
- **Visita aberta e direito a acompanhante**.
- **Equipe de referência e apoio matricial**.
- Projeto Terapêutico Singular e Projeto de Saúde Coletiva.
- Projetos de construção coletiva da ambiência.
- Programa de Formação em Saúde do Trabalhador (PFST) e Comunidade Ampliada de Pesquisa (CAP).
- Grupo de Trabalho de Humanização (GTH) e Câmara Técnica de Humanização.
- Programas de qualidade de vida e saúde para os trabalhadores.

Equipe de referência é o grupo de profissionais responsável por determinado conjunto de usuários, criando vínculo; **apoio matricial** é o suporte técnico especializado oferecido a essas equipes (por exemplo, equipe multiprofissional apoiando a Estratégia Saúde da Família).

11.6 Carta dos Direitos dos Usuários da Saúde (Portaria nº 1.820/2009)

Princípios: todo cidadão tem direito ao **acesso** ordenado e organizado aos sistemas de saúde; a **tratamento adequado e efetivo**; a **atendimento humanizado, acolhedor e livre de discriminação**; a atendimento que respeite sua pessoa, seus valores e direitos (incluindo identificação pelo **nome social**, sigilo, consentimento livre e esclarecido, acompanhante); tem **responsabilidades** para que o tratamento aconteça adequadamente; e direito ao comprometimento dos gestores para que os princípios sejam cumpridos.

2. PONTOS QUE MAIS CAEM EM PROVA

- PNH lançada em 2003; é política transversal, não programa.
- Os três princípios: transversalidade; indissociabilidade entre atenção e gestão; protagonismo, corresponsabilidade e autonomia.
- Acolhimento é postura ética, não local nem triagem.
- ACCR: atendimento por gravidade e não por ordem de chegada.
- Ambiência: espaço físico, social e de relações.
- Clínica ampliada, PTS, equipe de referência e apoio matricial.
- Direito a acompanhante e visita aberta; Carta dos Direitos dos Usuários.

3. MACETES E DICAS DE MEMORIZAÇÃO

- **"TIP"** para os princípios: Transversalidade, Indissociabilidade (atenção-gestão), Protagonismo (com corresponsabilidade e autonomia).
- **"Acolher não é lugar, é jeito"**.
- **"Ambiência = ambiente + convivência"**.
- **"Referência cuida, matriciamento apoia"**.
- **Diretrizes: "A-G-A-C-V-D"** – Acolhimento, Gestão participativa, Ambiência, Clínica ampliada, Valorização do trabalhador, Defesa dos direitos.

4. QUESTÕES

QUESTÃO 01

São princípios da Política Nacional de Humanização:

(A) universalidade, integralidade e equidade.
(B) transversalidade; indissociabilidade entre atenção e gestão; e protagonismo, corresponsabilidade e autonomia dos sujeitos e coletivos.
(C) descentralização, regionalização e hierarquização.
(D) acolhimento, ambiência e clínica ampliada.
(E) hierarquia, disciplina e produtividade.

✔️ **GABARITO: B**

Comentário:

A) Incorreta – são princípios doutrinários do SUS (Lei 8.080/1990).

B) Correta – são os três princípios da PNH.

C) Incorreta – são princípios organizativos do SUS.

D) Incorreta – são diretrizes da PNH, não princípios.

E) Incorreta – não têm relação com a PNH.

QUESTÃO 02

Na perspectiva da PNH, o acolhimento é entendido como:

(A) um espaço físico específico na entrada da unidade.
(B) uma etapa realizada exclusivamente pelo enfermeiro na triagem.
(C) uma postura ética que implica escuta qualificada e reconhecimento das necessidades do usuário, devendo estar presente em todos os momentos do atendimento.
(D) o atendimento por ordem de chegada.
(E) a distribuição de senhas no início do expediente.

✔️ **GABARITO: C**

Comentário:

A) Incorreta – acolhimento não é um local.

B) Incorreta – é responsabilidade de todos os profissionais e não se limita à triagem.

C) Correta – o acolhimento é postura ética, com escuta qualificada e vínculo.

D) Incorreta – com a classificação de risco, o atendimento se dá por gravidade.

E) Incorreta – a distribuição de senhas não caracteriza acolhimento.

QUESTÃO 03

A diretriz da PNH que trata da criação de espaços físicos, sociais e de relações interpessoais saudáveis, acolhedores e que respeitem a privacidade é a:

(A) clínica ampliada.
(B) cogestão.
(C) ambiência.
(D) valorização do trabalhador.
(E) defesa dos direitos dos usuários.

✔️ **GABARITO: C**

Comentário:

A) Incorreta – a clínica ampliada considera a singularidade do sujeito no cuidado.

B) Incorreta – a cogestão trata da participação na tomada de decisão.

C) Correta – ambiência é o tratamento dado ao espaço físico entendido como espaço social, profissional e de relações.

D) Incorreta – a valorização trata do trabalhador e de sua participação.

E) Incorreta – trata do cumprimento dos direitos dos usuários.

QUESTÃO 04

O suporte técnico especializado oferecido por profissionais de diferentes áreas a uma equipe interdisciplinar responsável pelo cuidado de um grupo de usuários é denominado:

(A) equipe de referência.
(B) apoio matricial.
(C) ouvidoria.
(D) colegiado gestor.
(E) visita aberta.

✔️ **GABARITO: B**

Comentário:

A) Incorreta – a equipe de referência é a responsável direta pelos usuários.

B) Correta – o apoio matricial dá retaguarda especializada às equipes de referência.

C) Incorreta – a ouvidoria é dispositivo de escuta de usuários e trabalhadores.

D) Incorreta – o colegiado é espaço de gestão participativa.

E) Incorreta – a visita aberta amplia o acesso de familiares.

QUESTÃO 05

Sobre a Política Nacional de Humanização, assinale a alternativa correta.

(A) Trata-se de um programa vertical, restrito aos hospitais.

(B) Foi criada em 2010 e se aplica apenas à atenção básica.

(C) É uma política transversal, que deve estar presente em todas as políticas e práticas do SUS, envolvendo usuários, trabalhadores e gestores.

(D) Considera o usuário como receptor passivo das ações de saúde.

(E) Exclui os trabalhadores da tomada de decisões.

✔️ **GABARITO: C**

Comentário:

A) Incorreta – a PNH não é programa e não se restringe a hospitais.

B) Incorreta – foi lançada em 2003 e abrange todos os níveis de atenção.

C) Correta – a transversalidade é um de seus princípios, com inclusão dos três sujeitos.

D) Incorreta – a PNH defende o protagonismo e a autonomia do usuário.

E) Incorreta – a valorização e a participação dos trabalhadores são diretrizes.

5. REVISÃO DO CAPÍTULO

Resumo em tópicos: PNH/HumanizaSUS (2003); conceito de humanização; princípios; método da tríplice inclusão; diretrizes (acolhimento, gestão participativa, ambiência, clínica ampliada, valorização do trabalhador, defesa dos direitos); dispositivos; Carta dos Direitos dos Usuários.

Quadro-resumo: princípios = transversalidade + indissociabilidade + protagonismo; acolhimento = postura ética; ACCR = gravidade; Portaria 1.820/2009 = direitos dos usuários.

Pegadinhas: chamar a PNH de programa; dizer que acolhimento é local ou triagem; confundir princípios do SUS com os da PNH; trocar diretriz por princípio.

Erros comuns: confundir equipe de referência com apoio matricial; achar que a PNH é só para hospitais.

ASSUNTO 12 – REDE DE FRIO: CONSERVAÇÃO, ARMAZENAMENTO E MANIPULAÇÃO DE VACINAS

1. RESUMO TEÓRICO

12.1 Conceito e estrutura

Rede de Frio é o sistema que engloba estrutura técnico-administrativa, normas, recursos humanos, equipamentos e procedimentos para **receber, armazenar, conservar, manipular, distribuir e transportar** os imunobiológicos do PNI em condições adequadas, desde o laboratório produtor até o momento da administração. O objetivo é **manter a potência imunogênica** das vacinas (Manual de Rede de Frio do PNI, 5ª edição, 2017).

Instâncias: **nacional** (Central Nacional de Armazenamento e Distribuição de Imunobiológicos – CENADI), **estadual** (centrais estaduais), **regional**, **municipal** e **local** (salas de vacinação, onde ocorre a administração).

12.2 Temperaturas de conservação

- Na instância **local (sala de vacinação)**, todos os imunobiológicos são conservados entre **+2 °C e +8 °C**, sendo ideal **+5 °C**.
- Nas instâncias nacional e estaduais, algumas vacinas virais (como a febre amarela e a tríplice viral, em estoques de grande volume) podem ser armazenadas em temperatura negativa (–25 °C a –15 °C), conforme orientação.
- **Vacinas que não podem ser congeladas** (o congelamento as inativa ou faz precipitar o adjuvante de alumínio): as **adsorvidas** e as de subunidades – hepatite B, DTP, pentavalente, dT, dTpa, VIP, pneumocócicas, meningocócicas, HPV, influenza.
- Vacinas de vírus vivos (febre amarela, tríplice viral, varicela) são **mais sensíveis ao calor** e à **luz**.

Teste do congelamento (teste de agitação): suspeita de congelamento de vacina adsorvida – a vacina congelada, após agitação, forma flocos e sedimenta mais rápido; deve ser descartada (e a ocorrência notificada).

12.3 Equipamentos

- **Câmara refrigerada** (refrigerador científico): equipamento **recomendado** pelo PNI para a sala de vacinação, com temperatura programada entre +2 °C e +8 °C, circulação de ar forçada, alarme, registro contínuo e autonomia em queda de energia. Não é necessário o uso de bobinas de gelo dentro dela e as vacinas podem ser armazenadas em todas as prateleiras, conforme o fabricante.
- **Refrigerador doméstico:** seu uso **não é mais recomendado**; onde ainda existir, deve ser exclusivo para imunobiológicos, com as seguintes regras: no **congelador**, bobinas de gelo reutilizáveis; na **1ª prateleira**, vacinas que podem ser submetidas a temperatura negativa (virais); na **2ª prateleira**, vacinas que **não podem ser congeladas**; na **3ª prateleira**, estoques de diluentes e materiais; **gaveta de legumes retirada** e substituída por garrafas com água e corante; **nada na porta**; distância de 20 cm da parede e 15 cm do teto; abrir o mínimo possível.
- **Caixas térmicas** (poliuretano ou poliestireno expandido – isopor): usadas para atividades extramuros, transporte e uso diário (caixa de uso diário). Devem ser preparadas com **bobinas de gelo reutilizáveis ambientadas** (deixadas à temperatura ambiente até sumir a névoa e o gelo ficar

com aspecto "suado", o que evita o congelamento das vacinas) e com **termômetro**, mantendo +2 °C a +8 °C antes de receber as vacinas.

Termômetros: de **máxima e mínima** (analógico ou digital, com cabo extensor) ou **data logger**. A leitura e o registro no **Mapa de Controle Diário de Temperatura** devem ser feitos **no início e no final da jornada de trabalho** (no mínimo duas vezes ao dia), anotando a temperatura do momento, a máxima e a mínima, e depois "zerando" (reset) o termômetro.

12.4 Prazos após abertura do frasco multidose

Vacina	Prazo de validade após a abertura (frasco multidose)
BCG	**6 horas** após a reconstituição
Febre amarela	**6 horas** após a reconstituição
Tríplice viral	**8 horas** após a reconstituição
Varicela	Uso imediato (monodose, em geral)
Hepatite B, DTP, dT, VIP (multidose)	Até **28 dias** após a abertura (conforme o fabricante), mantidas as condições assépticas e a temperatura
Influenza (multidose)	Conforme o fabricante (em geral **7 dias**)
Pneumocócica 10 (multidose)	Até 7 dias (conforme o fabricante)

Os prazos variam conforme o laboratório produtor: **sempre consultar a bula e as notas técnicas vigentes**. Registrar data e hora de abertura no frasco.

12.5 Manipulação e administração

- Higienizar as mãos antes do preparo.
- Conferir nome, validade, aspecto, lote e integridade do frasco.
- Reconstituir apenas com o **diluente próprio** do fabricante, na temperatura adequada (o diluente deve estar na mesma temperatura da vacina, entre +2 °C e +8 °C, na hora da reconstituição).
- **Antissepsia da pele:** a rotina do PNI dispensa o álcool na sala de vacinação; se a pele estiver visivelmente suja, lavar com água e sabão. Se o álcool 70% for usado (ex.: vacinação em ambiente hospitalar), esperar a secagem completa, pois ele pode inativar vacinas vivas como a BCG.
- Não massagear o local após a aplicação.
- Descartar seringas e agulhas em **caixa coletora de perfurocortantes** (grupo E); frascos de vacinas de microrganismos vivos atenuados são resíduos do **grupo A1** e devem ser tratados (autoclavados) antes do descarte.

12.6 Queda de energia e alterações de temperatura

Em caso de falha de energia ou de equipamento: **não abrir** o refrigerador; monitorar a temperatura; se o tempo previsto de reparo exceder a autonomia do equipamento, **transferir as vacinas para caixas térmicas** ou outro equipamento adequado. Toda **alteração de temperatura** (excursão fora de +2 °C a +8 °C) deve ser comunicada à coordenação de imunização; as vacinas são mantidas **sob refrigeração e isoladas, sem uso**, identificadas como "sob suspeita", até a avaliação técnica (notificação de **queixa técnica/desvio de qualidade** no sistema). Nunca descartá-las por conta própria nem continuar usando antes do parecer.

Lavagem do refrigerador doméstico: a cada 15 dias ou quando a camada de gelo no congelador atingir 0,5 cm, transferindo antes as vacinas para outro equipamento ou caixa térmica.

2. PONTOS QUE MAIS CAEM EM PROVA

- Temperatura na sala de vacinação: +2 °C a +8 °C (ideal +5 °C).

- Vacinas que não podem ser congeladas (adsorvidas) × sensíveis ao calor/luz (vivas).
- Câmara refrigerada como equipamento recomendado.
- Organização do refrigerador doméstico (porta vazia, gaveta retirada, garrafas com água).
- Ambientação das bobinas na caixa térmica.
- Leitura do termômetro no início e no fim do expediente.
- Prazos após abertura: BCG e febre amarela 6 h; tríplice viral 8 h.
- Conduta em excursão de temperatura: isolar, manter refrigerado, comunicar, aguardar avaliação.

3. MACETES E DICAS DE MEMORIZAÇÃO

- **"Dois a oito, ideal cinco"**.
- **"Adsorvida não gela"**: vacinas com alumínio perdem a potência se congeladas.
- **"Viva teme calor e luz"**.
- **"Seis, seis, oito"**: BCG 6 h, febre amarela 6 h, tríplice viral 8 h.
- **"Bobina suada é bobina pronta"**: ambientada, sem névoa.
- **"Porta vazia"**: nada de vacina na porta do refrigerador.
- **"Alterou a temperatura? Separa, refrigera e comunica"**.

4. QUESTÕES

QUESTÃO 01

Na sala de vacinação, os imunobiológicos devem ser conservados na faixa de temperatura de:

(A) –20 °C a –15 °C.
(B) 0 °C a +4 °C.
(C) +2 °C a +8 °C, sendo ideal +5 °C.
(D) +8 °C a +15 °C.
(E) temperatura ambiente, desde que protegidos da luz.

✔️ **GABARITO: C**

Comentário:

A) Incorreta – temperaturas negativas são usadas apenas em algumas instâncias para vacinas virais específicas.

B) Incorreta – 0 °C expõe vacinas adsorvidas ao risco de congelamento.

C) Correta – a faixa de conservação na instância local é de +2 °C a +8 °C, ideal +5 °C.

D) Incorreta – acima de +8 °C há perda de potência.

E) Incorreta – vacinas não podem ficar em temperatura ambiente.

QUESTÃO 02

É exemplo de vacina que perde sua potência se for congelada:

(A) febre amarela.
(B) tríplice viral.
(C) hepatite B.
(D) varicela.
(E) BCG.

✔️ **GABARITO: C**

Comentário:

A) Incorreta – a febre amarela é vacina viral atenuada, sensível ao calor, que tolera temperatura negativa em instâncias superiores.

B) Incorreta – a tríplice viral também tolera congelamento nas instâncias de armazenamento.

C) Correta – a hepatite B é adsorvida (contém hidróxido de alumínio) e é inativada pelo congelamento.

D) Incorreta – a varicela é viral atenuada.

E) Incorreta – a BCG é bacteriana atenuada liofilizada, sensível à luz e ao calor.

QUESTÃO 03

Ao preparar a caixa térmica para uso diário na sala de vacinação, o técnico em enfermagem deve:

(A) colocar as bobinas diretamente do congelador em contato com as vacinas.
(B) ambientar as bobinas de gelo reutilizáveis até o desaparecimento da névoa, posicionar o termômetro e só acondicionar as vacinas quando a temperatura estiver entre +2 °C e +8 °C.
(C) usar gelo em cubos soltos misturados às vacinas.
(D) dispensar o termômetro, pois a caixa mantém a temperatura sozinha.
(E) deixar a caixa aberta para facilitar o acesso.

✔️ **GABARITO: B**

Comentário:

A) Incorreta – bobinas não ambientadas podem congelar as vacinas.

B) Correta – a ambientação evita o congelamento e o termômetro garante a faixa correta.

C) Incorreta – gelo solto não é recomendado e molha os frascos.

D) Incorreta – a monitoração da temperatura é obrigatória.

E) Incorreta – a caixa deve permanecer fechada, abrindo-se o mínimo possível.

QUESTÃO 04

Após a reconstituição, o frasco multidose da vacina BCG pode ser utilizado por até:

(A) 1 hora.
(B) 6 horas.
(C) 8 horas.
(D) 24 horas.
(E) 28 dias.

✔️ **GABARITO: B**

Comentário:

A) Incorreta – prazo inferior ao estabelecido.

B) Correta – a BCG reconstituída pode ser usada por até 6 horas, mantida entre +2 °C e +8 °C e protegida da luz.

C) Incorreta – 8 horas é o prazo da tríplice viral.

D) Incorreta – prazo superior ao permitido.

E) Incorreta – 28 dias é prazo de algumas vacinas líquidas multidose, como a hepatite B.

QUESTÃO 05

Ao iniciar o expediente, o técnico verifica que o termômetro registrou temperatura máxima de +12 °C durante a noite. A conduta correta é:

(A) descartar imediatamente todas as vacinas.

(B) continuar usando as vacinas normalmente, pois a temperatura atual está adequada.
(C) manter as vacinas refrigeradas, isoladas e sem uso, identificadas como "sob suspeita", e comunicar a coordenação de imunização para avaliação.
(D) congelar as vacinas para compensar o aquecimento.
(E) transferir as vacinas para a porta do refrigerador.

✔️ **GABARITO: C**

Comentário:

A) Incorreta – o descarte depende de avaliação técnica.

B) Incorreta – a excursão de temperatura exige avaliação antes do uso.

C) Correta – as vacinas ficam sob suspeita, refrigeradas e sem uso até o parecer da coordenação.

D) Incorreta – o congelamento inativa várias vacinas.

E) Incorreta – a porta é a região de maior variação de temperatura e não deve conter vacinas.

5. REVISÃO DO CAPÍTULO

Resumo em tópicos: conceito e instâncias da Rede de Frio; faixas de temperatura; vacinas sensíveis ao congelamento e ao calor; câmara refrigerada e refrigerador doméstico; caixas térmicas e bobinas; termômetros e mapa de controle; prazos após abertura; manipulação; condutas em falhas e excursões de temperatura.

Quadro-resumo: +2 °C a +8 °C (ideal +5 °C); leitura no início e fim do expediente; BCG 6 h; febre amarela 6 h; tríplice viral 8 h; hepatite B multidose até 28 dias (conforme fabricante).

Pegadinhas: armazenar vacina na porta; usar bobina sem ambientar; congelar hepatite B ou DTP; descartar sem avaliação técnica.

Erros comuns: achar que vacinas vivas toleram calor; confundir os prazos da BCG e da tríplice viral.

ASSUNTO 13 – BIOSSEGURANÇA: PRECAUÇÕES PADRÃO, LIMPEZA E DESINFECÇÃO, HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS, EPI E GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS

1. RESUMO TEÓRICO

13.1 Conceito e base normativa

Biossegurança é o conjunto de ações voltadas para prevenir, minimizar ou eliminar riscos inerentes às atividades que possam comprometer a saúde humana, animal e o meio ambiente. A **NR 32** (Portaria MTE nº 485/2005) estabelece as diretrizes de segurança e saúde do trabalho nos serviços de saúde, determinando, entre outras medidas: **vacinação gratuita** dos trabalhadores (tétano, difteria, **hepatite B** e outras conforme o risco), proibição do **reencape** e da desconexão manual de agulhas, proibição de **adornos** (anéis, pulseiras, relógios, crachás pendurados) durante a assistência, proibição de fumar, comer e beber nos postos de trabalho, e de usar calçados abertos.

Classificação de riscos ocupacionais: físicos (ruído, radiação, temperatura), químicos (gases, quimioterápicos, desinfetantes), **biológicos** (vírus, bactérias, fungos – o risco mais característico da enfermagem), ergonômicos (postura, levantamento de peso, turnos) e de acidentes (perfurocortantes, quedas).

13.2 Precauções padrão e específicas

As **precauções padrão** devem ser aplicadas a **todos os pacientes**, independentemente do diagnóstico, sempre que houver risco de contato com sangue, fluidos corporais, secreções, excreções (exceto suor), pele não íntegra e mucosas. Incluem: higiene das mãos; uso de luvas, avental, máscara e óculos conforme o risco; descarte adequado de perfurocortantes; etiqueta respiratória.

Precauções baseadas na transmissão (somadas às precauções padrão):

Precaução	Tamanho das partículas / via	Exemplos de doenças	Medidas
Contato	Contato direto ou indireto	Bactérias multirresistentes (MRSA, KPC), *Clostridioides difficile*, escabiose, herpes-zóster localizado, diarreias infecciosas	Luvas e avental ao entrar no quarto; quarto privativo ou coorte; equipamentos exclusivos (estetoscópio, termômetro)
Gotículas	Partículas > 5 µm, alcance de cerca de 1 metro	**Meningite meningocócica**, coqueluche, influenza, caxumba, rubéola, difteria	**Máscara cirúrgica** para o profissional (a menos de 1 m) e para o paciente no transporte; quarto privativo ou distância de 1 m
Aerossóis	Partículas ≤ 5 µm, ficam suspensas no ar	**Tuberculose** pulmonar/laríngea, **sarampo**, **varicela** e herpes-zóster disseminado	**Máscara N95/PFF2** para o profissional; quarto privativo com porta fechada, pressão negativa e filtro HEPA, se disponível; máscara cirúrgica no paciente durante o transporte

13.3 Higienização das mãos

A **RDC ANVISA nº 42/2010** obriga a disponibilização de **preparação alcoólica** para fricção antisséptica das mãos nos pontos de assistência. Os **5 momentos** para a higiene das mãos (OMS):

- **1.** Antes de tocar o paciente.
- **2.** Antes de realizar procedimento limpo/asséptico.
- **3.** Após risco de exposição a fluidos corporais.
- **4.** Após tocar o paciente.
- **5.** Após tocar superfícies próximas ao paciente.

Técnica	Duração	Indicação
Fricção antisséptica com preparação alcoólica	**20 a 30 segundos**	Mãos sem sujidade visível (método preferencial na rotina)
Higiene simples com água e sabonete	**40 a 60 segundos**	Mãos visivelmente sujas ou com fluidos; após o banheiro; antes de comer; contato com *C. difficile* e outros esporulados (o álcool não elimina esporos)
Antissepsia cirúrgica	3 a 5 minutos (degermante)	Antes de procedimentos cirúrgicos

As **luvas não substituem** a higiene das mãos, que deve ser feita antes de calçá-las e após retirá-las.

13.4 Equipamentos de proteção individual (EPI)

EPI é todo dispositivo de uso individual destinado à proteção contra riscos à segurança e saúde no trabalho (NR 6). Deve ter **Certificado de Aprovação (CA)** e ser fornecido **gratuitamente** pelo empregador, que também deve treinar e fiscalizar o uso; o trabalhador deve usar, guardar e conservar o EPI.

Sequência de paramentação (colocação): avental → máscara (ou respirador) → óculos ou protetor facial → luvas.

Sequência de desparamentação (retirada): luvas → óculos/protetor facial → avental → máscara (retirada fora do quarto, pelas tiras) → higiene das mãos. Na retirada, o objetivo é tocar o mínimo possível nas partes externas contaminadas.

O respirador **N95/PFF2** deve passar por teste de vedação a cada uso e pode ser reutilizado pelo mesmo profissional, se íntegro, seco e limpo, conforme o protocolo da instituição.

13.5 Limpeza e desinfecção de superfícies

- **Limpeza concorrente:** diária, feita com o paciente internado, nas superfícies próximas (mobiliário, grades da cama, bancadas, pisos e equipamentos).
- **Limpeza terminal:** completa, após **alta, óbito ou transferência**, ou em internações longas (programada, em geral semanal ou quinzenal conforme a área), abrangendo paredes, teto, piso, mobiliário e equipamentos.

Princípios: do **mais limpo para o mais sujo**, de **cima para baixo**, de **dentro para fora** (do fundo do quarto em direção à porta) e em **sentido unidirecional**; usar técnica de **dois baldes** (um com solução e outro com água para enxágue) ou sistema de mop; **nunca varrer a seco** (dispersa microrganismos).

Matéria orgânica em superfícies (respingos de sangue): remover com papel absorvente usando luvas, depois limpar e aplicar desinfetante (como hipoclorito de sódio a 1% ou desinfetante padronizado), conforme o protocolo.

Desinfetantes de superfície mais usados: **álcool 70%** (fricção por cerca de 30 segundos em superfícies pequenas e limpas), **hipoclorito de sódio** (corrosivo para metais), quaternário de amônio, ácido peracético. A classificação de Spaulding para artigos foi detalhada no Assunto 2.

13.6 Gerenciamento de resíduos de serviços de saúde (RSS)

A **RDC ANVISA nº 222/2018** regulamenta as boas práticas de gerenciamento, e a **Resolução CONAMA nº 358/2005** trata do tratamento e da disposição final. Todo serviço deve ter um **Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde (PGRSS)**.

Grupo	Tipo	Exemplos	Acondicionamento / símbolo
A	Infectante (biológico)	Bolsas de sangue, culturas, peças anatômicas, materiais com sangue ou fluidos	Saco **branco leitoso** com símbolo de substância infectante
B	Químico	Medicamentos vencidos, quimioterápicos, reagentes, saneantes, mercúrio	Recipiente compatível, identificado com símbolo de risco químico (losango)
C	Radioativo	Rejeitos de medicina nuclear e radioterapia	Recipiente blindado, símbolo internacional de radiação (trifólio magenta/roxo)
D	Comum	Papel, restos de alimentos sem contato com fluidos, fraldas de uso comum (conforme legislação), gesso sem sangue	Saco preto ou cinza; recicláveis separados por cor
E	Perfurocortante	Agulhas, lâminas de bisturi, ampolas de vidro, lancetas	Caixa rígida, resistente à perfuração e vazamento, com símbolo de infectante e inscrição "perfurocortante"

A caixa de perfurocortante deve ser preenchida no máximo até **3/4** da capacidade (ou até a linha indicada pelo fabricante), mantida suspensa ou em suporte, longe do piso, e o descarte deve ser feito **imediatamente** após o uso, pelo próprio profissional, **sem reencapar** a agulha.

13.7 Acidente com material biológico

Conduta imediata: **lavar** exaustivamente o local com **água e sabão** (pele) ou **soro fisiológico/água** (mucosas); **não espremer**, não fazer cortes nem aplicar substâncias cáusticas (hipoclorito, éter). Comunicar a chefia imediatamente, procurar atendimento de referência para avaliação do risco, testagem do paciente-fonte (testes rápidos de HIV, hepatites B e C) e do acidentado, e início da **PEP** idealmente nas **2 primeiras horas** (no máximo 72 h). Notificar no **SINAN** e emitir a **CAT** (Comunicação de Acidente de Trabalho). Acompanhamento sorológico após o acidente.

2. PONTOS QUE MAIS CAEM EM PROVA

- NR 32: vacinação contra hepatite B, proibição de reencape e de adornos.
- Precauções padrão para todos os pacientes.
- Contato × gotículas (máscara cirúrgica) × aerossóis (N95) e exemplos.
- 5 momentos da higiene das mãos; tempos (álcool 20–30 s, água e sabão 40–60 s).
- Água e sabão em *C. difficile* e mãos visivelmente sujas.
- Sequência de colocação e retirada do EPI.
- Limpeza concorrente × terminal; do limpo para o sujo; nunca varrer a seco.
- Grupos de resíduos A a E (RDC 222/2018); caixa de perfurocortante até 3/4.

- Conduta no acidente com material biológico; PEP em até 72 h.

3. MACETES E DICAS DE MEMORIZAÇÃO

- **"Aerossol é TSV com N95"**: Tuberculose, Sarampo, Varicela.
- **"Gotícula é Gripe, Meningite e Coqueluche, com máscara cirúrgica"**.
- **"Contato é bactéria resistente, com luva e avental"**.
- **"ABQRCE": A biológico, B químico, C radioativo, D comum, E perfurocortante**.
- **"Luva sai primeiro, máscara sai por último"**.
- **"Furou? Lava, não espreme, comunica"**.
- **"Álcool não mata esporo"**: *C. difficile* pede água e sabão.

4. QUESTÕES

QUESTÃO 01

Paciente internado com suspeita de tuberculose pulmonar bacilífera deve ser mantido em precaução:

(A) de contato, com luvas e avental.
(B) por gotículas, com máscara cirúrgica para os profissionais.
(C) por aerossóis, com quarto privativo de porta fechada e uso de máscara N95/PFF2 pelos profissionais.
(D) padrão apenas, sem medidas adicionais.
(E) reversa, para proteção do paciente.

✔️ **GABARITO: C**

Comentário:

A) Incorreta – a precaução de contato é indicada para multirresistentes e outras doenças de transmissão por contato.

B) Incorreta – a máscara cirúrgica não protege contra aerossóis.

C) Correta – a TB pulmonar é transmitida por aerossóis e exige respirador N95/PFF2 e quarto privativo.

D) Incorreta – as precauções padrão são insuficientes nesse caso.

E) Incorreta – o isolamento reverso protege pacientes imunodeprimidos, como neutropênicos.

QUESTÃO 02

Segundo a RDC ANVISA nº 222/2018, agulhas, lâminas de bisturi e ampolas de vidro pertencem ao grupo:

(A) A.
(B) B.
(C) C.
(D) D.
(E) E.

✔️ **GABARITO: E**

Comentário:

A) Incorreta – o grupo A reúne resíduos com possível presença de agentes biológicos.

B) Incorreta – o grupo B reúne resíduos químicos.

C) Incorreta – o grupo C reúne rejeitos radioativos.

D) Incorreta – o grupo D é o de resíduos comuns.

E) Correta – o grupo E é o dos materiais perfurocortantes ou escarificantes.

QUESTÃO 03

Durante a retirada dos EPI ao sair do quarto de um paciente em precaução de contato e gotículas, a sequência recomendada é:

(A) máscara, avental, óculos e luvas.
(B) luvas, óculos ou protetor facial, avental, máscara e higiene das mãos.
(C) avental, luvas, máscara e óculos.
(D) óculos, máscara, luvas e avental.
(E) não há sequência definida.

✔️ **GABARITO: B**

Comentário:

A) Incorreta – retirar a máscara primeiro, com as luvas contaminadas, aumenta o risco de autocontaminação.

B) Correta – as luvas (mais contaminadas) saem primeiro e a máscara por último, seguida da higiene das mãos.

C) Incorreta – sequência inadequada.

D) Incorreta – sequência inadequada.

E) Incorreta – há sequência padronizada para reduzir a contaminação.

QUESTÃO 04

Após se furar com agulha utilizada em paciente, o técnico em enfermagem deve, de imediato:

(A) espremer o local para retirar o sangue contaminado.
(B) aplicar hipoclorito de sódio sobre o ferimento.
(C) lavar exaustivamente o local com água e sabão, comunicar a chefia e procurar o serviço de referência para avaliação da profilaxia.
(D) aguardar o fim do plantão para relatar o ocorrido.
(E) apenas cobrir o local com curativo.

✔️ **GABARITO: C**

Comentário:

A) Incorreta – espremer aumenta a área exposta e o risco de lesão.

B) Incorreta – substâncias cáusticas são contraindicadas.

C) Correta – lavagem, comunicação e avaliação rápida para PEP (idealmente em até 2 h, no máximo 72 h).

D) Incorreta – a demora compromete a eficácia da profilaxia.

E) Incorreta – é necessária avaliação do risco e notificação.

QUESTÃO 05

Sobre a higienização das mãos, é correto afirmar:

(A) o uso de luvas dispensa a higiene das mãos.

(B) a fricção com preparação alcoólica é indicada quando as mãos estão visivelmente sujas de sangue.

(C) a higiene com água e sabonete deve durar de 40 a 60 segundos e é obrigatória no cuidado a pacientes com *Clostridioides difficile*.

(D) a higiene das mãos só é necessária após tocar o paciente.

(E) a fricção alcoólica deve durar no mínimo 3 minutos.

✔️ **GABARITO: C**

Comentário:

A) Incorreta – as luvas não substituem a higiene das mãos.

B) Incorreta – com sujidade visível, a indicação é água e sabonete.

C) Correta – o álcool não elimina esporos; a lavagem com água e sabão remove mecanicamente o agente.

D) Incorreta – são cinco momentos, inclusive antes de tocar o paciente.

E) Incorreta – a fricção alcoólica dura de 20 a 30 segundos.

5. REVISÃO DO CAPÍTULO

Resumo em tópicos: biossegurança e NR 32; riscos ocupacionais; precauções padrão e por transmissão; higiene das mãos (RDC 42/2010, 5 momentos, técnicas); EPI e sequências; limpeza concorrente e terminal; resíduos (RDC 222/2018); acidente com material biológico.

Quadro-resumo: álcool 20–30 s; água e sabão 40–60 s; caixa de perfurocortante até 3/4; PEP em até 72 h; aerossóis – N95; gotículas – máscara cirúrgica.

Pegadinhas: reencapar agulha; máscara cirúrgica para tuberculose; álcool em mãos sujas; luva substituindo higiene; espremer o local do acidente.

Erros comuns: confundir grupo A com grupo E; varrer o piso a seco; retirar a máscara antes das luvas.

ASSUNTO 14 – FARMACOLOGIA APLICADA À ENFERMAGEM: PRINCÍPIOS BÁSICOS, CÁLCULOS, DILUIÇÕES E INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS

1. RESUMO TEÓRICO

14.1 Princípios básicos

Farmacocinética é o que o organismo faz com o fármaco: **absorção, distribuição, metabolização** (principalmente no **fígado**) e **excreção** (principalmente pelos **rins**). **Farmacodinâmica** é o que o fármaco faz no organismo (mecanismo de ação e efeitos).

Conceitos: **meia-vida** (tempo para a concentração plasmática cair pela metade), **efeito colateral** (efeito previsível além do desejado), **reação adversa**, **efeito tóxico** (dose excessiva), **tolerância** (necessidade de doses maiores para o mesmo efeito), **dependência**, **idiossincrasia** (resposta incomum, de origem genética), **efeito placebo**, **janela terapêutica** (faixa entre a dose eficaz e a tóxica – estreita em digoxina, lítio, fenitoína, aminofilina, varfarina).

Biodisponibilidade: a via **endovenosa** tem biodisponibilidade de **100%** e início de ação mais rápido. A via oral sofre o **efeito de primeira passagem** hepática. A via sublingual evita esse efeito (ex.: nitroglicerina/isossorbida).

Medicamentos potencialmente perigosos (alta vigilância – MPP): insulinas, anticoagulantes (heparina, varfarina), **cloreto de potássio concentrado** (nunca administrar em bolus – risco de parada cardíaca; sempre diluído e em infusão controlada), opioides, quimioterápicos, sedativos, bloqueadores neuromusculares, soluções hipertônicas (glicose 50%, cloreto de sódio 20%). Exigem dupla checagem e armazenamento diferenciado.

14.2 Grupos farmacológicos mais cobrados

Grupo	Exemplos	Cuidados de enfermagem
Analgésicos/antitérmicos	Dipirona, paracetamol	Paracetamol em altas doses é hepatotóxico
Anti-inflamatórios (AINEs)	Diclofenaco, ibuprofeno, cetoprofeno	Irritação gástrica (administrar após refeição); evitar na dengue
Opioides	Morfina, tramadol, fentanil	**Depressão respiratória**, constipação, retenção urinária; antídoto: **naloxona**
Anticoagulantes	Heparina (SC/EV), enoxaparina (SC), varfarina (oral)	Observar sangramentos; heparina SC sem aspirar e sem massagear; antídotos: **protamina** (heparina) e **vitamina K** (varfarina)
Diuréticos	Furosemida, hidroclorotiazida, espironolactona	Balanço hídrico, peso; furosemida e tiazídicos causam **hipopotassemia**; espironolactona poupa potássio
Cardiotônicos	Digoxina	Verificar pulso apical por 1 minuto; suspender e comunicar se < 60 bpm; sinais de intoxicação: náuseas, visão amarelada, arritmias
Antibióticos	Penicilinas, cefalosporinas, vancomicina	Respeitar horário rigoroso; perguntar sobre alergia;

		vancomicina infundida lentamente (no mínimo 60 min – risco de "síndrome do homem vermelho")
Broncodilatadores	Salbutamol, fenoterol, aminofilina	Taquicardia, tremores
Corticoides	Hidrocortisona, prednisona, dexametasona	Hiperglicemia, retenção hídrica; não suspender abruptamente após uso prolongado

14.3 Cálculos de medicamentos

Regra de três é a base. Exemplo: prescrição de 250 mg de um antibiótico; frasco de 500 mg diluído em 10 mL. 500 mg — 10 mL; 250 mg — x → x = **5 mL**.

Concentrações de soluções: a porcentagem indica **gramas em 100 mL**. Soro glicosado 5% = 5 g de glicose em 100 mL (50 g em 1.000 mL). Cloreto de sódio 0,9% = 0,9 g em 100 mL. Ampola de glicose 50% com 10 mL = 5 g. Ampola de KCl 19,1% com 10 mL = 1,91 g ≈ 25 mEq (2,5 mEq/mL). Ampola de NaCl 20% com 10 mL = 2 g.

Transformação de soro (aumentar a concentração): prescrição de SG 10% 500 mL tendo SG 5% 500 mL e ampolas de glicose 50% (10 mL). SG 10% 500 mL = 50 g; SG 5% 500 mL = 25 g; faltam 25 g. Ampola de 50%: 50 g em 100 mL → 25 g em **50 mL** (5 ampolas). Para manter o volume, desprezam-se 50 mL do soro antes de acrescentar (o volume desprezado também contém glicose; em provas, aplica-se o cálculo conforme o que a questão pedir).

Gotejamento:

- **Macrogotas:** nº de gotas/min = V ÷ (T × 3), com V em mL e T em horas (1 mL = 20 gotas).
- **Microgotas:** nº de microgotas/min = V ÷ T (1 mL = 60 microgotas); ou seja, microgotas/min = mL/h.
- Com tempo em minutos: gotas/min = (V × 20) ÷ minutos; microgotas/min = (V × 60) ÷ minutos.
- Relação: **1 gota = 3 microgotas**.

Exemplo 1: SF 0,9% 1.000 mL em 8 h → 1.000 ÷ (8 × 3) = 1.000 ÷ 24 ≈ **41,6 → 42 gotas/min**.

Exemplo 2: 500 mL em 6 h em microgotas → 500 ÷ 6 ≈ **83 microgotas/min**.

Exemplo 3: 100 mL de antibiótico em 30 min → (100 × 20) ÷ 30 ≈ **67 gotas/min**.

Bomba de infusão: programa-se em **mL/h**. Ex.: 1.000 mL em 24 h = 41,6 mL/h.

Penicilina G cristalina (unidades): frasco de 5.000.000 UI. Ao diluir em 8 mL de AD, o volume final fica em cerca de **10 mL** (o pó ocupa cerca de 2 mL). Logo, 5.000.000 UI — 10 mL. Para 2.000.000 UI → x = **4 mL**. Frasco de 1.000.000 UI: o pó acrescenta cerca de 0,4 mL ao volume.

Insulina: seringa de insulina graduada em unidades (100 UI/mL). Se houver só seringa de 3 mL ou 1 mL comum: 100 UI — 1 mL; 10 UI — x → x = **0,1 mL**.

Heparina: frasco de 5.000 UI/0,25 mL (SC) ou 5.000 UI/mL (EV). Prescrição de 2.500 UI com frasco de 5.000 UI/mL → **0,5 mL**.

Conversões úteis: 1 g = 1.000 mg; 1 mg = 1.000 mcg (µg); 1 L = 1.000 mL; 1 colher de sopa ≈ 15 mL; 1 colher de chá ≈ 5 mL.

14.4 Diluição e reconstituição

Reconstituir o pó com o diluente indicado (água destilada, SF 0,9% ou diluente próprio), homogeneizar sem formar espuma (rolar o frasco), observar a estabilidade após diluição, rotular com nome do paciente, medicamento, dose, diluente, volume, data, hora e responsável. Medicamentos fotossensíveis (nitroprussiato de sódio, anfotericina B) exigem equipo e frasco protegidos da luz.

14.5 Interações medicamentosas

Interação medicamentosa é a alteração do efeito de um fármaco causada por outro fármaco, alimento, bebida ou agente químico. Pode ser **sinérgica** (potencialização – aumento do efeito) ou **antagônica** (redução ou anulação do efeito), farmacocinética ou farmacodinâmica, e também físico-química (**incompatibilidade** na mesma seringa ou via – formação de precipitado, turvação, mudança de cor).

Exemplos clássicos:

- **Varfarina + AAS/AINEs:** aumento do risco de sangramento.
- **Varfarina + alimentos ricos em vitamina K** (verduras verde-escuras): redução do efeito anticoagulante – orientar consumo regular, sem excessos.
- **Álcool + benzodiazepínicos/opioides:** depressão do sistema nervoso central e respiratória.
- **Antiácidos e leite + tetraciclinas e ciprofloxacino:** redução da absorção do antibiótico (formação de quelatos com cálcio, magnésio, alumínio).
- **Rifampicina + anticoncepcional oral:** redução do efeito do anticoncepcional.
- **Diurético de alça + digoxina:** a hipopotassemia aumenta o risco de intoxicação digitálica.
- **IECA + espironolactona ou suplemento de potássio:** risco de **hiperpotassemia**.
- **Levotiroxina:** administrar em jejum, 30 a 60 minutos antes do café da manhã.
- **Sulfato ferroso:** absorção melhor com vitamina C (suco de laranja) e pior com leite, café e chá; orientar que as fezes podem ficar escuras.
- **Fenitoína:** incompatível com soro glicosado (precipita) – diluir apenas em **SF 0,9%**.

2. PONTOS QUE MAIS CAEM EM PROVA

- Farmacocinética (absorção, distribuição, metabolismo, excreção) × farmacodinâmica.
- Via EV com biodisponibilidade de 100%.
- Medicamentos de alta vigilância; KCl nunca em bolus.
- Antídotos: naloxona (opioide), protamina (heparina), vitamina K (varfarina), flumazenil (benzodiazepínico), gluconato de cálcio (sulfato de magnésio).
- Cálculos por regra de três; concentração de soros; transformação de soro.
- Fórmulas de gotejamento; 1 mL = 20 gotas = 60 microgotas.
- Penicilina cristalina: 5.000.000 UI em volume final de 10 mL.
- Interações: varfarina, tetraciclina com leite, fenitoína só com SF, levotiroxina em jejum.

3. MACETES E DICAS DE MEMORIZAÇÃO

- **"V sobre T vezes 3"**: macrogotas por minuto com tempo em horas.
- **"Microgota por minuto é igual a mL por hora"**.
- **"Uma gota vale três microgotas"**.
- **"Por cento é grama em cem mL"**.
- **"Potássio na veia, só diluído e devagar"**.
- **"NaPro-K": Naloxona-opioide, Protamina-heparina, vitamina K-varfarina**.
- **"Fenitoína odeia glicose"**.

4. QUESTÕES

QUESTÃO 01

Foi prescrito soro fisiológico 0,9% 1.500 mL para correr em 12 horas, em equipo de macrogotas. O gotejamento será de aproximadamente:

(A) 21 gotas/min.
(B) 42 gotas/min.
(C) 63 gotas/min.
(D) 125 gotas/min.
(E) 14 gotas/min.

✔️ **GABARITO: B**

Comentário:

A) Incorreta – valor correspondente a 750 mL em 12 h.

B) Correta – 1.500 ÷ (12 × 3) = 1.500 ÷ 36 ≈ 41,6 → 42 gotas/min.

C) Incorreta – erro no denominador.

D) Incorreta – esse seria o resultado em microgotas (1.500 ÷ 12 = 125 microgotas/min).

E) Incorreta – cálculo sem fundamento.

QUESTÃO 02

Prescrição: cefalotina 750 mg EV de 6/6 h. Disponível: frasco-ampola de 1 g, a ser diluído em 10 mL de água destilada. Quantos mL devem ser aspirados?

(A) 5 mL.
(B) 6,5 mL.
(C) 7,5 mL.
(D) 8 mL.
(E) 10 mL.

✔️ **GABARITO: C**

Comentário:

A) Incorreta – corresponderia a 500 mg.

B) Incorreta – erro de cálculo.

C) Correta – 1.000 mg — 10 mL; 750 mg — x → x = 7,5 mL.

D) Incorreta – corresponderia a 800 mg.

E) Incorreta – corresponderia à dose total de 1 g.

QUESTÃO 03

Prescrição: penicilina G cristalina 3.000.000 UI EV. Disponível: frasco de 5.000.000 UI. Ao reconstituir com 8 mL de água destilada, obtém-se volume final de 10 mL. Deve-se aspirar:

(A) 3 mL.
(B) 4,8 mL.
(C) 5 mL.
(D) 6 mL.
(E) 8 mL.

✔️ **GABARITO: D**

Comentário:

A) Incorreta – desconsidera a proporção.

B) Incorreta – esse valor seria obtido usando 8 mL como volume final, ignorando o volume do pó.

C) Incorreta – corresponderia a 2.500.000 UI.

D) Correta – 5.000.000 UI — 10 mL; 3.000.000 UI — x → x = 6 mL.

E) Incorreta – erro de cálculo.

QUESTÃO 04

O antídoto utilizado na intoxicação por heparina é:

(A) naloxona.
(B) flumazenil.
(C) sulfato de protamina.
(D) vitamina K.
(E) gluconato de cálcio.

✔️ **GABARITO: C**

Comentário:

A) Incorreta – a naloxona reverte opioides.

B) Incorreta – o flumazenil reverte benzodiazepínicos.

C) Correta – a protamina neutraliza a heparina.

D) Incorreta – a vitamina K é o antídoto da varfarina.

E) Incorreta – o gluconato de cálcio reverte a intoxicação por sulfato de magnésio.

QUESTÃO 05

Paciente em uso de varfarina recebe orientações do técnico em enfermagem. É orientação correta:

(A) usar ácido acetilsalicílico para dores de cabeça, pois potencializa o tratamento.
(B) consumir grande quantidade de verduras verde-escuras diariamente para melhorar o efeito.

(C) manter consumo regular e moderado de alimentos ricos em vitamina K e evitar anti-inflamatórios sem orientação médica, observando sinais de sangramento.
(D) suspender o medicamento quando houver sangramento gengival, sem comunicar a equipe.
(E) tomar o medicamento com leite para aumentar a absorção.

✔️ **GABARITO: C**

Comentário:

A) Incorreta – AAS aumenta o risco de sangramento.

B) Incorreta – o excesso de vitamina K reduz o efeito anticoagulante.

C) Correta – a regularidade da dieta e a vigilância de sangramentos são fundamentais.

D) Incorreta – sinais de sangramento devem ser comunicados à equipe.

E) Incorreta – não há essa recomendação para a varfarina.

5. REVISÃO DO CAPÍTULO

Resumo em tópicos: farmacocinética e farmacodinâmica; conceitos; medicamentos de alta vigilância; grupos farmacológicos e antídotos; regra de três; concentrações e transformação de soro; gotejamento; penicilina, insulina e heparina; diluição; interações e incompatibilidades.

Quadro-resumo: gotas/min = V ÷ (T × 3); microgotas/min = V ÷ T; 1 mL = 20 gotas = 60 microgotas; SG 5% = 5 g/100 mL; penicilina 5.000.000 UI em 10 mL; insulina 100 UI/mL.

Pegadinhas: KCl em bolus; esquecer o volume do pó da penicilina; confundir antídotos; diluir fenitoína em SG.

Erros comuns: multiplicar em vez de dividir no gotejamento; confundir mg com mcg; administrar digoxina com pulso abaixo de 60 bpm.

ASSUNTO 15 – ENFERMAGEM APLICADA À REALIZAÇÃO DE EXAMES E COLETA DE MATERIAIS BIOLÓGICOS

1. RESUMO TEÓRICO

15.1 Princípios gerais da coleta

- Conferir a **solicitação** e a **identificação do paciente** com pelo menos **dois identificadores** (nome completo e data de nascimento ou número do prontuário) – nunca pelo número do leito.
- Orientar o paciente sobre o exame e o preparo (jejum, dieta, suspensão de medicamentos quando prescrita).
- Higienizar as mãos e usar EPI (luvas de procedimento).
- **Identificar o frasco/tubo** na presença do paciente (nome, data, hora, tipo de material, responsável) – rotular o frasco, e não a tampa.
- Encaminhar o material ao laboratório o mais rápido possível, em condições adequadas (temperatura, proteção da luz quando necessário).
- Registrar o procedimento no prontuário.

Jejum: para exames de rotina, em geral de **8 horas** (mínimo) a **12 horas** (perfil lipídico, conforme laboratório). O jejum prolongado acima de 14 horas pode alterar resultados. A água é permitida.

15.2 Coleta de sangue venoso (flebotomia)

- Garrote a cerca de **7 a 10 cm acima** do local da punção, por no máximo **1 minuto** (o garroteamento prolongado causa hemoconcentração e altera resultados como potássio).
- Locais preferenciais: veias da **fossa antecubital** (mediana cubital, cefálica e basílica).
- Antissepsia com álcool 70% e aguardar secar; não palpar novamente o local após a antissepsia.
- Agulha com bisel voltado para cima, ângulo de 15° a 30°.
- Não coletar no membro com acesso venoso em infusão, fístula arteriovenosa ou do lado de mastectomia com esvaziamento axilar.
- Após a coleta: retirar o garrote **antes** de retirar a agulha, comprimir o local com algodão seco, **sem dobrar o braço**, por 1 a 2 minutos.

Ordem de coleta dos tubos no sistema a vácuo (CLSI):

Ordem	Tubo / tampa	Aditivo	Exames
1	Frasco de hemocultura	Meio de cultura	Hemocultura
2	Azul-claro	Citrato de sódio	Coagulação (TP, TTPA) – preencher até a marca (proporção 9:1)
3	Vermelho ou amarelo	Sem aditivo ou ativador de coágulo/gel separador	Bioquímica, sorologias (soro)
4	Verde	Heparina	Gasometria, alguns exames bioquímicos (plasma)
5	Roxo/lilás	**EDTA**	**Hemograma**, tipagem sanguínea, HbA1c
6	Cinza	Fluoreto de sódio + EDTA ou oxalato	**Glicemia**, lactato

Os tubos com aditivo devem ser **homogeneizados por inversão suave** (5 a 10 vezes, conforme o fabricante), **sem agitar** (agitar causa hemólise).

Hemocultura: coletar **antes do início do antibiótico**, com antissepsia rigorosa da pele (clorexidina alcoólica ou álcool 70% – aguardar secar) e desinfecção da tampa do frasco; em geral **2 amostras** (pares) de **sítios diferentes** de punção periférica; volume adequado ao frasco (adulto, em geral 8 a 10 mL por frasco); não coletar pelo cateter já instalado, salvo protocolo específico (pareada com periférica).

Gasometria arterial: punção preferencial da **artéria radial**, após o **teste de Allen** (avalia a circulação colateral pela artéria ulnar); seringa heparinizada, retirar bolhas de ar, vedar e encaminhar imediatamente (em gelo, se houver demora); comprimir o local por **5 minutos** (ou mais em anticoagulados). Valores de referência: pH 7,35–7,45; PaO2 80–100 mmHg; PaCO2 35–45 mmHg; HCO3 22–26 mEq/L. A punção arterial é atividade do enfermeiro ou do médico (conforme Parecer/Resolução do COFEN), cabendo ao técnico o preparo do material e a assistência.

Glicemia capilar: puncionar a **lateral da polpa digital** (menos terminações nervosas), desprezar a primeira gota quando recomendado pelo fabricante, não espremer excessivamente; em RN, a punção é feita na **lateral do calcanhar** (também local do teste do pezinho).

15.3 Coleta de urina

- **Urina tipo I (EAS – elementos anormais e sedimento):** preferencialmente a **primeira urina da manhã**, jato médio, frasco limpo, após higiene íntima com água e sabão.
- **Urocultura:** higiene íntima, desprezar o **primeiro jato** e coletar o **jato médio** em **frasco estéril**, sem tocar a parte interna; preferencialmente a primeira urina da manhã ou com pelo menos **2 a 4 horas de retenção**; encaminhar em até 1–2 horas ou refrigerar (2 °C a 8 °C) por até 24 h. Em paciente com sonda vesical de demora, a amostra deve ser coletada pelo **dispositivo próprio de coleta (porta de amostra) do sistema fechado**, com seringa e agulha estéreis após desinfecção com álcool 70% – **nunca da bolsa coletora** nem desconectando o sistema. Em lactentes sem controle esfincteriano, usa-se o saco coletor adesivo estéril (trocado a cada 30 minutos se não houver diurese) ou cateterismo.
- **Urina de 24 horas:** iniciar desprezando a **primeira urina** da manhã (anotando o horário), coletar todas as micções seguintes durante 24 horas e **incluir a primeira urina da manhã seguinte**, no mesmo horário do início; manter o frasco refrigerado ou com conservante conforme o exame.

15.4 Coleta de fezes e escarro

- **Parasitológico de fezes (EPF):** coletar em frasco limpo, sem contaminação com urina ou água do vaso; geralmente **3 amostras em dias alternados**; frasco com conservante quando indicado.
- **Coprocultura:** frasco estéril ou com meio de transporte (*swab* retal), antes do antibiótico.
- **Pesquisa de sangue oculto:** conforme o método, pode exigir dieta sem carne vermelha e suspensão de alguns medicamentos.
- **Escarro (baciloscopia para TB):** orientar a coletar **escarro** (e não saliva), após inspiração profunda e tosse forte, em **local aberto e ventilado** (longe de outras pessoas), em pote plástico descartável, com tampa de rosca; 1ª amostra no momento da consulta e 2ª na manhã seguinte, ao despertar, antes de escovar os dentes e em jejum (apenas enxaguar a boca com água); volume de 5 a 10 mL; proteger da luz e encaminhar logo (ou refrigerar).

15.5 Preparo para exames de imagem e outros procedimentos

- **Ultrassonografia de abdome total:** jejum de 6 a 8 horas; **bexiga cheia** para US pélvica/de vias urinárias (ingestão de água e não urinar antes).

▸ **Exames contrastados (tomografia, urografia):** jejum; perguntar sobre **alergias** (principalmente a iodo/contraste), função renal e uso de **metformina** (suspensa conforme protocolo pelo risco de acidose lática); hidratação após o exame.

▸ **Endoscopia digestiva alta:** jejum de 8 horas; retirar próteses dentárias; acompanhante (uso de sedação).

▸ **Colonoscopia:** dieta sem resíduos e limpeza intestinal com laxativo na véspera.

▸ **Ressonância magnética:** retirar todos os objetos metálicos; contraindicada em portadores de marca-passo não compatível e alguns implantes metálicos.

▸ **Eletrocardiograma (ECG):** paciente em decúbito dorsal, em repouso, pele limpa e seca; derivações precordiais: **V1** (4º espaço intercostal à direita do esterno), **V2** (4º EIC à esquerda do esterno), **V3** (entre V2 e V4), **V4** (5º EIC na linha hemiclavicular esquerda), **V5** (linha axilar anterior, mesmo nível de V4) e **V6** (linha axilar média, mesmo nível de V4). Eletrodos periféricos: **vermelho no braço direito, amarelo no braço esquerdo, verde na perna esquerda e preto na perna direita**.

▸ **Papanicolau:** ver orientações no Assunto 7.

2. PONTOS QUE MAIS CAEM EM PROVA

▸ Identificação com dois identificadores; rotular na presença do paciente.

▸ Garrote por no máximo 1 minuto; retirar o garrote antes da agulha; não dobrar o braço.

▸ Ordem dos tubos: hemocultura → citrato (azul) → soro (vermelho/amarelo) → heparina (verde) → EDTA (roxo) → fluoreto (cinza).

▸ EDTA = hemograma; fluoreto = glicemia; citrato = coagulação.

▸ Hemocultura antes do antibiótico, 2 amostras de sítios diferentes.

▸ Teste de Allen antes da gasometria radial.

▸ Urocultura: jato médio, frasco estéril; na SVD, coletar pelo dispositivo próprio, nunca da bolsa.

▸ Urina de 24 h: despreza a primeira e inclui a do dia seguinte.

▸ Escarro: amostra da manhã, em jejum, local ventilado.

▸ Posição dos eletrodos do ECG.

3. MACETES E DICAS DE MEMORIZAÇÃO

▸ **Ordem dos tubos: "Hemo Azul Vermelho Verde Roxo Cinza"** – "**H**oje **A**ndei **V**endo **V**árias **R**osas **C**inzas".

▸ **"Roxo conta células"**: EDTA para hemograma.

▸ **"Cinza guarda o açúcar"**: fluoreto para glicemia.

▸ **"Azul coagula"**: citrato para coagulação.

▸ **ECG periféricos: "Sol (amarelo) à esquerda, fogo (vermelho) à direita; grama (verde) no pé esquerdo, terra (preto) no pé direito"**.

▸ **"24 h: joga a primeira, guarda a última"**.

4. QUESTÕES

QUESTÃO 01

Para a realização de hemograma completo, o sangue deve ser coletado no tubo com tampa:

(A) azul-claro, com citrato de sódio.
(B) cinza, com fluoreto de sódio.
(C) roxa (lilás), com EDTA.
(D) vermelha, sem anticoagulante.
(E) verde, com heparina.

✔️ **GABARITO: C**

Comentário:

A) Incorreta – o citrato é usado para provas de coagulação.

B) Incorreta – o fluoreto é usado para glicemia.

C) Correta – o EDTA preserva a morfologia das células sanguíneas, sendo indicado para hemograma.

D) Incorreta – o tubo sem anticoagulante é usado para obter soro (bioquímica e sorologias).

E) Incorreta – a heparina é usada para gasometria e alguns exames bioquímicos.

QUESTÃO 02

Paciente com sonda vesical de demora tem solicitação de urocultura. A coleta deve ser feita:

(A) diretamente da bolsa coletora.
(B) desconectando a sonda do sistema coletor.
(C) pelo dispositivo próprio de coleta do sistema fechado, com seringa e agulha estéreis, após desinfecção com álcool 70%.
(D) após 24 horas de clampeamento da sonda.
(E) somente após a retirada da sonda.

✔️ **GABARITO: C**

Comentário:

A) Incorreta – a urina da bolsa está estagnada e contaminada.

B) Incorreta – desconectar o sistema quebra o circuito fechado e aumenta o risco de infecção.

C) Correta – a porta de amostra permite a coleta asséptica mantendo o sistema fechado.

D) Incorreta – o clampeamento prolongado não é indicado.

E) Incorreta – a coleta pode e deve ser feita com a sonda pelo dispositivo próprio.

QUESTÃO 03

Sobre a coleta de urina de 24 horas, é correto afirmar:

(A) deve-se guardar a primeira urina da manhã do primeiro dia e desprezar a do segundo dia.
(B) deve-se desprezar a primeira urina da manhã do primeiro dia, anotar o horário, coletar todas as micções seguintes e incluir a primeira urina do dia seguinte.
(C) basta coletar uma única amostra de jato médio.
(D) o frasco deve ser mantido em temperatura ambiente, exposto ao sol.
(E) não é necessário registrar o horário de início.

✔️ **GABARITO: B**

Comentário:

A) Incorreta – é o inverso: despreza-se a primeira do início e guarda-se a do dia seguinte.

B) Correta – assim se garante o volume exato de 24 horas.

C) Incorreta – a amostra isolada não substitui a de 24 h.

D) Incorreta – o frasco deve ser refrigerado ou conter conservante, conforme o exame.

E) Incorreta – o registro do horário é indispensável.

QUESTÃO 04

Antes da punção da artéria radial para coleta de gasometria, deve-se realizar o teste de:

(A) Rinne.
(B) Allen.
(C) Romberg.
(D) Lasègue.
(E) laço.

✔️ **GABARITO: B**

Comentário:

A) Incorreta – o teste de Rinne avalia a audição.

B) Correta – o teste de Allen avalia a circulação colateral da mão pela artéria ulnar.

C) Incorreta – o teste de Romberg avalia o equilíbrio.

D) Incorreta – o sinal de Lasègue avalia a irritação do nervo ciático.

E) Incorreta – a prova do laço avalia a fragilidade capilar (dengue).

QUESTÃO 05

Na realização do eletrocardiograma, o eletrodo da derivação V1 deve ser posicionado no:

(A) 5º espaço intercostal na linha hemiclavicular esquerda.
(B) 4º espaço intercostal na borda esternal direita.
(C) 4º espaço intercostal na borda esternal esquerda.

(D) 5º espaço intercostal na linha axilar média.
(E) 2º espaço intercostal na linha hemiclavicular direita.

✔️ **GABARITO: B**

Comentário:

A) Incorreta – esse é o local de V4.

B) Correta – V1 fica no 4º espaço intercostal, à direita do esterno.

C) Incorreta – esse é o local de V2.

D) Incorreta – esse é o local de V6.

E) Incorreta – não corresponde a derivação precordial padrão.

5. REVISÃO DO CAPÍTULO

Resumo em tópicos: princípios gerais de coleta; flebotomia e ordem dos tubos; hemocultura; gasometria e teste de Allen; glicemia capilar; urina (EAS, urocultura, 24 h); fezes; escarro; preparo para exames de imagem, endoscopia e ECG.

Quadro-resumo: garrote ≤ 1 min; EDTA – hemograma; fluoreto – glicemia; citrato – coagulação; hemocultura antes do antibiótico; gasometria – comprimir 5 min; urina de 24 h – despreza a primeira, inclui a do dia seguinte.

Pegadinhas: coletar urocultura da bolsa; agitar os tubos; identificar pelo leito; coletar saliva em vez de escarro.

Erros comuns: inverter a ordem dos tubos; dobrar o braço após a coleta; trocar V1 com V2.

ASSUNTO 16 – NOÇÕES DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA

1. RESUMO TEÓRICO

16.1 Nutrientes

Macronutrientes (fornecem energia):

Nutriente	Calorias por grama	Função	Fontes
Carboidratos	**4 kcal**	Principal fonte de energia	Arroz, pães, massas, tubérculos, frutas
Proteínas	**4 kcal**	Construção e reparação de tecidos (plástica), enzimas, anticorpos	Carnes, ovos, leite, leguminosas (feijão, lentilha)
Lipídios (gorduras)	**9 kcal**	Reserva de energia, absorção de vitaminas lipossolúveis, hormônios	Óleos, manteiga, castanhas, carnes gordas

Micronutrientes (vitaminas e minerais – função reguladora): vitaminas **lipossolúveis** (**A, D, E, K**) e **hidrossolúveis** (complexo B e C).

Micronutriente	Deficiência	Fontes
Vitamina A	Cegueira noturna, xeroftalmia	Fígado, cenoura, abóbora, manga
Vitamina D	Raquitismo (criança), osteomalácia (adulto)	Exposição solar, peixes, ovos
Vitamina K	Distúrbios de coagulação	Verduras verde-escuras
Vitamina C	Escorbuto (sangramento gengival)	Frutas cítricas, acerola, goiaba
Vitamina B12 e ácido fólico	Anemia megaloblástica; ácido fólico – defeitos do tubo neural	B12: carnes; folato: folhas verdes, feijão
Vitamina B1 (tiamina)	Beribéri; encefalopatia de Wernicke (etilistas)	Cereais integrais, carne de porco
Ferro	**Anemia ferropriva** (a mais comum)	Carnes vermelhas, fígado, feijão (melhor absorvido com vitamina C)
Iodo	Bócio, hipotireoidismo	**Sal iodado**, frutos do mar
Cálcio	Osteoporose	Leite e derivados

Fibras alimentares regulam o trânsito intestinal e ajudam no controle da glicemia e do colesterol. A água é essencial (cerca de 30 a 35 mL/kg/dia no adulto saudável).

16.2 Guia Alimentar para a População Brasileira (2014)

Classifica os alimentos pelo **grau de processamento**:

- **In natura ou minimamente processados:** devem ser a **base da alimentação** (frutas, legumes, verduras, arroz, feijão, ovos, leite, carnes frescas).
- **Ingredientes culinários processados:** óleos, gorduras, sal e açúcar – usar em **pequenas quantidades**.
- **Processados:** conservas, queijos, pães feitos com farinha, sal e fermento – **limitar** o consumo.
- **Ultraprocessados:** refrigerantes, biscoitos recheados, salgadinhos, embutidos, macarrão instantâneo – **evitar**.

A "regra de ouro" é: **prefira sempre alimentos in natura ou minimamente processados e preparações culinárias a alimentos ultraprocessados**.

16.3 Dietas hospitalares

Dieta	Consistência / características	Indicação
Geral (livre)	Sem restrições	Pacientes sem necessidade de modificação
Branda	Alimentos abrandados pela cocção, sem frituras	Transição para a dieta geral, dificuldade leve de mastigação, pós-operatório tardio
Pastosa	Alimentos amassados, em purê	Dificuldade de mastigação e deglutição, pós-operatório de cabeça e pescoço
Líquida-pastosa (semilíquida)	Líquidos e alimentos de consistência cremosa	Transição de líquida para pastosa
Líquida completa	Todos os alimentos líquidos (leite, sucos, sopas liquidificadas)	Pós-operatório, preparo de exames
Líquida restrita (de prova / clara)	Água, chás, caldos coados, gelatina, sucos coados sem resíduos	Primeira dieta após cirurgia, preparo de colonoscopia; deixa poucos resíduos
Zero (jejum)	Nada por via oral	Pré-operatório, preparo de exames, risco de broncoaspiração

Dietas especiais: hipossódica (HAS, ICC, cirrose, DRC), para diabéticos (controle de carboidratos simples e fracionamento – 5 a 6 refeições), hipolipídica (dislipidemia, pancreatite), hiperproteica (queimados, desnutridos, cicatrização), hipoproteica (DRC não dialítica, encefalopatia hepática), rica em fibras (constipação), sem glúten (doença celíaca), sem lactose (intolerância à lactose).

16.4 Nutrição enteral e parenteral

Nutrição enteral (NE): administração de dieta pelo trato gastrintestinal, por sonda (nasogástrica, nasoenteral, gastrostomia, jejunostomia), quando o paciente **não pode ou não deve se alimentar pela boca, mas tem o intestino funcionante**. Regulamentada pela **RDC ANVISA nº 503/2021** (que substituiu a RDC 63/2000).

Cuidados de enfermagem na NE:

- Confirmar o posicionamento da sonda antes de iniciar a dieta (radiografia, na sonda nasoenteral).
- Manter a **cabeceira elevada entre 30° e 45°** durante a infusão e por **30 a 60 minutos após** (prevenção de broncoaspiração).
- Conferir rótulo: nome do paciente, composição, volume, velocidade, data e hora de preparo e validade.
- Administração **intermitente** (gravitacional ou em bolus com seringa) ou **contínua** (bomba de infusão).
- **Lavar a sonda com 20 a 30 mL de água** filtrada (em adultos) antes e depois de cada dieta e de cada medicamento, para evitar obstrução.
- Não misturar medicamentos com a dieta; triturar apenas comprimidos que podem ser triturados (não triturar revestidos, de liberação prolongada ou sublinguais) e administrar cada um separadamente.
- Dieta em sistema aberto (frasco manipulado): tempo máximo de infusão de cerca de **4 horas** em temperatura ambiente; sistema fechado: até **24 horas** (conforme o fabricante).
- Observar complicações: **diarreia** (a mais comum), distensão abdominal, vômitos, resíduo gástrico elevado, broncoaspiração, deslocamento ou obstrução da sonda.
- Registrar volume infundido e aceitação.

Nutrição parenteral (NP): administração de nutrientes por **via endovenosa** (central ou periférica), quando o trato gastrintestinal **não pode ser usado** ou é insuficiente. Regulamentada pela Portaria SVS/MS nº 272/1998. Cuidados: via **exclusiva** do cateter para a NP (não administrar medicamentos

nem coletar sangue pela mesma via), uso obrigatório de **bomba de infusão**, **técnica asséptica rigorosa**, troca da bolsa e do equipo a cada **24 horas**, conservação sob refrigeração (2 °C a 8 °C) até o uso e retirada da geladeira cerca de 1 hora antes, proteção da luz quando houver vitaminas, **controle de glicemia capilar** (risco de hiperglicemia; a suspensão abrupta pode causar hipoglicemia), balanço hídrico e peso diário. Nunca acelerar a infusão para compensar atraso.

16.5 Avaliação nutricional

Medidas antropométricas: peso, altura, **IMC** (ver Assunto 9), circunferência abdominal, circunferência da panturrilha (idosos – < 31 cm indica perda de massa muscular), pregas cutâneas. No **idoso**, considera-se eutrofia o IMC entre **22 e 27 kg/m²** (critério de Lipschitz), baixo peso < 22 e sobrepeso > 27. Na criança, usam-se as curvas da OMS da Caderneta da Criança (peso/idade, estatura/idade, IMC/idade).

Desnutrição energético-proteica: marasmo (déficit calórico global – emagrecimento intenso, "aspecto de velho") e kwashiorkor (déficit predominantemente proteico – **edema**, alterações de cabelo e pele, hepatomegalia).

2. PONTOS QUE MAIS CAEM EM PROVA

- Calorias: carboidrato 4, proteína 4, lipídio 9 kcal/g.
- Vitaminas lipossolúveis A, D, E, K; deficiências clássicas (escorbuto, raquitismo, cegueira noturna).
- Anemia ferropriva; ferro e vitamina C.
- Guia Alimentar: base de alimentos in natura; evitar ultraprocessados.
- Consistências das dietas hospitalares; dieta líquida restrita como primeira após cirurgia.
- NE: cabeceira 30–45°, lavagem da sonda com água, diarreia como complicação mais comum.
- NP: via exclusiva, bomba de infusão, troca a cada 24 h, controle glicêmico.
- IMC do idoso (22–27).

3. MACETES E DICAS DE MEMORIZAÇÃO

- **"4-4-9"**: carboidrato, proteína, gordura.
- **"ADEK se dissolve em gordura"**.
- **"Escorbuto sangra a gengiva por falta de C"**.
- **"Intestino funciona? Use-o"**: enteral antes da parenteral.
- **"Parenteral tem via só dela"**.
- **"Kwashiorkor incha, marasmo seca"**.
- **"Idoso: 22 a 27 está bom"**.

4. QUESTÕES

QUESTÃO 01

Durante a administração de dieta enteral por sonda nasoenteral, constitui cuidado de enfermagem correto:

(A) manter o paciente em decúbito dorsal horizontal durante a infusão.
(B) manter a cabeceira elevada entre 30° e 45° durante a infusão e após o término, lavando a sonda com água antes e depois da dieta.
(C) misturar todos os medicamentos triturados ao frasco da dieta.
(D) iniciar a dieta antes da confirmação radiológica do posicionamento da sonda.
(E) acelerar a infusão para compensar atrasos.

✔️ **GABARITO: B**

Comentário:

A) Incorreta – o decúbito zero aumenta o risco de broncoaspiração.

B) Correta – a elevação da cabeceira previne broncoaspiração e a lavagem evita obstrução da sonda.

C) Incorreta – medicamentos não devem ser misturados à dieta, pelo risco de interação e obstrução.

D) Incorreta – a posição da sonda nasoenteral deve ser confirmada por radiografia.

E) Incorreta – infusão rápida causa diarreia, distensão e vômitos.

QUESTÃO 02

Em relação à nutrição parenteral, é correto afirmar:

(A) pode ser infundida pela mesma via usada para medicamentos e coleta de sangue.
(B) dispensa o uso de bomba de infusão.
(C) deve ser infundida por via exclusiva, com bomba de infusão, técnica asséptica rigorosa e controle da glicemia capilar.
(D) é indicada para pacientes com trato gastrintestinal funcionante e sem restrições.
(E) a bolsa pode permanecer instalada por 72 horas.

✔️ **GABARITO: C**

Comentário:

A) Incorreta – a via deve ser exclusiva pelo alto risco de contaminação e incompatibilidade.

B) Incorreta – a bomba de infusão é obrigatória para controle preciso.

C) Correta – são os cuidados essenciais da NP.

D) Incorreta – se o TGI funciona, a via enteral é preferida.

E) Incorreta – a bolsa e o equipo são trocados a cada 24 horas.

QUESTÃO 03

A deficiência de vitamina C provoca:

(A) raquitismo.
(B) escorbuto.
(C) beribéri.
(D) cegueira noturna.
(E) bócio.

✔️ **GABARITO: B**

Comentário:

A) Incorreta – o raquitismo decorre da deficiência de vitamina D.

B) Correta – o escorbuto, com sangramento gengival e má cicatrização, decorre da falta de vitamina C.

C) Incorreta – o beribéri está ligado à deficiência de vitamina B1.

D) Incorreta – a cegueira noturna está ligada à deficiência de vitamina A.

E) Incorreta – o bócio está ligado à deficiência de iodo.

QUESTÃO 04

No pós-operatório imediato de cirurgia abdominal, após liberação médica para início da alimentação, a primeira dieta geralmente oferecida é a:

(A) geral.
(B) branda.
(C) pastosa.
(D) líquida restrita (de prova).
(E) hiperproteica sólida.

✔️ **GABARITO: D**

Comentário:

A) Incorreta – a dieta geral é oferecida após a progressão.

B) Incorreta – a branda é etapa posterior.

C) Incorreta – a pastosa vem depois das dietas líquidas.

D) Correta – a dieta líquida restrita (água, chás, caldos coados) testa a tolerância do trato gastrintestinal.

E) Incorreta – a consistência sólida não é a primeira etapa.

QUESTÃO 05

Segundo o Guia Alimentar para a População Brasileira, a base da alimentação deve ser composta por:

(A) alimentos ultraprocessados enriquecidos com vitaminas.
(B) alimentos in natura ou minimamente processados.
(C) alimentos processados e conservas.

(D) óleos, sal e açúcar em grandes quantidades.
(E) suplementos alimentares industrializados.

✔️ **GABARITO: B**

Comentário:

A) Incorreta – os ultraprocessados devem ser evitados.

B) Correta – a regra de ouro do Guia é preferir alimentos in natura ou minimamente processados.

C) Incorreta – os processados devem ser limitados.

D) Incorreta – os ingredientes culinários devem ser usados em pequenas quantidades.

E) Incorreta – suplementos não são a base da alimentação saudável.

5. REVISÃO DO CAPÍTULO

Resumo em tópicos: macro e micronutrientes; deficiências vitamínicas e minerais; Guia Alimentar (2014); dietas hospitalares e especiais; nutrição enteral (RDC 503/2021) e parenteral; avaliação nutricional; desnutrição.

Quadro-resumo: 4-4-9 kcal/g; cabeceira 30–45° na NE; lavagem da sonda com 20–30 mL de água; NP – via exclusiva, troca a cada 24 h; IMC do idoso 22–27.

Pegadinhas: medicamentos misturados à dieta; NP pela mesma via de medicamentos; ultraprocessados enriquecidos como base da dieta.

Erros comuns: confundir vitaminas lipossolúveis e hidrossolúveis; esquecer a glicemia capilar na NP; usar IMC do adulto para idosos.

ASSUNTO 17 – POLÍTICA NACIONAL DE SEGURANÇA DO PACIENTE

1. RESUMO TEÓRICO

17.1 Marco legal

O **Programa Nacional de Segurança do Paciente (PNSP)** foi instituído pela **Portaria GM/MS nº 529/2013**, com o objetivo geral de contribuir para a qualificação do cuidado em saúde em **todos os estabelecimentos de saúde** do território nacional. A **RDC ANVISA nº 36/2013** institui ações para a segurança do paciente em serviços de saúde, tornando obrigatória a criação do **Núcleo de Segurança do Paciente (NSP)** e a elaboração do **Plano de Segurança do Paciente (PSP)**.

Objetivos específicos do PNSP: promover e apoiar a implementação de iniciativas voltadas à segurança do paciente, por meio dos Núcleos de Segurança do Paciente; envolver pacientes e familiares; ampliar o acesso da sociedade às informações; produzir, sistematizar e difundir conhecimentos; fomentar a inclusão do tema no ensino técnico, de graduação e pós-graduação.

17.2 Conceitos (Portaria 529/2013 e RDC 36/2013)

Termo	Definição
Segurança do paciente	Redução, a um mínimo aceitável, do risco de **dano desnecessário** associado ao cuidado de saúde
Dano	Comprometimento da estrutura ou função do corpo e/ou qualquer efeito dele oriundo, incluindo doenças, lesão, sofrimento, morte, incapacidade ou disfunção
Risco	Probabilidade de um incidente ocorrer
Incidente	Evento ou circunstância que poderia ter resultado, ou resultou, em dano desnecessário ao paciente
Evento adverso	**Incidente que resulta em dano** ao paciente
Near miss (quase erro)	Incidente que **não atingiu** o paciente (foi interceptado antes)
Incidente sem dano	Incidente que **atingiu** o paciente, mas **não causou dano**
Circunstância notificável	Situação com potencial significativo de causar dano, sem que tenha ocorrido incidente (ex.: desfibrilador quebrado)
Cultura de segurança	Conjunto de valores, atitudes, competências e comportamentos que determinam o comprometimento com a gestão da saúde e da segurança, **substituindo a culpa e a punição pela oportunidade de aprender com as falhas**
Gestão de risco	Aplicação sistêmica e contínua de políticas, procedimentos e recursos na identificação, análise, avaliação, comunicação e controle de riscos

17.3 As seis metas internacionais de segurança do paciente

Os **protocolos básicos** do Ministério da Saúde (Portarias nº 1.377/2013 e nº 2.095/2013) correspondem às metas da OMS:

Meta	Protocolo	Principais ações
1. Identificar corretamente o	Identificação do paciente	**Pulseira** de identificação

paciente		(preferencialmente branca) com pelo menos **2 identificadores** (nome completo e data de nascimento ou nome da mãe/nº do prontuário); **nunca usar número do leito** ou do quarto; confirmar antes de qualquer procedimento, medicação, coleta, transfusão; pulseiras de cores podem indicar alergia ou risco de queda conforme o protocolo institucional
2. Melhorar a comunicação entre profissionais	Comunicação efetiva	Ordens verbais apenas em emergências, com **"leitura de volta" (read back)**; passagem de plantão estruturada (método **SBAR/ISBAR**: Situação, Breve histórico, Avaliação, Recomendação)
3. Melhorar a segurança na prescrição, uso e administração de medicamentos	Medicamentos	**9 certos**; dupla checagem de medicamentos de alta vigilância; evitar abreviaturas (como "U" para unidades); separação de medicamentos com nomes e embalagens semelhantes
4. Assegurar cirurgia em local de intervenção, procedimento e paciente corretos	Cirurgia segura	**Lista de Verificação de Cirurgia Segura** (Entrada, Pausa, Saída – ver Assunto 2); demarcação da lateralidade pelo cirurgião
5. Higienizar as mãos para evitar infecções	Prática de higiene das mãos	**5 momentos**; preparação alcoólica no ponto de assistência (ver Assunto 13)
6. Reduzir o risco de quedas e lesões por pressão	Prevenção de quedas e de lesão por pressão	Avaliação do risco de queda (escala de **Morse**) e de LPP (escala de **Braden**); grades elevadas, campainha ao alcance, iluminação, calçados antiderrapantes, acompanhante; mudança de decúbito a cada 2 h, hidratação da pele

Os 9 certos da medicação (protocolo do MS): paciente certo, medicamento certo, via certa, hora certa, dose certa, registro certo, orientação certa, forma certa e resposta certa.

17.4 Notificação de incidentes

Os eventos adversos devem ser notificados ao **Sistema Nacional de Vigilância Sanitária (SNVS)** pelo **NSP**, por meio do sistema **Notivisa**. Prazos (RDC 36/2013):

- **Eventos adversos com óbito:** notificação em até **72 horas** a partir do ocorrido.
- **Never events** (eventos que nunca deveriam ocorrer – como cirurgia em local ou paciente errado, retenção de corpo estranho, óbito ou lesão grave por erro de medicação, LPP estágio 3 ou 4): notificação em até 72 h e investigação.
- **Demais eventos adversos:** notificação até o **15º dia útil do mês subsequente** ao mês de ocorrência.

Qualquer profissional pode e deve comunicar incidentes ao NSP da instituição. A notificação tem caráter **educativo e não punitivo**, focado na melhoria dos processos (análise de causa raiz, protocolo de Londres, diagrama de Ishikawa). Pacientes e familiares também podem notificar (Notivisa – módulo cidadão).

17.5 Atuação do técnico em enfermagem

- Conferir a identificação do paciente antes de **todo** cuidado.
- Aplicar os 9 certos e realizar dupla checagem nos medicamentos de alta vigilância.
- Comunicar e registrar incidentes e quase erros, sem medo de punição.
- Avaliar e registrar o risco de queda e de LPP, executando as medidas preventivas prescritas.
- Higienizar as mãos nos 5 momentos.
- Orientar e envolver o paciente e a família na própria segurança (perguntar o nome, informar alergias, chamar ajuda para levantar).

2. PONTOS QUE MAIS CAEM EM PROVA

- Portaria 529/2013 (PNSP) e RDC 36/2013 (NSP e PSP).
- Conceitos: incidente, evento adverso, near miss, incidente sem dano, circunstância notificável.
- As 6 metas e os protocolos correspondentes.
- Pulseira com 2 identificadores; nunca o número do leito.
- Ordem verbal com leitura de volta; SBAR.
- Escala de Morse (quedas) e de Braden (LPP).
- Notificação pelo Notivisa: óbito em 72 h; demais até o 15º dia útil do mês seguinte.
- Cultura de segurança não punitiva.

3. MACETES E DICAS DE MEMORIZAÇÃO

- **"6 metas: I-C-M-C-H-Q"**: Identificação, Comunicação, Medicamentos, Cirurgia, Higiene das mãos, Quedas e LPP.
- **"Evento adverso dói"**: é o incidente que causou dano.
- **"Near miss passou raspando"**: não chegou ao paciente.
- **"Leito muda, nome não"**: nunca identificar pelo leito.
- **"Morse cai, Braden machuca a pele"**.
- **"Óbito em 72 h"** de notificação.
- **"SBAR: Situação, Breve histórico, Avaliação, Recomendação"**.

4. QUESTÕES

QUESTÃO 01

O técnico em enfermagem preparou o medicamento para o paciente errado, mas percebeu o erro ao conferir a pulseira de identificação, antes da administração. Segundo a classificação de incidentes, trata-se de:

(A) evento adverso.
(B) near miss (quase erro).
(C) incidente sem dano.
(D) circunstância notificável.
(E) never event.

✔️ **GABARITO: B**

Comentário:

A) Incorreta – o evento adverso é o incidente que resulta em dano.

B) Correta – o incidente foi interceptado e não atingiu o paciente: near miss.

C) Incorreta – o incidente sem dano atinge o paciente, mas não causa dano.

D) Incorreta – a circunstância notificável não envolve incidente.

E) Incorreta – o medicamento não chegou a ser administrado.

QUESTÃO 02

Segundo o protocolo de identificação do paciente, é correto afirmar:

(A) o número do leito é um identificador seguro e suficiente.
(B) a pulseira deve conter pelo menos dois identificadores, como nome completo e data de nascimento, e ser conferida antes de qualquer procedimento.
(C) pacientes conscientes dispensam a pulseira de identificação.
(D) a conferência da identificação deve ser feita apenas na admissão.
(E) a pulseira deve conter apenas o diagnóstico médico.

✔️ **GABARITO: B**

Comentário:

A) Incorreta – o leito nunca deve ser usado como identificador.

B) Correta – são exigidos ao menos dois identificadores e a conferência antes de cada cuidado.

C) Incorreta – todos os pacientes internados devem usar pulseira.

D) Incorreta – a conferência deve ocorrer antes de cada procedimento.

E) Incorreta – o diagnóstico não é identificador e expõe o paciente.

QUESTÃO 03

A instituição do Núcleo de Segurança do Paciente nos serviços de saúde tornou-se obrigatória com a:

(A) Lei nº 8.080/1990.
(B) RDC ANVISA nº 36/2013.
(C) Portaria nº 1.820/2009.
(D) NR 32.
(E) Lei nº 7.498/1986.

✔️ **GABARITO: B**

Comentário:

A) Incorreta – a Lei 8.080/1990 é a Lei Orgânica da Saúde.

B) Correta – a RDC 36/2013 determina a criação do NSP e do Plano de Segurança do Paciente.

C) Incorreta – a Portaria 1.820/2009 trata dos direitos dos usuários.

D) Incorreta – a NR 32 trata da segurança do trabalhador.

E) Incorreta – a Lei 7.498/1986 regula o exercício da enfermagem.

QUESTÃO 04

A escala utilizada para avaliar o risco de quedas em pacientes hospitalizados é a escala de:

(A) Braden.
(B) Glasgow.
(C) Morse.
(D) Apgar.
(E) Aldrete e Kroulik.

✔️ **GABARITO: C**

Comentário:

A) Incorreta – Braden avalia o risco de lesão por pressão.

B) Incorreta – Glasgow avalia o nível de consciência.

C) Correta – a escala de Morse avalia o risco de quedas.

D) Incorreta – Apgar avalia a vitalidade do recém-nascido.

E) Incorreta – Aldrete e Kroulik avaliam a recuperação pós-anestésica.

QUESTÃO 05

Em relação à notificação de eventos adversos, segundo a RDC ANVISA nº 36/2013, é correto afirmar:

(A) eventos adversos que evoluírem para óbito devem ser notificados em até 72 horas a partir do ocorrido.
(B) a notificação tem caráter punitivo e serve para identificar o profissional culpado.
(C) apenas os médicos podem comunicar incidentes ao NSP.

(D) eventos adversos sem óbito não precisam ser notificados.

(E) a notificação deve ser feita ao Conselho Regional de Enfermagem.

✔️ **GABARITO: A**

Comentário:

A) Correta – eventos com óbito são notificados em até 72 h; os demais até o 15º dia útil do mês subsequente.

B) Incorreta – a cultura de segurança é não punitiva e voltada à aprendizagem.

C) Incorreta – qualquer profissional pode e deve comunicar incidentes.

D) Incorreta – todos os eventos adversos devem ser notificados.

E) Incorreta – a notificação é feita ao SNVS pelo Notivisa.

5. REVISÃO DO CAPÍTULO

Resumo em tópicos: PNSP (Portaria 529/2013); RDC 36/2013 (NSP e PSP); conceitos; seis metas e protocolos; 9 certos; notificação (Notivisa e prazos); cultura de segurança; atuação do técnico.

Quadro-resumo: 6 metas; 2 identificadores; SBAR; Morse – quedas; Braden – LPP; óbito – notificação em 72 h; demais – até o 15º dia útil do mês seguinte.

Pegadinhas: chamar near miss de evento adverso; identificar pelo leito; achar que a notificação é punitiva.

Erros comuns: confundir Morse e Braden; trocar a Portaria 529/2013 pela RDC 36/2013.

ASSUNTO 18 – COMISSÃO DE CONTROLE DE INFECÇÕES RELACIONADAS À ASSISTÊNCIA À SAÚDE (CCIRAS)

1. RESUMO TEÓRICO

18.1 Base legal

A **Lei nº 9.431/1997** obriga os hospitais do país a manter um **Programa de Controle de Infecções Hospitalares (PCIH)** e a criar uma **Comissão de Controle de Infecções Hospitalares (CCIH)**. A **Portaria GM/MS nº 2.616/1998** regulamenta as diretrizes e normas para a prevenção e o controle das infecções hospitalares. Com a ampliação do conceito para **Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde (IRAS)** – que podem ocorrer em hospitais, ambulatórios, serviços de diálise, atenção domiciliar e outros –, muitos serviços e estados passaram a usar a denominação **CCIRAS**. A ANVISA coordena o **Programa Nacional de Prevenção e Controle de IRAS (PNPCIRAS)**.

Programa de Controle de Infecção Hospitalar (PCIH): conjunto de ações desenvolvidas deliberada e sistematicamente com vistas à redução máxima possível da incidência e da gravidade das infecções hospitalares.

18.2 Composição da comissão (Portaria 2.616/1998)

A CCIH/CCIRAS é composta por dois tipos de membros:

Tipo	Quem são	Função
Membros consultores	Representantes dos serviços **médico, de enfermagem, de farmácia, de microbiologia (laboratório) e da administração**	Definem as diretrizes, aprovam o programa e as normas
Membros executores	Representam o **Serviço de Controle de Infecção Hospitalar (SCIH)**; no mínimo **2 técnicos de nível superior** da área da saúde para cada **200 leitos** ou fração, sendo **1 deles preferencialmente enfermeiro**	Executam as ações programadas do controle de infecção

Carga horária mínima dos executores: **6 horas diárias** para o enfermeiro e **4 horas diárias** para os demais profissionais, com ampliação nos hospitais com leitos destinados a pacientes críticos (UTI, berçário de alto risco, queimados, transplante, onco-hematologia, aids): a comissão deve ser acrescida de outros profissionais de nível superior, e os executores têm **2 horas semanais** a mais para cada **10 leitos críticos** ou fração.

O **presidente** da comissão é indicado pela direção da instituição, e a comissão deve ter regimento interno.

18.3 Competências da CCIH/CCIRAS

- Elaborar, implementar, manter e avaliar o **programa de controle de infecção**, adequado às características da instituição.
- Implantar e manter um **sistema de vigilância epidemiológica** das infecções, preferencialmente **busca ativa** (método recomendado pela portaria).

- Realizar **investigação epidemiológica de casos e surtos**, implantando medidas imediatas de controle.
- Elaborar e divulgar **relatórios periódicos** com taxas e indicadores à direção e às chefias.
- Propor e cooperar na elaboração de **normas e rotinas técnico-operacionais** (precauções, isolamento, limpeza, processamento de artigos, procedimentos invasivos).
- Promover **treinamento e capacitação** dos profissionais (educação permanente).
- Elaborar a **política de uso racional de antimicrobianos**, germicidas e materiais médico-hospitalares, em conjunto com a farmácia (controle de antibióticos restritos, padronização).
- **Notificar** ao órgão de gestão do SUS os casos de doenças de notificação compulsória e surtos diagnosticados ou suspeitos.
- Definir, junto à CME e ao serviço de limpeza, a padronização de **saneantes** e de processamento de artigos.
- Cooperar com a ação de fiscalização da vigilância sanitária.

18.4 Vigilância e indicadores de IRAS

Classificação clássica das infecções (Portaria 2.616/1998):

- **Infecção comunitária (IC):** constatada ou em incubação no ato de admissão, desde que não relacionada a internação anterior no mesmo hospital. Também é comunitária a infecção do RN transmitida por via **transplacentária** (toxoplasmose, rubéola, sífilis, citomegalovírus, HIV) e a associada a **bolsa rota superior a 24 horas**.
- **Infecção hospitalar (IH):** adquirida após a admissão do paciente, manifestada durante a internação ou após a alta, quando puder ser relacionada à internação ou a procedimentos hospitalares. Critério prático: manifestação após **72 horas** da admissão quando o período de incubação for desconhecido; antes de 72 h, quando associada a procedimentos invasivos realizados após a admissão. No RN, são hospitalares todas as infecções, **exceto** as transmitidas de forma transplacentária e as associadas à bolsa rota > 24 h.

Principais indicadores:

- **Taxa de infecção hospitalar** = (nº de infecções hospitalares ÷ nº de saídas – altas, óbitos e transferências) × 100.
- **Taxa de pacientes com infecção** = (nº de pacientes com IH ÷ nº de saídas) × 100.
- **Densidade de incidência** de infecções associadas a dispositivos = (nº de infecções ÷ nº de **paciente-dia** em uso do dispositivo) × 1.000. Ex.: IPCS por 1.000 cateteres centrais-dia; PAV por 1.000 ventiladores mecânicos-dia; ITU por 1.000 sondas vesicais-dia.
- **Taxa de utilização de dispositivo** = dispositivo-dia ÷ paciente-dia.
- Taxa de infecção de sítio cirúrgico por **potencial de contaminação** da cirurgia (limpa, potencialmente contaminada, contaminada e infectada). A taxa de ISC em **cirurgias limpas** é o melhor indicador da qualidade da assistência cirúrgica (esperada abaixo de 2% a 5%).
- Perfil de sensibilidade microbiana e consumo de antimicrobianos.

18.5 Classificação das cirurgias por potencial de contaminação

Classe	Definição	Exemplos
Limpa	Tecidos estéreis ou de fácil descontaminação, sem processo infeccioso e sem penetração em tratos colonizados	Cirurgias cardíacas, neurocirurgias, ortopédicas sem fratura exposta, herniorrafia, tireoidectomia
Potencialmente contaminada	Penetração em tratos digestório, respiratório ou urinário com colonização, sem contaminação significativa	Colecistectomia sem inflamação aguda, histerectomia, cirurgias gástricas
Contaminada	Tecidos recentemente	Cirurgias de cólon, fratura exposta

	traumatizados e abertos, colonizados por flora abundante, ou com falha técnica grosseira	recente, apendicite sem perfuração
Infectada	Presença de processo infeccioso ou tecido necrótico	Apendicite supurada/perfurada, drenagem de abscesso, fratura exposta antiga

18.6 Participação do técnico em enfermagem

O técnico em enfermagem **não integra a CCIH como membro executor** (exigência de nível superior), mas é peça fundamental na prevenção: adere às rotinas e protocolos (higiene das mãos, precauções, bundles, técnica asséptica), comunica à CCIH sinais de infecção e surtos, participa dos treinamentos, colabora com a coleta de culturas e com a manutenção de dispositivos invasivos e orienta pacientes e familiares.

2. PONTOS QUE MAIS CAEM EM PROVA

- Lei 9.431/1997 (obrigatoriedade) e Portaria 2.616/1998 (regulamentação).
- Membros consultores (médico, enfermagem, farmácia, microbiologia, administração) × executores (SCIH).
- 2 técnicos de nível superior por 200 leitos, 1 preferencialmente enfermeiro; enfermeiro 6 h/dia.
- Competências: programa, vigilância (busca ativa), surtos, uso racional de antimicrobianos, treinamento, notificação.
- Infecção comunitária × hospitalar; critério de 72 h; exceções no RN.
- Indicadores: taxa de IH e densidade de incidência por 1.000 dispositivos-dia.
- Classificação das cirurgias (limpa, potencialmente contaminada, contaminada, infectada).

3. MACETES E DICAS DE MEMORIZAÇÃO

- **"Lei 9.431 cria, Portaria 2.616 detalha"**.
- **Consultores: "MEFMA"** – Médico, Enfermagem, Farmácia, Microbiologia, Administração.
- **"Dois para duzentos"**: 2 executores de nível superior para cada 200 leitos.
- **"Enfermeiro 6, os outros 4"**: horas diárias dos executores.
- **"72 h separam a comunidade do hospital"**.
- **"Bebê nasceu com a infecção da placenta? Comunitária"**.
- **"Limpa mede a qualidade"**: taxa de ISC em cirurgias limpas.

4. QUESTÕES

QUESTÃO 01

A lei que tornou obrigatória a manutenção de um Programa de Controle de Infecções Hospitalares pelos hospitais do país é a:

(A) Lei nº 8.080/1990.
(B) Lei nº 9.431/1997.
(C) Lei nº 7.498/1986.
(D) Lei nº 10.216/2001.
(E) Lei nº 8.142/1990.

✔️ **GABARITO: B**

Comentário:

A) Incorreta – é a Lei Orgânica da Saúde.

B) Correta – a Lei 9.431/1997 obriga os hospitais a manter o PCIH.

C) Incorreta – trata do exercício profissional da enfermagem.

D) Incorreta – trata da saúde mental.

E) Incorreta – trata da participação da comunidade e do financiamento do SUS.

QUESTÃO 02

Conforme a Portaria nº 2.616/1998, os membros executores da CCIH representam o Serviço de Controle de Infecção Hospitalar e devem ser, no mínimo:

(A) 1 técnico de enfermagem para cada 50 leitos.
(B) 2 técnicos de nível superior da área da saúde para cada 200 leitos ou fração, sendo um deles preferencialmente enfermeiro.
(C) 5 médicos infectologistas por hospital.
(D) 1 administrador para cada 100 leitos.
(E) representantes de todos os setores, sem exigência de formação.

✔️ **GABARITO: B**

Comentário:

A) Incorreta – os executores são de nível superior.

B) Correta – é o dimensionamento mínimo da portaria.

C) Incorreta – não há essa exigência.

D) Incorreta – o administrador integra os membros consultores.

E) Incorreta – há exigência de nível superior na área da saúde.

QUESTÃO 03

Paciente internado para tratamento clínico desenvolve pneumonia no 5º dia de internação, sem evidência de que estivesse em incubação na admissão. Essa infecção é classificada como:

(A) comunitária.
(B) hospitalar (relacionada à assistência).
(C) transplacentária.
(D) endógena comunitária.
(E) não classificável.

✔️ **GABARITO: B**

Comentário:

A) Incorreta – a infecção comunitária está presente ou em incubação na admissão.

B) Correta – manifestação após 72 h da admissão, sem incubação prévia, caracteriza infecção hospitalar.

C) Incorreta – transplacentária refere-se a infecções do recém-nascido.

D) Incorreta – a origem endógena não define a classificação como comunitária.

E) Incorreta – a classificação é possível pelos critérios da portaria.

QUESTÃO 04

Uma herniorrafia inguinal eletiva, sem processo infeccioso e sem abertura de tratos colonizados, é classificada como cirurgia:

(A) limpa.
(B) potencialmente contaminada.
(C) contaminada.
(D) infectada.
(E) suja.

✔️ **GABARITO: A**

Comentário:

A) Correta – não há penetração em tratos colonizados nem infecção, caracterizando cirurgia limpa.

B) Incorreta – a potencialmente contaminada envolve abertura de tratos colonizados.

C) Incorreta – a contaminada envolve tecidos traumatizados ou falhas técnicas grosseiras.

D) Incorreta – a infectada envolve processo infeccioso presente.

E) Incorreta – "suja" não é a denominação adotada pela Portaria 2.616/1998, que utiliza "infectada".

QUESTÃO 05

Entre as competências da CCIH/CCIRAS, inclui-se:

(A) prescrever antibióticos para todos os pacientes internados.

(B) realizar a vigilância epidemiológica das infecções, investigar surtos e definir a política de uso racional de antimicrobianos.
(C) realizar diretamente a limpeza terminal dos quartos.
(D) punir os profissionais responsáveis pelas infecções.
(E) substituir a vigilância sanitária municipal.

✔️ **GABARITO: B**

Comentário:

A) Incorreta – a CCIH orienta o uso racional, mas a prescrição é do médico assistente.

B) Correta – vigilância, investigação de surtos e política de antimicrobianos são competências da comissão.

C) Incorreta – a limpeza é executada pelo serviço de higienização, com normas propostas pela CCIH.

D) Incorreta – o foco é a prevenção e a educação, não a punição.

E) Incorreta – a CCIH coopera com a vigilância sanitária, sem substituí-la.

5. REVISÃO DO CAPÍTULO

Resumo em tópicos: Lei 9.431/1997 e Portaria 2.616/1998; PCIH; composição (consultores e executores); competências; classificação das infecções; indicadores; classificação das cirurgias; participação do técnico.

Quadro-resumo: 2 executores de nível superior para 200 leitos; enfermeiro 6 h/dia; IH após 72 h; densidade de incidência por 1.000 dispositivos-dia; ISC em cirurgia limpa como indicador de qualidade.

Pegadinhas: técnico como membro executor; achar que a CCIH prescreve antibióticos; classificar infecção transplacentária do RN como hospitalar.

Erros comuns: confundir consultores com executores; inverter a Lei 9.431 e a Portaria 2.616.

ASSUNTO 19 – SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE

1. RESUMO TEÓRICO

19.1 Conceitos

Sistema de Informação em Saúde (SIS) é o conjunto de componentes que atuam de forma integrada para **coletar, processar, armazenar, analisar e disseminar** dados e informações, com o objetivo de apoiar o planejamento, a tomada de decisões, o monitoramento e a avaliação das ações e serviços de saúde. O **DATASUS** (Departamento de Informação e Informática do SUS) é o órgão do Ministério da Saúde responsável pelo desenvolvimento e manutenção dos principais sistemas nacionais.

Diferença: **dado** é o registro bruto (ex.: número de nascidos vivos); **informação** é o dado processado e contextualizado (ex.: taxa de natalidade); **indicador** é a medida-síntese que reflete aspectos da saúde de uma população (ex.: coeficiente de mortalidade infantil).

A Lei nº 8.080/1990 prevê a organização de um **Sistema Nacional de Informações em Saúde**, integrado em todo o território nacional, abrangendo questões epidemiológicas e de prestação de serviços.

19.2 Principais sistemas nacionais

Sistema	Documento-base	Finalidade
SIM – Sistema de Informações sobre Mortalidade	**Declaração de Óbito (DO)**	Registra os óbitos; base para os indicadores de mortalidade. A DO é preenchida pelo **médico** em 3 vias
SINASC – Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos	**Declaração de Nascido Vivo (DNV)**	Registra os nascimentos (peso ao nascer, idade gestacional, tipo de parto, Apgar, consultas de pré-natal). A DNV pode ser preenchida por profissional de saúde (médico, enfermeiro, parteira) responsável pela assistência ao parto
SINAN – Sistema de Informação de Agravos de Notificação	**Ficha de Notificação** e **Ficha de Investigação**	Registra doenças e agravos de notificação compulsória
SIH/SUS – Sistema de Informações Hospitalares	**AIH** – Autorização de Internação Hospitalar	Registra as internações financiadas pelo SUS; base para o pagamento hospitalar
SIA/SUS – Sistema de Informações Ambulatoriais	**BPA** (Boletim de Produção Ambulatorial) e **APAC** (Autorização de Procedimentos de Alta Complexidade)	Registra a produção ambulatorial
SI-PNI – Sistema de Informação do PNI	Registro do vacinado	Registra doses aplicadas, estoque e eventos adversos pós-vacinação, por indivíduo
SISVAN – Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional	Marcadores de consumo alimentar e antropometria	Monitora o estado nutricional da população
SISAB – Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica	Dados enviados pela **estratégia e-SUS APS** (Coleta de Dados Simplificada – **CDS** – e **Prontuário Eletrônico do Cidadão – PEC**)	Substituiu o **SIAB** (Sistema de Informação da Atenção Básica) a partir de 2013; registra as ações da atenção primária de forma individualizada (pelo CPF/CNS)
CNES – Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde	Ficha cadastral do estabelecimento	Cadastra estabelecimentos, profissionais, leitos e

		equipamentos
SISCAN	Requisições de exames citopatológicos, histopatológicos e mamografias	Rastreamento do câncer do colo do útero e de mama (integrou o SISCOLO e o SISMAMA)
GAL – Gerenciador de Ambiente Laboratorial	Requisição de exames	Gerencia exames dos laboratórios de saúde pública (LACEN)
Notivisa	Notificação de incidentes e queixas técnicas	Vigilância sanitária (eventos adversos, queixas técnicas de produtos)

Cartão Nacional de Saúde (CNS – Cartão SUS): identifica o usuário do SUS; atualmente, o **CPF** pode ser usado como identificador. A **Rede Nacional de Dados em Saúde (RNDS)**, plataforma nacional de interoperabilidade, integra dados como vacinação e exames, disponíveis ao cidadão pelo aplicativo **Meu SUS Digital** (antigo Conecte SUS).

19.3 Indicadores mais cobrados

- **Coeficiente de mortalidade infantil** = (óbitos de menores de 1 ano ÷ nascidos vivos no ano) × 1.000 – usa dados do **SIM** (numerador) e do **SINASC** (denominador). Componentes: neonatal precoce (0 a 6 dias), neonatal tardia (7 a 27 dias) e pós-neonatal (28 dias a menos de 1 ano).
- **Razão de mortalidade materna** = (óbitos maternos ÷ nascidos vivos) × 100.000. Óbito materno: durante a gestação ou até **42 dias** após o término, por causa relacionada à gravidez (não acidental).
- **Coeficiente de natalidade** = (nascidos vivos ÷ população) × 1.000.
- **Coeficiente de incidência** e de **prevalência** (ver Assunto 10).
- **Cobertura vacinal** = (doses do esquema completo aplicadas ÷ população-alvo) × 100.
- **Proporção de nascidos vivos com baixo peso** (< 2.500 g).

19.4 Uso dos sistemas pela enfermagem

O técnico em enfermagem alimenta vários sistemas no dia a dia: registra as vacinas no **SI-PNI**/e-SUS, preenche fichas do **e-SUS APS** (atendimento, procedimentos, visitas), colabora no preenchimento da ficha de notificação do **SINAN** e registra procedimentos que geram produção no SIA. A qualidade do dado depende do registro **completo, correto e oportuno**: dados mal preenchidos geram indicadores incorretos e prejudicam o planejamento e o financiamento.

19.5 Proteção de dados

A **Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD – Lei nº 13.709/2018)** classifica os dados de saúde como **dados pessoais sensíveis**, cujo tratamento exige cuidados especiais. É vedado compartilhar senhas de acesso aos sistemas, e o profissional responde pelo uso indevido de informações. O acesso deve ser restrito ao necessário para a assistência (ver Assunto 20 – sigilo profissional).

2. PONTOS QUE MAIS CAEM EM PROVA

- SIM – Declaração de Óbito; SINASC – Declaração de Nascido Vivo; SINAN – Ficha de Notificação.
- SIH – AIH; SIA – BPA e APAC.
- SISAB/e-SUS APS substituiu o SIAB.
- SI-PNI – registro nominal de vacinação.
- CNES – cadastro de estabelecimentos e profissionais.
- Mortalidade infantil usa SIM + SINASC (× 1.000 nascidos vivos).

- Mortalidade materna até 42 dias (× 100.000 nascidos vivos).
- LGPD: dado de saúde é sensível.

3. MACETES E DICAS DE MEMORIZAÇÃO

- **"SIM morre, SINASC nasce, SINAN notifica"**.
- **"AIH interna, APAC é alta complexidade ambulatorial"**.
- **"SIAB morreu, nasceu o SISAB"** (com o e-SUS).
- **"Mortalidade infantil: morto do SIM sobre vivo do SINASC"**.
- **"Materna até 42 dias, por 100 mil"**.
- **"CNES conta prédios, gente e leitos"**.

4. QUESTÕES

QUESTÃO 01

O sistema de informação cujo documento-base é a Declaração de Nascido Vivo é o:

(A) SIM.
(B) SINAN.
(C) SINASC.
(D) SIH/SUS.
(E) CNES.

✔️ **GABARITO: C**

Comentário:

A) Incorreta – o SIM usa a Declaração de Óbito.

B) Incorreta – o SINAN usa as fichas de notificação e investigação.

C) Correta – o SINASC registra os nascimentos a partir da DNV.

D) Incorreta – o SIH usa a Autorização de Internação Hospitalar.

E) Incorreta – o CNES cadastra estabelecimentos de saúde.

QUESTÃO 02

Para calcular o coeficiente de mortalidade infantil de um município, utilizam-se dados dos sistemas:

(A) SINAN e SIH.
(B) SIM e SINASC.
(C) SIA e CNES.
(D) SI-PNI e SISVAN.
(E) SISAB e Notivisa.

✔️ **GABARITO: B**

Comentário:

A) Incorreta – SINAN e SIH não fornecem óbitos e nascimentos de forma completa.

B) Correta – o numerador (óbitos de menores de 1 ano) vem do SIM e o denominador (nascidos vivos) do SINASC.

C) Incorreta – são sistemas de produção ambulatorial e cadastro.

D) Incorreta – são sistemas de vacinação e nutrição.

E) Incorreta – são sistemas da atenção básica e de vigilância sanitária.

QUESTÃO 03

O sistema que substituiu o SIAB e recebe os dados da atenção primária coletados por meio da estratégia e-SUS APS é o:

(A) SISAB.
(B) SIM.
(C) SINASC.
(D) SIA.
(E) GAL.

✔️ **GABARITO: A**

Comentário:

A) Correta – o SISAB recebe os dados do e-SUS APS (CDS e PEC), de forma individualizada.

B) Incorreta – o SIM registra óbitos.

C) Incorreta – o SINASC registra nascimentos.

D) Incorreta – o SIA registra a produção ambulatorial para faturamento.

E) Incorreta – o GAL gerencia exames laboratoriais de saúde pública.

QUESTÃO 04

A Autorização de Internação Hospitalar (AIH) é o documento-base do:

(A) SINAN.
(B) SIH/SUS.
(C) SIA/SUS.
(D) SI-PNI.
(E) SISCAN.

✔️ **GABARITO: B**

Comentário:

A) Incorreta – o SINAN trabalha com fichas de notificação.

B) Correta – a AIH alimenta o Sistema de Informações Hospitalares.

C) Incorreta – o SIA usa BPA e APAC.

D) Incorreta – o SI-PNI registra a vacinação.

E) Incorreta – o SISCAN registra exames de rastreamento do câncer.

QUESTÃO 05

De acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018), os dados referentes à saúde do paciente são classificados como:

(A) dados públicos, de livre divulgação.
(B) dados anonimizados por natureza.

(C) dados pessoais sensíveis.
(D) dados irrelevantes para a proteção legal.
(E) dados de uso exclusivo do Ministério da Saúde.

✔️ **GABARITO: C**

Comentário:

A) Incorreta – dados de saúde não são de livre divulgação.

B) Incorreta – a anonimização é um processo, não uma característica natural do dado.

C) Correta – a LGPD considera dados de saúde como dados pessoais sensíveis.

D) Incorreta – esses dados têm proteção especial.

E) Incorreta – são tratados por diversos serviços, sempre com as garantias legais.

5. REVISÃO DO CAPÍTULO

Resumo em tópicos: conceito de SIS, dado, informação e indicador; DATASUS; SIM, SINASC, SINAN, SIH, SIA, SI-PNI, SISVAN, SISAB/e-SUS, CNES, SISCAN, GAL, Notivisa; CNS e RNDS; indicadores; papel da enfermagem; LGPD.

Quadro-resumo: DO → SIM; DNV → SINASC; ficha de notificação → SINAN; AIH → SIH; BPA/APAC → SIA; mortalidade infantil × 1.000 NV; materna × 100.000 NV.

Pegadinhas: SIAB como sistema vigente; confundir SIH com SIA; achar que a DO pode ser preenchida pela enfermagem.

Erros comuns: inverter numerador e denominador da mortalidade infantil; confundir SINAN com SINASC.

ASSUNTO 20 – ÉTICA NO SERVIÇO PÚBLICO, SIGILO PROFISSIONAL, RELAÇÕES INTERPESSOAIS E ATENDIMENTO AO USUÁRIO

1. RESUMO TEÓRICO

20.1 Ética e moral

Ética é a reflexão filosófica sobre os valores e as normas que orientam o comportamento humano; tem caráter universal e teórico. **Moral** é o conjunto de normas e costumes de determinado grupo social, em determinada época; tem caráter prático e cultural. **Bioética** estuda os problemas éticos ligados à vida e à saúde, com quatro princípios clássicos (Beauchamp e Childress): **autonomia** (respeito às decisões do paciente – consentimento livre e esclarecido), **beneficência** (fazer o bem), **não maleficência** (não causar dano – *primum non nocere*) e **justiça** (equidade na distribuição dos recursos).

20.2 Ética no serviço público

Princípios da Administração Pública (art. 37 da Constituição Federal) – **LIMPE**: **L**egalidade, **I**mpessoalidade, **M**oralidade, **P**ublicidade e **E**ficiência.

O **Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal (Decreto nº 1.171/1994)**, referência frequente em provas, estabelece:

- **Regras deontológicas:** a dignidade, o decoro, o zelo, a eficácia e a consciência dos princípios morais são primados maiores do servidor; o servidor não pode omitir ou falsear a verdade; a cortesia, a boa vontade e a harmonia com a estrutura organizacional são essenciais; deixar o cidadão esperando em filas ou atrasar a prestação do serviço caracteriza **atitude contra a ética** e dano moral ao usuário; a **publicidade** de qualquer ato administrativo é requisito de eficácia e moralidade (salvo os casos de sigilo, como segurança nacional e investigações).
- **Deveres:** desempenhar com rapidez e eficiência as atribuições; ser probo, reto, leal e justo; tratar cuidadosamente os usuários; ser **assíduo e frequente**; comunicar imediatamente aos superiores atos contrários ao interesse público; manter limpo e em ordem o local de trabalho; apresentar-se ao trabalho com vestimentas adequadas.
- **Vedações:** usar o cargo para obter favorecimento; prejudicar deliberadamente a reputação de colegas ou cidadãos; ser conivente com erro ou infração; usar artifícios para procrastinar o atendimento; **receber presente, gratificação ou vantagem** de qualquer espécie para o cumprimento da função; alterar ou deturpar documentos; desviar servidor para atendimento particular; retirar documentos da repartição sem autorização.
- **Comissão de Ética:** em cada órgão; a **pena aplicável é a de censura**, fundamentada por escrito e assinada pelos integrantes.

No âmbito estadual, o servidor da SES-TO também está sujeito ao **Estatuto dos Servidores Públicos do Estado do Tocantins (Lei estadual nº 1.818/2007)**, que trata de deveres, proibições e penalidades disciplinares (advertência, suspensão, demissão, cassação de aposentadoria, destituição de cargo em comissão).

Improbidade administrativa (Lei nº 8.429/1992, alterada pela Lei nº 14.230/2021): atos que importam **enriquecimento ilícito**, causam **prejuízo ao erário** ou **atentam contra os princípios** da administração; após 2021, exige-se **dolo** para a configuração.

20.3 Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (CEPE)

Aprovado pela **Resolução COFEN nº 564/2017**. Organizado em **direitos, deveres, proibições e infrações e penalidades**.

Penalidades (aplicadas pelos Conselhos Regionais e Federal, em ordem crescente de gravidade): **advertência verbal, multa, censura, suspensão do exercício profissional** (até 90 dias) e **cassação do direito ao exercício profissional** (até 30 anos). A cassação é de competência do **COFEN**, mediante proposta do COREN.

Pontos de destaque do CEPE:

- **Direito** de recusar-se a desenvolver atividades sem condições mínimas de segurança, comunicando o fato formalmente; de suspender as atividades quando a instituição não oferecer condições dignas de trabalho (exceto em urgência e emergência).
- **Dever** de prestar assistência sem discriminação de qualquer natureza; de respeitar o direito do paciente de decidir sobre sua pessoa e seu tratamento; de registrar no prontuário as informações inerentes ao cuidado.
- **Proibido:** executar atividades que não sejam de sua competência técnica, científica, ética e legal; **administrar medicamentos sem conhecer a indicação, ação, via, dose e possíveis riscos**; prescrever medicamentos (exceto nos programas de saúde pública e rotinas aprovadas, no caso do enfermeiro); assinar ações de enfermagem que não executou; promover ou participar de prática destinada a antecipar a morte da pessoa (**eutanásia**); provocar aborto ou cooperar em prática destinada a interromper a gestação, **exceto nos casos permitidos pela legislação vigente**; registrar informações incompletas, imprecisas ou inverídicas.

20.4 Sigilo profissional

O CEPE determina o dever de **manter sigilo sobre fato de que tenha conhecimento em razão da atividade profissional**, **exceto** nos casos previstos em lei, ordem judicial ou com o **consentimento escrito** da pessoa envolvida ou de seu representante legal. O sigilo deve ser mantido **mesmo que o fato seja de conhecimento público** e em caso de **falecimento** da pessoa envolvida. Em atividade multiprofissional, os fatos podem ser revelados **apenas quando necessários à prestação da assistência**. O profissional intimado como testemunha deve comparecer e, se for o caso, **declarar seu impedimento** de revelar o segredo.

Exceções em que a revelação é obrigatória: **notificação compulsória** de doenças e agravos, comunicação de **violência** contra crianças, adolescentes (ao Conselho Tutelar – ECA), idosos e mulheres (notificação compulsória e, em alguns casos, comunicação à autoridade policial em até 24 h – Lei nº 13.931/2019), e risco à vida de terceiros.

A **violação de segredo profissional** também é crime (art. 154 do Código Penal): revelar, sem justa causa, segredo de que tem ciência em razão de função, ministério, ofício ou profissão.

20.5 Relações interpessoais e atendimento ao usuário

Comunicação: verbal e não verbal (gestos, expressão facial, tom de voz, postura, toque, distância – proxêmica). Barreiras: uso de jargão técnico, ruído, pressa, preconceito, falta de escuta. A **escuta ativa** e a **empatia** (colocar-se no lugar do outro, compreendendo seus sentimentos sem julgá-los) são fundamentais. Simpatia (compartilhar o sentimento) é diferente de empatia.

Trabalho em equipe: respeito, cooperação, comunicação clara, resolução de conflitos com diálogo (mediação), feedback construtivo, responsabilidade compartilhada. Conflitos são inerentes às relações e devem ser enfrentados de forma ética, sem exposição dos colegas diante de pacientes.

Atendimento ao usuário: cordialidade, identificação do profissional (crachá com nome e função), chamar o paciente pelo **nome** (inclusive pelo **nome social** – Decreto nº 8.727/2016 e Portaria nº 1.820/2009), linguagem clara, respeito à privacidade (biombos, portas fechadas), escuta das queixas, orientação sobre os fluxos, prioridade legal de atendimento (**Lei nº 10.048/2000**: pessoas com deficiência, idosos com 60 anos ou mais, gestantes, lactantes, pessoas com crianças de colo, obesos, pessoas com transtorno do espectro autista – Lei 12.764/2012 –, doadores de sangue – Lei 14.626/2023 – e pessoas com mobilidade reduzida). Reclamações devem ser acolhidas e encaminhadas à **ouvidoria**.

Assédio moral: exposição repetitiva e prolongada do trabalhador a situações humilhantes e constrangedoras; deve ser denunciado. Assédio sexual é crime (art. 216-A do Código Penal).

2. PONTOS QUE MAIS CAEM EM PROVA

- Ética × moral; princípios da bioética.
- LIMPE (art. 37 da CF).
- Decreto 1.171/1994: deveres, vedações, pena de censura pela Comissão de Ética.
- Improbidade: enriquecimento ilícito, prejuízo ao erário, atentado aos princípios; exige dolo.
- CEPE (Res. COFEN 564/2017): penalidades em ordem (advertência, multa, censura, suspensão, cassação).
- Proibido administrar medicamento sem conhecer indicação, ação, via, dose e riscos.
- Sigilo: mantido mesmo após a morte e se o fato for público; exceções legais.
- Empatia × simpatia; nome social; prioridades legais de atendimento.

3. MACETES E DICAS DE MEMORIZAÇÃO

- **"LIMPE"**: Legalidade, Impessoalidade, Moralidade, Publicidade, Eficiência.
- **Bioética "A-B-N-J"**: Autonomia, Beneficência, Não maleficência, Justiça.
- **Penalidades do CEPE: "Agora Mais Calma, Sem Confusão"** – Advertência, Multa, Censura, Suspensão, Cassação.
- **"Comissão de Ética do servidor só censura"**.
- **"Segredo não morre com o paciente"**.
- **"Empatia entende, simpatia sente junto"**.

4. QUESTÕES

QUESTÃO 01

Segundo o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (Resolução COFEN nº 564/2017), as penalidades aplicáveis, em ordem crescente de gravidade, são:

(A) censura, advertência verbal, multa, cassação e suspensão.

(B) advertência verbal, multa, censura, suspensão do exercício profissional e cassação do direito ao exercício profissional.

(C) multa, suspensão, advertência, demissão e prisão.

(D) advertência escrita, demissão e exoneração.

(E) suspensão, multa e advertência.

✔️ **GABARITO: B**

Comentário:

A) Incorreta – a ordem está invertida.

B) Correta – é a ordem prevista no CEPE.

C) Incorreta – demissão e prisão não são penalidades ético-profissionais do CEPE.

D) Incorreta – demissão e exoneração são institutos administrativos, não do CEPE.

E) Incorreta – a relação está incompleta e fora de ordem.

QUESTÃO 02

Sobre o sigilo profissional, conforme o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, é correto afirmar:

(A) o sigilo deixa de existir quando o paciente falece.

(B) o fato pode ser revelado livremente quando já for de conhecimento público.

(C) o sigilo deve ser mantido mesmo que o fato seja de conhecimento público e em caso de falecimento, ressalvados os casos previstos em lei, ordem judicial ou consentimento escrito.

(D) o profissional pode comentar o caso com familiares de outros pacientes, desde que não diga o nome.

(E) a notificação compulsória de doenças viola o sigilo e é proibida.

✔️ **GABARITO: C**

Comentário:

A) Incorreta – o sigilo permanece após o falecimento.

B) Incorreta – o conhecimento público não libera o profissional do sigilo.

C) Correta – essa é a regra do CEPE, com as exceções previstas.

D) Incorreta – a revelação a terceiros sem justa causa é infração ética.

E) Incorreta – a notificação compulsória é dever legal e exceção ao sigilo.

QUESTÃO 03

São princípios expressos da Administração Pública previstos no art. 37 da Constituição Federal:

(A) legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.
(B) universalidade, integralidade e equidade.
(C) hierarquia, disciplina e lealdade.
(D) autonomia, beneficência e justiça.
(E) transversalidade, protagonismo e autonomia.

✔️ **GABARITO: A**

Comentário:

A) Correta – são os princípios do LIMPE.

B) Incorreta – são princípios do SUS.

C) Incorreta – são valores típicos das instituições militares.

D) Incorreta – são princípios da bioética.

E) Incorreta – são princípios da Política Nacional de Humanização.

QUESTÃO 04

De acordo com o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal (Decreto nº 1.171/1994), é vedado ao servidor:

(A) ser assíduo e frequente ao serviço.
(B) tratar cuidadosamente os usuários dos serviços.
(C) receber presente ou vantagem de qualquer espécie, de qualquer pessoa, para o cumprimento da sua função.
(D) comunicar aos superiores atos contrários ao interesse público.
(E) manter limpo e em ordem o local de trabalho.

✔️ **GABARITO: C**

Comentário:

A) Incorreta – a assiduidade é dever do servidor.

B) Incorreta – o cuidado no trato com os usuários é dever.

C) Correta – receber presentes ou vantagens para cumprir a função é vedação expressa.

D) Incorreta – a comunicação de irregularidades é dever.

E) Incorreta – a organização do local de trabalho é dever.

QUESTÃO 05

O técnico em enfermagem, ao atender um usuário ansioso, procura compreender os sentimentos dele, colocando-se em seu lugar, sem julgá-lo, e mantendo a postura profissional. Essa atitude caracteriza:

(A) simpatia.
(B) empatia.
(C) apatia.
(D) antipatia.
(E) transferência.

✔️ **GABARITO: B**

Comentário:

A) Incorreta – a simpatia é compartilhar o mesmo sentimento, envolvendo-se emocionalmente.

B) Correta – empatia é compreender o outro colocando-se em seu lugar, sem perder a objetividade profissional.

C) Incorreta – apatia é a falta de interesse ou de reação emocional.

D) Incorreta – antipatia é a aversão.

E) Incorreta – transferência é conceito da psicanálise, relativo à projeção de afetos.

5. REVISÃO DO CAPÍTULO

Resumo em tópicos: ética, moral e bioética; LIMPE; Decreto 1.171/1994; Estatuto do Servidor do Tocantins; improbidade; CEPE (Res. 564/2017) – direitos, deveres, proibições e penalidades; sigilo e suas exceções; comunicação, empatia, trabalho em equipe; atendimento ao usuário, nome social e prioridades legais.

Quadro-resumo: LIMPE; penalidades do CEPE: advertência → multa → censura → suspensão → cassação; Comissão de Ética do servidor: censura; sigilo permanece após a morte.

Pegadinhas: achar que fato público libera o sigilo; confundir empatia com simpatia; incluir demissão entre as penalidades do CEPE; trocar princípios do SUS pelos da Administração.

Erros comuns: inverter a ordem das penalidades; achar que a notificação compulsória viola o sigilo.